Optimal Untuk Negeri

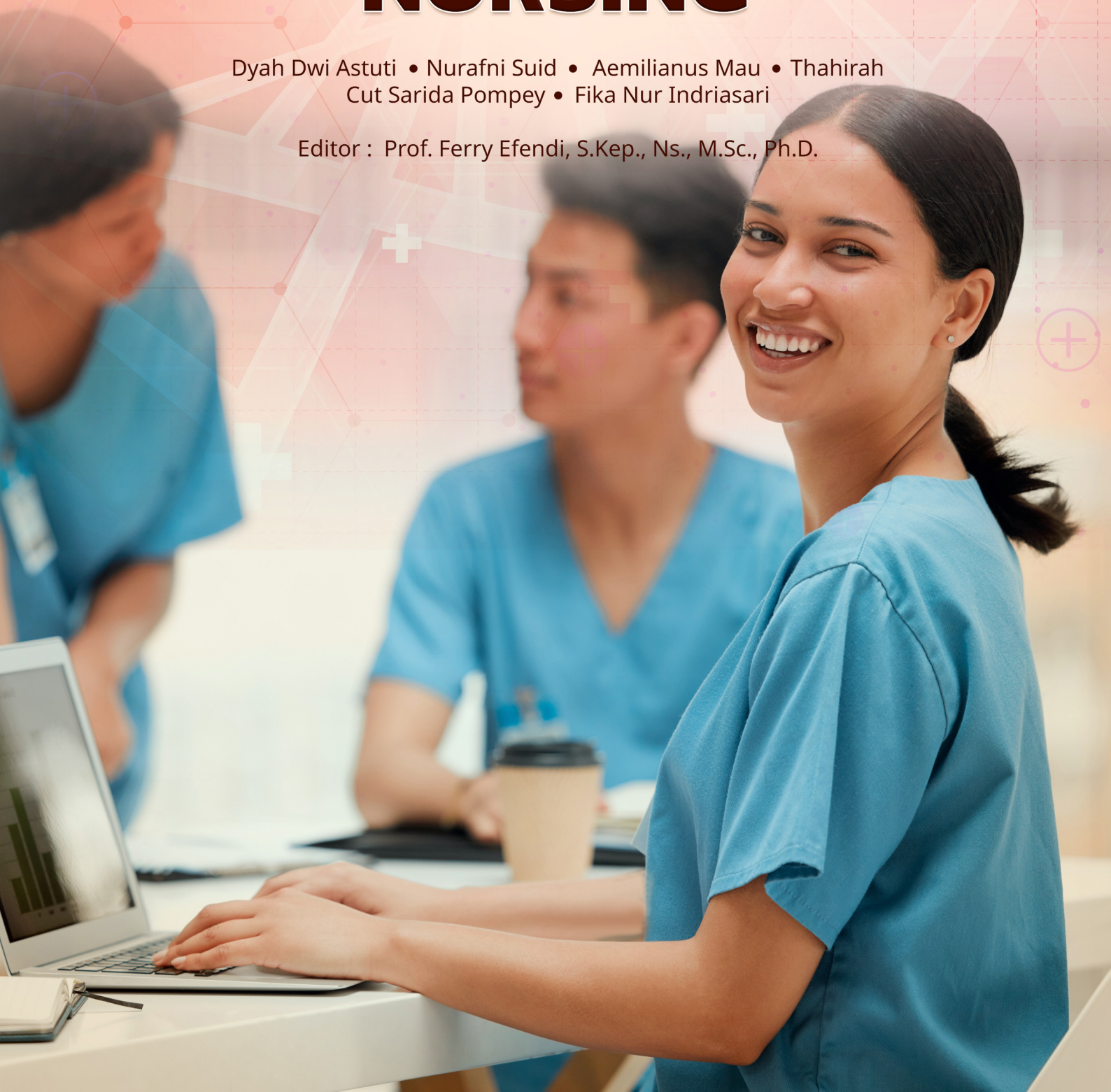
optimal

Buku Ajar

RISET KEPERAWATAN DAN EVIDENCE-BASED NURSING

Dyah Dwi Astuti • Nurafni Suid • Aemilianus Mau • Thahirah
Cut Sarida Pompey • Fika Nur Indriasari

Editor : Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



Buku Ajar :
Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing

Penulis:

Dr. Dyah Dwi Astuti, M. Kep., Ns. Sp. Kep. An
Ns. Nurafni Suid,. S.Tr., Kep., M., Tr.Kep
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.
Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Cut Sarida Pompey, S.Kep., M.N.S.
Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Editor : Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:
Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing

Penulis:
Dr. Dyah Dwi Astuti, M. Kep., Ns. Sp. Kep. An
Ns. Nurafni Suid,. S.Tr., Kep., M., Tr.Kep
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.
Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Cut Sarida Pompey, S.Kep., M.N.S.
Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Editor :
Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-01-9

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul **"Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing"** ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar riset, proses penelitian, pengelolaan data, penilaian bukti ilmiah, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menuntut tenaga keperawatan untuk memiliki kemampuan berpikir ilmiah, kritis, sistematis, dan berbasis bukti. Dalam praktik keperawatan, setiap keputusan klinis tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi perlu didukung oleh hasil penelitian terbaik, keahlian klinis, kondisi pasien, serta nilai dan preferensi pasien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing* menjadi bagian penting dalam membentuk calon perawat yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan asuhan keperawatan yang bermutu.

Buku ajar ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami tahapan penting dalam riset keperawatan, mulai dari penyusunan instrumen penelitian dan pengukuran, prosedur pengumpulan data, manajemen data, hingga analisis data kuantitatif dasar. Selain itu, buku ini juga membahas pentingnya kemampuan melakukan *critical appraisal*, memahami hirarki bukti, menerapkan *Evidence-Based Nursing* dalam praktik keperawatan, serta menyusun proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah akademik.

Materi dalam buku ajar ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan akademik dan profesional. Melalui pembahasan yang terarah, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana suatu masalah keperawatan dapat dikaji secara ilmiah, bagaimana data penelitian dikumpulkan dan dianalisis, serta bagaimana hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keperawatan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih aktif, kritis, dan aplikatif.

Penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, pembimbing akademik, peneliti pemula, serta praktisi keperawatan yang ingin memperkuat pemahaman mengenai riset dan praktik keperawatan berbasis bukti. Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya ilmiah di lingkungan pendidikan keperawatan, sehingga

mahasiswa terbiasa membaca, menilai, dan memanfaatkan hasil penelitian secara tepat dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang ilmiah, profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 INSTRUMEN PENELITIAN DAN PENGUKURAN **1**
A. Pendahuluan 5
B. Konsep Instrumen Penelitian 5
C. Prosedur Pengumpulan Data 8
D. Perbandingan Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 10
E. Penyusunan Instrumen Sesuai Konstruk Dan Skala Ukur Untuk Menghasilkan Data Yang Valid. 11
F. Uji Coba Instrumen Penelitian 12
Referensi **20**

BAB 2 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN MANAJEMEN DATA **22**
A. Pendahuluan 26
B. Klasifikasi Data dalam Keperawatan 27
C. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif 28
D. Metode Pengumpulan Data Kualitatif 35
E. Manajemen Data Penelitian 40
F. Format penjelasan penelitian 42
G. Ringkasan Bab 43
Referensi **50**

BAB 3 ANALISIS DATA KUANTITATIF DASAR **51**
A. Pendahuluan 55
B. Tujuan Pembelajaran 56
C. Konsep Dasar Analisis Data Kuantitatif dalam keperawatan 56
D. Kesimpulan 59
Referensi **61**

BAB 4 CRITICAL APPRAISAL DAN HIRARKI BUKTI 62
A. Pendahuluan 66
B. Apakah Critical Appraisal itu? 66
C. Mengapa Melakukan Critical Appraisal? 67
D. Bagaimana Melakukan Critical Appraisal? 68
E. RINGKASAN 87
Referensi 93

BAB 5 IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED NURSING DI PRAKTIK 96
A. Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti. 102
B. Merancang rencana implementasi EBN (stakeholder, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur 117
C. Rangkuman 128
D. Latihan Soal 132
Referensi 138

BAB 6 PENYUSUNAN PROPOSAL, SKRIPSI, DAN PUBLIKASI ILMIAH 140
A. Konsep Dasar Riset Keperawatan 148
B. Penyusunan proposal penelitian keperawatan 151
C. Penyusunan skripsi keperawatan 156
D. Teknik penulisan ilmiah 160
E. Publikasi ilmiah dalam keperawatan 164
F. Etika penelitian dan publikasi ilmiah 168
G. Rangkuman Materi 196
Glosarium 200
Referensi 202

Profil Penulis 204

BAB 1

INSTRUMEN PENELITIAN DAN PENGUKURAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Instrumen Penelitian dan Pengukuran	1.1 Memilih/menyusun instrumen sesuai konstruk dan skala ukur untuk menghasilkan data yang valid.	1.2 Menyusun rencana uji validitas–reliabilitas (atau trustworthiness untuk instrumen kualitatif) termasuk uji coba/pilot.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Ujian/penugasan rancangan metode (protocol brief)	Kesesuaian desain dengan pertanyaan dan ketepatan rencana sampling/ukuran sampel (skor rubrik).	15	Protocol brief metode
CPMK-5	Penugasan instrumen + SOP pengumpulan/manajemen data	Kesesuaian instrumen–skala ukur dan kelengkapan SOP/manajemen data (checklist/rubrik).	15	Draft instrumen; SOP; data dictionary
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan identifikasi isu	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik pada skenario				

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

A. Pendahuluan

Keberhasilan sebuah penelitian ilmiah tidak hanya ditentukan oleh ketajaman teoretis atau kematangan desain yang dirancang di atas kertas, melainkan oleh kekuatan fondasi empirisnya di lapangan. Dalam struktur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-3), seorang akademisi dan peneliti dituntut untuk tidak hanya mampu merancang metode penelitian secara konseptual, tetapi juga menguasai aspek eksekusi prosedural secara sistematis—mulai dari penetapan batas populasi, perhitungan sampel, pemilihan teknik sampling, hingga finalisasi instrumen pengumpul data. Bab ini hadir sebagai perwujudan taktis dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK-5), yang berfokus pada fase krusial dalam metodologi penelitian: rekonstruksi alat ukur, mekanisasi pengumpulan data di lapangan, serta tata kelola manajemen data modern.

Secara komprehensif, bab ini akan membahas empat pilar utama yang saling mengunci keabsahan sebuah riset. Pertama, pembahasan akan diawali dengan metodologi penyusunan instrumen penelitian, baik untuk pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, guna memastikan bahwa alat ukur yang dikembangkan memiliki validitas (ketepatan) dan reliabilitas (keajekan) yang memadai. Kedua, pembaca akan dituntun untuk menyusun rencana pengukuran yang presisi, termasuk operasionalisasi variabel dan penentuan sistem skoring yang objektif. Ketiga, bab ini mengupas tuntas teknik dan prosedur pengumpulan data di area klinis maupun komunitas, dengan menekankan pada keterampilan komunikasi terapeutik dan etika pengkajian guna meminimalkan bias informasi. Keempat, bagian akhir bab ini akan mengulas secara mendalam mengenai manajemen data pasca-pengumpulan, yang mencakup jaminan keamanan data (data security), perlindungan kerahasiaan identitas subjek (data confidentiality), serta pengendalian kualitas data (data quality) agar seluruh proses penanganan data memiliki rekam jejak yang transparan, valid, dan sepenuhnya dapat diaudit (auditable).

Melalui pemahaman yang utuh terhadap materi di dalam bab ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengumpulkan data mentah secara mekanis, melainkan memiliki penalaran klinis dan metodologis (clinical and methodological reasoning) dalam mengelola data penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional yang akuntabel dan sahih secara ilmiah.

B. Konsep Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan sebuah alat pengukuran yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mempermudah dalam mengumpulkan data penelitian. Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa untuk memperoleh data seorang peneliti harus

menggunakan alat atau instrumen yang dapat menunjang dalam memperoleh data dari permasalahan yang akan diteliti dan untuk menentukan jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen penelitian adalah alat bantu (seperti kuesioner, tes, atau pedoman wawancara) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis, objektif, dan akurat (Ultavia, 2023).

Instrumen penelitian menurut Ibnu Hajar (dalam Hardani dkk, 2020) adalah "alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif". Sehingga diperlukan teknik pengembangan skala atau alat ukur untuk mengukur variabel dalam pengumpulan data yang lebih sistematis.

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih sistematis serta mudah diolah. Secara sederhana, instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk merekam informasi dari responden atau objek penelitian (Gede Subhaktiyasa, 2024).

Jenis instrumen utama meliputi kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan tes, yang dipilih berdasarkan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk memastikan data valid dan reliabel. Instrumen harus valid dan reliabel (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024):

1. Kuesioner/Angket

   Alat pengumpul data tertulis yang berisi pertanyaan/pernyataan terstruktur, sering menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap atau pendapat. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun sistematis untuk dijawab oleh responden. Metode ini efisien untuk mendapatkan data kuantitatif/kualitatif dari banyak responden, mencakup data sikap, pendapat, perilaku, dan karakteristik.

2. Wawancara (*Interview)*

   Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung, bisa terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk mendalami persepsi atau pengalaman. Instrumen wawancara penelitian adalah alat bantu, biasanya berupa panduan wawancara (interview guide), yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang disusun peneliti untuk mengumpulkan data verbal yang mendalam dari responden. Instrumen ini krusial untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan, terstruktur, dan sesuai tujuan penelitian

3. Observasi (Pengamatan)

   Pengamatan langsung terhadap fenomena, perilaku, atau peristiwa. Dapat terstruktur (menggunakan ceklis/skala) atau tidak terstruktur. Instrumen

observasi penelitian adalah alat bantu sistematis berupa panduan, daftar periksa (checklist), atau skala penilaian (*rating scale)* yang digunakan peneliti untuk merekam, mencatat, dan mengukur data perilaku, objek, atau situasi secara langsung di lapangan. Instrumen ini mengubah pengamatan menjadi data objektif.

4. Tes (Tes Hasil Belajar/Kognitif):
   Alat untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau bakat subjek, sering diukur menggunakan taksonomi kognitif (misal: C2, C3).
5. Studi Dokumentasi
   Analisis terhadap dokumen tertulis, gambar, atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen studi dokumentasi penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data berbentuk dokumen, seperti buku, arsip, laporan, foto, atau video, guna menjawab masalah penelitian. Instrumen ini memastikan pengumpulan data sistematis, relevan, dan valid.
6. Skala Pengukuran (*Rating Scale)*
   Instrumen yang memberikan nilai pada jawaban responden, seperti skala ordinal untuk mengukur tingkat persetujuan

Penyusunan instrumen penelitian sebaiknya mengikuti tahapan-tahapan tertentu agar memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Menurut penelitian Triyogo (2014), tahap-tahap penyusunan instrumen dilakukan disesuaikan dengan penelitian ini adalah dengan cara berikut (Jannah et al., 2025):

1. Perencanaan
   Tahap perencanaan merupakan fondasi konseptual krusial yang mengawali seluruh proses penyusunan instrumen penelitian, di mana peneliti secara sistematis merumuskan tujuan pengukuran serta melakukan operasionalisasi variabel. Pada fase awal ini, konsep-konsep teoretis yang masih bersifat abstrak dan makro diurai ke dalam subvariabel atau dimensi yang lebih spesifik, untuk kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator empiris yang dapat diamati secara nyata di lapangan. Keberhasilan tahap perencanaan ini sangat menentukan ketepatan instrumen dalam membingkai parameter penelitian, sehingga alat ukur yang dikembangkan nantinya benar-benar selaras dengan arah hipotesis dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.
2. Menyusun tabel persiapan pembuatan instrumen (kisi - kisi instrumen penelitian).
   Setelah indikator penelitian berhasil dirumuskan, langkah berikutnya adalah menyusun tabel persiapan pembuatan instrumen atau yang dikenal sebagai kisi-kisi instrumen penelitian (blue-print). Matriks kisi-kisi ini berfungsi sebagai peta

jalan pembimbing (guideline) yang memetakan keterkaitan logis antara variabel, dimensi, indikator, hingga sebaran nomor butir pertanyaan atau pernyataan, termasuk pembagian antara item positif (favorable) dan negatif (unfavorable). Melalui penyusunan kisi-kisi yang terstruktur, peneliti dapat menjamin representativitas konten secara proporsional, memastikan tidak ada indikator penting yang terlewatkan, serta menjaga agar jumlah butir soal tidak menumpuk hanya pada satu dimensi tertentu demi menjaga keseimbangan bobot instrumen.

3. Penulisan butir pertanyaan angket dan tes yang menyesuaikan indikator instrumen penelitian.

   Tahap penulisan butir pertanyaan angket atau tes dilakukan dengan mengonversi setiap indikator yang tertuang dalam kisi-kisi menjadi kalimat-kalimat konkret yang siap disajikan kepada responden. Dalam proses penulisan ini, peneliti wajib menerapkan kaidah kebahasaan yang jelas, lugas, mudah dipahami oleh karakteristik populasi target, serta secara ketat menghindari penggunaan kalimat ganda (double-barreled) yang dapat membingungkan responden dalam memberikan jawaban. Kejelian peneliti dalam memilih diksi dan menyusun struktur kalimat pada tahap ini memegang peran vital untuk meminimalkan bias interpretasi, sehingga setiap data atau respons yang diberikan oleh subjek penelitian murni mencerminkan kondisi objektif dari apa yang sedang diukur.

4. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan.

   Proses penyusunan ini diakhiri dengan tahap penyuntingan dan penentuan skor item sebagai langkah finalisasi draf instrumen sebelum dilakukan pengujian validitas tingkat lanjut di lapangan. Penyuntingan tidak hanya berfokus pada perbaikan tata bahasa dan ejaan, melainkan juga melengkapi instrumen dengan pedoman pengerjaan yang jelas, ringkas, dan etis guna memandu responden selama proses pengisian secara mandiri.

5. Penentuan skor item.

   Bersamaan dengan itu, penentuan sistem skoring—seperti penetapan bobot nilai pada Skala Likert untuk angket sikap atau skor biner untuk instrumen tesharus dirumuskan secara tegas dan konsisten agar transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif dapat dihitung secara statistik secara akurat.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian merupakan langkah sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah. Secara umum, prosedur ini melibatkan persiapan instrumen hingga pelaksanaan di

lapangan. Berikut adalah tahapan umum yang dilakukan dalam penelitian (Aisyah & Sumo, 2025):

1. Identifikasi Kebutuhan Data
   Menentukan jenis data yang diperlukan (primer atau sekunder) berdasarkan tujuan penelitian.
2. Penyusunan Instrumen
   Membuat alat pengumpul data seperti pedoman wawancara, kuesioner/angket, atau lembar observasi yang valid dan reliabel.
3. Penentuan Sumber Data (Populasi & Sampel)
   Menentukan siapa atau apa yang akan menjadi subjek penelitian.
4. Pelaksanaan Pengumpulan Data
   Turun ke lapangan untuk mengambil data menggunakan teknik yang telah dipilih (misalnya melakukan wawancara atau menyebar angket).
5. Pengecekan Keabsahan Data
   Melakukan verifikasi data, misalnya melalui teknik triangulasi (menggabungkan berbagai sumber/metode) atau member check (mengonfirmasi kembali data kepada responden).

Robert Donmoyer dalam (Nurwahdini Hutasuhut & Meyniar Albina, 2025) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan sebuah pendekatan terhadap kajian empiris yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis serta menampilkan data dalam bentuk numerik. Metode penelitian kuantitatif termasuk pendekatan dalam metode psikologi yang mengetes terhadap teori melalui studi dalam hubungan variabel tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yang paling banyak dilakukan ialah riset psikologi di Indonesia yaitu menggunakan survei dan eksperimen. Metode penelitian kuantitatif menekankan penelitian yang meliputi angka - angka dalam teknik pengumpulan datanya di lapangan. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data kuantitatif, dengan cenderung lebih memperhatikan generalisasi dan metode pengumpulan datanya menggunakan instrumen kuesioner / angket, observasi terstruktur, eksperimen dan studi survei.

Kualitas sebuah penelitian ditentukan dari teknik pengumpulan datanya karena teknik yang tepat menentukan valid tidaknya suatu data yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data bisa dimaknai dengan prosedural komponen sistematis yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain menggunakan survei dan eksperimen, teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana yang digunakan dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Namun letak perbedaannya ada dalam prosedurnya, jika dalam penelitian kuantitatif maka

teknik wawancara dilakukan dengan menyusun format secara terstruktur dan berfokus pada pertanyaan yang dapat dijawab dengan angka. Observasi dalam penelitian kuantitatif dilakukan secara terstruktur, peneliti mengamati fenomena menggunakan kriteria yang jelas dan berurutan. Data yang dikumpulkan berupa frekuensi,, durasi serta kategori tertentu yang kemudian dianalisis secara statistik. Serta terdapat dokumentasi dalam pengumpulan data kuantitatif dimana teknik ini merujuk pada pengumpulan data dari rekaman atau foto dari sumber tertulis yang ada, misalnya: laporan, statistik dan arsip, tentunya dari adanya sumber dokumentasi tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang valid serta bisa mendukung terhadap temuan penelitian (Salmia, 2023).

D. Perbandingan Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif

Menurut Nur et al., (2026) persamaan teknik pengumpulan data, meskipun penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam kedua jenis penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif antara lain :

1. Wawancara digunakan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan data berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka,
2. Observasi juga dapat digunakan dalam kedua jenis penelitian. Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati.

Teori lainnya tentang perbedaan Teknik Pengumpulan Data dikemukakan oleh (Berlianti et al., 2024), yang menjelaskan bahwa terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan secara umum dalam kedua jenis penelitian, terdapat perbedaan penting dalam pendekatan dan fokus pengumpulan data antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa perbedaan teknik pengumpulan data antara keduanya meliputi

1. Penekanan pada subjek penelitian

   Penelitian kualitatif cenderung lebih mendalam dan menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Sementara itu, penelitian kuantitatif cenderung lebih memperhatikan generalisasi data dan analisis statistik,
2. Metode pengumpulan data yang digunakan

   Selain teknik pengumpulan data yang umum digunakan, penelitian kualitatif juga menggunakan teknik khusus seperti studi dokumentasi, studi kasus, dan

fokus grup. Di sisi lain, penelitian kuantitatif lebih sering menggunakan instrumen kuesioner atau angket, observasi terstruktur, eksperimen, dan studi survei. Persamaan Instrumen Penelitian, Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif juga memiliki beberapa persamaan.

Beberapa perbedaan instrumen penelitian antara penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi (Mauizdati et al., 2024) :

1. Instrumen pengukuran dalam eksperimen lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Instrumen ini mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang terlibat dalam eksperimen,
2. Pedoman Wawancara: Pedoman wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan responden. Instrumen ini membantu memastikan topik-topik yang relevan dibahas dalam wawancara, (Creswell, 2014).

E. Penyusunan Instrumen Sesuai Konstruk Dan Skala Ukur Untuk Menghasilkan Data Yang Valid.

Penyusunan instrumen yang valid memerlukan analisis konstruk teoritis, penjabaran menjadi indikator, dan pemilihan skala ukur (nominal, ordinal, interval, rasio) yang tepat. Instrumen disusun dengan membuat kisi-kisi, merumuskan butir soal/pernyataan, dan melakukan uji coba (pilot test) untuk menguji validitas dan reliabilitas, guna memastikan data yang dihasilkan akurat. Berikut adalah langkah-langkah sistematis menyusun instrumen penelitian (Muhammad et al., 2024):

1. Analisis Konstruk Teoritis: Menjabarkan variabel menjadi sub-variabel dan indikator berdasarkan teori yang kuat, memastikan setiap aspek yang akan diukur terwakili.
2. Menyusun Kisi-Kisi Instrumen: Membuat tabel spesifikasi yang memuat konstruk, indikator, dan jumlah butir soal, untuk menjamin validitas isi (content validity).
3. Menetapkan Skala Ukur:
   a. Nominal

      Skala nominal adalah skala pengukuran terendah yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan data ke dalam label, kelompok, atau atribut yang berbeda tanpa adanya urutan, peringkat, atau jarak antar kategori. Angka pada data nominal hanya berfungsi sebagai label/kode (contoh: 1 untuk pria, 2 untuk wanita) dan tidak memiliki nilai matematis. Kategori (contoh: jenis kelamin).

b. Ordinal

Skala ordinal adalah jenis skala pengukuran instrumen penelitian yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengurutkan data berdasarkan peringkat atau tingkatan tertentu, namun jarak antar peringkat tidak diketahui atau tidak sama. Data ini bersifat kualitatif yang diurutkan (ranking) dan sering digunakan untuk mengukur variabel subjektif. Peringkat/Urutan (contoh: tingkat pendidikan).

c. Interval

Skala interval dalam instrumen penelitian adalah skala pengukuran yang mengurutkan data, memiliki jarak (interval) yang konsisten dan setara antar nilai, serta memungkinkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Skala ini tidak memiliki nol mutlak (nol bukan berarti "tidak ada"), contohnya suhu Celsius. Jarak, tidak ada nol mutlak (contoh: Suhu, Skala Likert).

d. Rasio

Skala rasio adalah tingkat pengukuran data tertinggi dan paling informatif dalam penelitian kuantitatif, yang memiliki karakteristik interval sama, urutan, serta nilai nol mutlak (absolut). Nol mutlak berarti angka "0" benar-benar menunjukkan ketiadaan atribut yang diukur, memungkinkan operasi hitung perkalian/pembagian. Jarak, ada nol mutlak (contoh: berat badan).

e. Penyusunan Butir Instrumen: Merumuskan pertanyaan/pernyataan yang jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan indikator.

1) Uji Coba Instrumen (*Pilot Test):* Uji coba pada sampel kecil untuk mengukur validitas (apakah alat ukur sesuai) dan reliabilitas (konsistensi).
2) Evaluasi dan Revisi: Menghapus atau memperbaiki butir yang tidak valid berdasarkan hasil uji coba.

F. Uji Coba Instrumen Penelitian

Uji coba instrumen adalah prosedur pengujian alat ukur penelitian (kuesioner/tes) pada skala kecil untuk memastikan kualitas, validitas (kesahihan), dan reliabilitas (keandalan) data sebelum digunakan dalam penelitian sesungguhnya. Tujuannya adalah mendeteksi kelemahan, memperbaiki item, serta memastikan responden memahami pertanyaan (Permatasari et al., 2025).

Uji coba instrumen penelitian kuantitatif bertujuan memastikan validitas (ketepatan) dan reliabilitas (konsistensi) kuesioner atau alat ukur sebelum penelitian sebenarnya. Langkah ini melibatkan penyebaran ke responden terbatas untuk

menguji korelasi skor butir dengan total (Validitas) dan stabilitas jawaban (*Cronbach's Alpha)* (Elpisisilia, 2024).

1. Uji Validitas

   Uji validitas adalah proses pengujian statistik untuk mengukur ketepatan, kesahihan, dan keakuratan suatu instrumen (seperti kuesioner) dalam menjalankan fungsinya, memastikan alat ukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Tujuannya adalah memastikan data yang diperoleh sah, relevan, dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Umumnya menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment* membandingkan dengan validitas butir/konstruk).

   Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan pertanyaan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner, dalam mengukur variabel. Kuesioner dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan nilai variabel yang diteliti. Dalam pelaksanaan pengujian validitas perlu diketahui langkah-langkah yang akan digunakan, seperti menurut Indrawan & Yuniawati (2014) langkah kerja yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen adalah menghitung koefisien validitas dengan menggunakan koefisien korelasi product moment untuk setiap butir dan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Jika r hitung > atau = r tabel maka butir dinyatakan valid. Jika r hitung < r tabel maka butir dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

   Uji reliabilitas adalah prosedur statistik untuk mengukur konsistensi, keterandalan, dan stabilitas instrumen penelitian (kuesioner) saat digunakan berulang kali. Instrumen dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Sinonimnya meliputi uji keajegan, keterandalan, konsistensi internal, atau stabilitas pengukuran. *Cronbach's Alpha* merupakan Metode paling umum untuk mengukur konsistensi internal kuesioner (Ardiansyah et al., 2023).

   Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan instrumen. Pengukuran yang handal diartikan pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. instrumen yang reliabel akan menghasilkan hasil yang sama pada saat mengukur objek yang sama (Sugiyono, 2019).

   Sedangkan pada Uji coba instrumen penelitian kualitatif bertujuan memastikan panduan wawancara, observasi, atau dokumen dapat menggali data secara mendalam, valid, dan reliabel. Uji coba dilakukan melalui studi pendahuluan (pilot study) pada sampel terbatas yang memiliki karakteristik sama dengan subjek penelitian, namun di luar lokasi utama, untuk memperbaiki struktur pertanyaan. Berikut jenis uji coba instrumen penelitian kualitatif meliputi (Gede Subhaktiyasa, 2024) :

a. Pilot Study/Pilot Project

Pilot Study/Pilot Project bertujuan untuk Menguji keterbacaan, durasi pengerjaan, dan apakah responden memahami instruksi serta pertanyaan. Dimana sampel yang dibutuhkan sejumlah 5-10 orang yang memiliki karakteristik sama dengan populasi target, kemudian hasil uji berupa masukan langsung untuk revisi kalimat yang membingungkan atau instruksi yang kurang jelas.

b. Expert Judgment (Pertimbangan Ahli)

Memastikan validitas isi, yaitu apakah item-item instrumen sudah mencakup seluruh aspek variabel yang diteliti*.,* dilakukan oleh Dosen pembimbing, ahli topik/subjek, atau ahli metodologi, kemudian hasil berupa catatan revisi untuk memperbaiki konten, struktur pertanyaan, atau membuang item yang tidak relevan.

Trustworthiness (keabsahan) dalam penelitian kualitatif memastikan data dapat dipercaya melalui empat kriteria utama: Kredibilitas (triangulasi, member check), Transferabilitas (deskripsi rinci), Dependabilitas (audit proses), dan Konfirmabilitas. Uji coba instrumen (pilot) krusial untuk mengevaluasi panduan wawancara/observasi agar sesuai tujuan, Berikut Komponen *Trustworthiness* Kualitatif & Pilot diantaranya adalah sebagai berikut (Aisyah & Sumo, 2025) :

a. Uji Coba/Pilot Studi

Dilakukan untuk menguji panduan wawancara atau observasi pada sampel kecil yang karakteristiknya mirip dengan subjek penelitian. Ini memastikan pertanyaan dipahami, relevan, dan tidak mengarahkan bias.

b. Kredibilitas (Credibility - Validitas Internal)

1) Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data, metode (wawancara, observasi, dokumen), atau peneliti untuk memverifikasi data.
2) Member Check: Mengonfirmasi kembali hasil interpretasi wawancara kepada partisipan untuk memastikan akurasi data.
3) Perpanjangan Pengamatan: Meningkatkan waktu di lapangan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman mendalam.

c. Transferabilitas (Transferability - Validitas Eksternal)

Memberikan deskripsi mendalam (*thick description*) agar hasil penelitian dapat diterapkan oleh pembaca pada konteks lain yang serupa.

d. Dependabilitas (Dependability - Reliabilitas)

Audit menyeluruh oleh pihak luar atau dosen pembimbing terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data.

e. Konfirmabilitas (Confirmability - Objektivitas)
   Memastikan hasil penelitian didasarkan pada data lapangan, bukan bias subjektif peneliti, biasanya melalui *audit trail* (catatan harian, transkrip).

Aktivitas 1- *Knows How*

Mini-Case (Diskusi kelompok)

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi variabel kasus
2. Melakukan pencarian dan seleksi instrumen
3. Melakukan Justifikasi peneliti terkait pengambilan instrumen dari segi bahasa maupun aspek klinis
4. Melakukan rencana uji validitas dan reliabilitas maupun *pilot study*

Petunjuk Kegiatan:

1. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil
2. Setiap kelompok membaca dan menganalisis kasus yang diberikan.
3. Kelompok mendiskusikan pertanyaan yang tersedia dan menuliskan hasil diskusi.
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Mini-Case

Pilih satu fenomena klinis (misal/cth: *Kecemasan Pasien Pre-Operasi* atau *Kepatuhan Diet Pasien DM*), dan tentukan:

1. Definisi Operasional: Apa yang dimaksud dengan variabel tersebut dalam penelitian Anda?
2. Parameter: Apa saja indikator yang ingin diukur?
3. Skala data yang dihasilkan?
4. Skala Ukur yang digunakan?
5. Apakah instrumen tersebut sensitif untuk populasi target?
6. Apakah instrumen sudah dilakukan uji coba instrumen sebelumnya? Jika ya jabarkan hasilnya?

Aktivitas 2 - *Shows How*

Simulasi/Skill Penyusunan Instrumen penelitian

Setelah mengikuti kegiatan simulasi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyusun Definisi Operasional (DO) secara Tepat
   Mahasiswa mampu menerjemahkan konsep teoretis variabel penelitian ke dalam indikator empiris yang dapat diukur secara konkret.
2. Memilih Jenis Instrumen yang Relevan
   Mahasiswa mampu menentukan alat pengumpul data yang paling sesuai (misal: kuesioner, lembar observasi, atau panduan wawancara) berdasarkan desain dan tujuan penelitian.

3. Mengonstruksi Butir Pertanyaan/Pernyataan
   Mahasiswa mampu menyusun item-item instrumen yang tidak bias, mudah dipahami responden, dan mencakup seluruh dimensi variabel (uji *content validity mandiri).*
4. Menetapkan Skala Pengukuran yang Sesuai
   Mahasiswa mampu menentukan penggunaan skala (Nominal, Ordinal, Interval, atau Rasio) serta model respons (seperti Skala Likert atau Guttman) untuk setiap variabel.
5. Merancang Prosedur Uji Validitas dan Reliabilitas
   Mahasiswa mampu merencanakan uji coba instrumen (pilot study) dan memahami teknik statistik (seperti Pearson Product Moment atau Cronbach's Alpha) untuk memastikan kualitas alat ukur.

Checklist Penyusunan Instrumen Kuantitatif

Nama Mahasiswa : _____

Tanggal : _____

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan
	Identifikasi Variabel dan Konsep	☐	☐	
1.	Menetapkan variabel independen dan dependen dengan jelas	☐	☐	
2.	Mencari teori pendukung (konseptual ahli)	☐	☐	
	Definisi Operasional dan Indikator	☐	☐	
3.	Menjabarkan variabel ke dalam sub variabel	☐	☐	
4.	Menurunkan sub variabel menjadi indikator yang dapat diukur	☐	☐	
	Penyusunan Butir Instrumen	☐	☐	
5.	Membuat pertanyaan/pernyataan untuk setiap indikator.	☐	☐	
6.	Menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan tidak ambigu.			
7.	Menyusun item positif (*favorable)* dan negatif (*unfavorable)* untuk menghindari bias			
	Skala Pengukuran			
8.	Memilih skala yang sesuai (Likert 1-5, Guttman ya/tidak, Semantic Differential).			
9.	Menentukan poin skala (contoh Likert: Sangat Setuju ke Sangat Tidak Setuju).			

	Uji coba Instrumen			
9	Melakukan uji validitas	☐	☐	
10	Melakukan uji reliabilitas	☐	☐	

Keputusan Penilaian:

☐Kompeten

☐Perlusupervisi

☐ Remedial

Checklist Penyusunan Instrumen Kualitatif

Nama Mahasiswa : _____

Tanggal : _____

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan
	Fase Perencanaan dan Konseptualisasi	☐	☐	
1.	Menetapkan fokus dan tujuan penelitian secara spesifik.	☐	☐	
2.	Menyusun kisi-kisi instrumen (menjabarkan fokus penelitian menjadi indikator/sub-variabel).	☐	☐	
3.	Memastikan instrumen relevan untuk menjawab rumusan masalah.			
4.	Menentukan jenis instrumen (wawancara mendalam, observasi, FGD, atau studi dokumen).			
	Fase Penyusunan Pertanyaan/Item	☐	☐	
5	Pertanyaan bersifat terbuka (open-ended) untuk mendorong jawaban deskriptif.	☐	☐	
6.	Menghindari pertanyaan yang mengarahkan (leading questions).			
7.	Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai konteks budaya informan.			
8.	Menyusun probe questions (pertanyaan lanjutan) untuk menggali informasi lebih dalam.			
9.	Mengatur alur pertanyaan dari yang umum ke khusus (mengalir logis).			
	Fase Validasi dan Uji Coba			
10.	Melakukan *expert judgment* (konsultasi dengan ahli/dosen pembimbing) untuk validitas isi.	☐	☐	

11.	Melakukan uji coba terbatas (pilot study) untuk memeriksa kemudahan pemahaman.			
12.	Merevisi instrumen berdasarkan masukan dari uji coba.			
	Fase Teknis dan Etika	☐	☐	
13.	Melakukan expert judgment (konsultasi dengan ahli/dosen pembimbing) untuk validitas isi.	☐	☐	
14.	Melakukan uji coba terbatas (pilot study) untuk memeriksa kemudahan pemahaman.			
15.	Merevisi instrumen berdasarkan masukan dari uji coba.			

Keputusan Penilaian:

☐ Kompeten

☐ Perlu supervisi

☐ Remedial

Referensi

Aisyah, S., & Sumo, M. (2025). Metodologi Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Konsep Pembelajaran Biologi : Sebuah Analisis Perbandingan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (Jtpp)*, *3*(2), 883–890.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9.

Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(3), 1861–1864.

Elpisisilia. (2024). *Evidence Based Nursing (Ebn) Penerapan Relaksasi Otot Progresif Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe Ii Di Kelurahan Elpisisilia , S . Kep Program Studi Profesi Ners Universitas Sulawesi Barat*.

Gede Subhaktiyasa, P. (2024). Evaluasi Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitiankuantitatif: Sebuah Studi Pustaka. *Journal Of Education Research*, *5*(4), 5599–5609.

Jannah, F., Sa, H., Maisuri, D. E., Agama, I., & Negeri, I. (2025). Journal Of Qualitative And Quantitative Research Komponen-Komponen Dalam Penelitian Kualitatif. *Journal Of Qualitative And Quantitative Research*, *2*(2), 98–109.

Mauizdati, N., Ruwaida, H., & Mardiana. (2024). Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Volume 3 Nomor 2 April (2024) 1164. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *3*(2), 1164–1175. Https://Publisherqu.Com/Index.Php/Pediaqu/Article/View/998/904

Muhammad, Y., Sabaruddin, G., & Andi, H. A. (2024). Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif) Muhammad. *Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, *2*(Pengumpulan Data), 161–173.

Nur, A., Roesadhi, A., Deli, A., Pasaribu, S., & Nasution, N. F. (2026). *Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research*. 14330–14344.

Nurwahdini Hutasuhut, & Meyniar Albina. (2025). Instrumen Penelitian Pendidikan. *Blaze : Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan*, *3*(3), 177–190. Https://Doi.Org/10.59841/Blaze.V3i3.2976

Permatasari, I. D., Sa'diyah, H., & Fahmi, A. S. (2025). Teknik Penyusunan Variabel, Instrumen Penelitian, Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kuantitatif. *Interdisiplin: Journal Of Qualitative And Quantitative Research*, *2*(1), 63–70.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Vol. 2).

Salmia, S. S. (2023). Development Of Quality Instruments And Data Collection Techniques. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (Jppguseda)*, *6*(1), 119–124. Https://Doi.Org/10.55215/Jppguseda.V6i1.7527

Ultavia. (2023). *Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. *6*(0), 167–186.

BAB 2

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN MANAJEMEN DATA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Prosedur Pengumpulan Data dan Manajemen Data	2.1 Menyusun SOP pengumpulan data (alur, peran, kontrol kualitas) termasuk persetujuan partisipan.	2.2 Menetapkan manajemen data (coding, cleaning, penyimpanan aman, kerahasiaan) yang dapat diaudit.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-7

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep inti EBN/etika dan ketepatan identifikasi isu etik pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-5	Penugasan instrumen + SOP pengumpulan/manajemen data	Kesesuaian instrumen–skala ukur dan kelengkapan SOP/manajemen data (checklist/rubrik).	15	Draft instrumen; SOP; data dictionary
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan identifikasi isu	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik pada skenario				

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

Kata Kunci

Berikut adalah kata kunci utama dalam bab ini yang mencerminkan kompetensi inti dalam prosedur pengumpulan dan manajemen data:

- **Prosedur Data:** Rangkaian langkah sistematis dalam memperoleh informasi dari subjek penelitian.
- **Manajemen Data:** Proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pemeliharaan data untuk menjamin keamanan dan kualitasnya.
- **Data Cleaning:** Teknik mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakkonsistenan pada dataset sebelum dianalisis.
- **Informed Consent:** Persetujuan tertulis yang diberikan partisipan setelah memahami seluruh prosedur dan risiko penelitian.
- **Database:** Kumpulan data terorganisir yang disimpan secara digital untuk memudahkan akses dan audit.
- **Triangulasi:** Penggunaan berbagai sumber atau metode untuk meningkatkan keabsahan (validitas) temuan riset.
- **Verbatim:** Transkripsi kata demi kata dari hasil rekaman wawancara tanpa mengubah gaya bahasa informan.
- **Audit Trail:** Dokumentasi langkah-langkah penelitian yang memungkinkan orang lain menelusuri proses dari data mentah hingga kesimpulan.

A. Pendahuluan

Kualitas temuan penelitian sangat bergantung pada integritas proses pengumpulan data di lapangan. Menurut Polit dan Beck (2022), pengumpulan data adalah fase di mana peneliti melakukan kontak langsung dengan realitas atau subjek penelitian. Dalam riset keperawatan, hal ini melibatkan interaksi kompleks yang harus dipandu oleh protokol ketat guna menghindari bias. Tanpa manajemen data yang terencana sejak awal, data yang dihasilkan rentan terhadap kesalahan teknis yang dapat menggugurkan validitas penelitian. Gray dan Grove (2021) menekankan bahwa setiap langkah pengumpulan data harus dapat ditelusuri (*trackable*) dan diaudit untuk memastikan akurasi dan objektivitas informasi yang dianalisis.

Pengumpulan data merupakan bagian utama dari proses penelitian. Metode dan instrumen pengumpulan data harus dipilih sesuai dengan sifat masalah, pendekatan terhadap solusi, dan variabel yang dipelajari. Apakah peneliti sedang menguji hipotesis atau mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, instrumen yang valid dan andal sangat penting. Tujuan dari bab ini adalah untuk menggambarkan berbagai metode pengumpulan data untuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian (Fein, 2017).

B. Klasifikasi Data dalam Keperawatan

Nieswiadomy dan Bailey (2018) menjelaskan bahwa data diklasifikasikan berdasarkan sifat informasinya menjadi dua kategori besar:

1. Data Kualitatif (Deskriptif)

   Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif dan dapat diperoleh melalui berbagai bentuk, seperti hasil observasi, tulisan, rekaman, maupun dokumentasi visual. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, studi kasus, catatan lapangan, buku harian, serta dokumen historis.

   Data kualitatif berfokus pada "makna" dan "pengalaman". Data ini berbentuk narasi, kata-kata, gambar, atau artefak budaya.

   a. Kapan digunakan? Ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena baru, memahami perspektif pasien secara mendalam, atau mempelajari dinamika sosial di bangsal rumah sakit.
   b. Karakteristik: Tidak dapat dihitung secara statistik secara langsung, namun dapat dikategorikan menjadi tema-tema.

   Data kualitatif sangat bermanfaat dalam eksplorasi awal suatu fenomena, khususnya pada bidang yang masih baru, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian kuantitatif. Keunggulan pendekatan ini adalah tidak memerlukan pengetahuan awal yang luas tentang subjek yang diteliti dan mampu menggambarkan variasi pengalaman individu secara lebih komprehensif.

2. Data Kuantitatif (Numerik)

   Data kuantitaif merupakan data dalam bentuk numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data ini dapat berupa angka yang digunakan secara langsung, seperti berat badan, tinggi badan, dan usia, maupun data kategorik yang dikonversi menjadi angka, seperti jenis kelamin atau status tertentu. Keunggulan data kuantitatif terletak pada kemudahan dalam proses analisis, kemampuan untuk melakukan perbandingan, serta pengujian hipotesis menggunakan teknik statistik yang telah terstandar. Apabila data dikumpulkan secara konsisten dan bebas dari bias, maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

   Data kuantitatif berfokus pada "jumlah" dan "frekuensi". Data ini berbentuk angka yang objektif.

   a. Kapan digunakan? Ketika peneliti ingin menguji hipotesis, mencari hubungan antar variabel, atau melakukan generalisasi dari sampel ke populasi.

b. Karakteristik: Memerlukan instrumen yang sudah divalidasi dan diuji reliabilitasnya.

C. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif sangat bergantung pada instrumen yang sistematis agar data yang dihasilkan seragam (konsisten). Menurut White et al (2021), pengumpulan data kuantitatif menggunakan beberapa jenis instrumen, yaitu:

1. Kuesioner,
2. Skala penilaian,
3. Daftar periksa (checklist),
4. Tes standar,
5. Serta pengukuran biofisik.

Metode pengumpulan data ini sering berbasis pada laporan diri (self-report), dimana responden diminta untuk memberikan informasi melalui pengisian kuesioner, survei, atau instrumen standar lainnya (Jones dan Brown, 2024)

1. Kuesioner

Kuesioner adalah set pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan informasi laporan diri (*self-report*). **Kuesioner** merupakan bentuk survei terstruktur yang umumnya diisi sendiri oleh responden (self-administered). Dalam praktik penelitian, kuesioner dapat didistribusikan melalui berbagai cara, seperti melalui surat (pos) atau secara langsung (tatap muka). Distribusi melalui pos memiliki keunggulan dari segi efisiensi biaya dan kemampuan menjangkau populasi yang luas dalam waktu relatif singkat. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan rendahnya tingkat pengembalian kuesioner (Fein, 2017).

Secara umum, tingkat respons kuesioner dapat bervariasi antara 0% hingga 80%, dengan tingkat respons yang dianggap realistis berkisar antara 30% hingga 60% pada sebagian besar penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan tingkat respons agar data yang diperoleh tetap representative (Fein, 2017).

Contoh Struktur Kuesioner

Kuesioner umumnya diawali dengan instruksi yang jelas kepada responden, kemudian diikuti oleh beberapa bagian, seperti:

a. Data Demografis

Berisi informasi latar belakang responden, misalnya pendidikan dan riwayat akademik.Contoh:1: SD, 2:SMP, 3: SLTA, 4: Perguruan Tinggi.

b. Kebiasaan Pribadi

Menggunakan skala kategori untuk mengukur frekuensi perilaku tertentu. Contoh: Konsumsi minuman:

0 = Tidak pernah
1 = <1 kali/bulan
2 = 1–3 kali/bulan
3 = 1–6 kali/minggu
4 = 1–2 kali/hari
5 = 3–4 kali/hari
6 = ≥5 kali/hari

Contoh: Kebiasaan merokok

0 = Tidak pernah
1 = Mantan perokok
2–6 = Berdasarkan jumlah konsumsi per hari

c. Riwayat Kesehatan

Menggunakan format dikotomi (Ya/Tidak).

Contoh:

1) Penyakit jantung (Ya=1, Tidak=0)
2) Hipertensi (Ya=1, Tidak=0)
3) Kolesterol tinggi (Ya=1, Tidak=0)
4) Emfisema (Ya=1, Tidak=0)
5) Kanker (Ya=1, Tidak=0)

Menurut Smith et al. (2023), langkah pengembangan meliputi:

1) Justifikasi Teoretis: Setiap pertanyaan harus didasarkan pada variabel yang ada di definisi operasional.
2) Uji Coba (*Pilot Testing*): Kuesioner harus diujikan pada kelompok kecil (minimal 10-20 orang) yang karakteristiknya mirip dengan sampel penelitian untuk melihat apakah ada kata-kata yang membingungkan.

Jenis Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

a. Kuesioner Tertutup

Kuesioner tertutup merupakan format dimana responden diminta memilih jawaban dari alternatif yang telah disediakan. Jenis ini banyak digunakan dalam survei skala besar karena:

1) Memudahkan proses pengkodean data,
2) Mempercepat analisis statistik,
3) Serta meningkatkan konsistensi jawaban responden.

b. Kuesioner Terbuka

Kuesioner terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Meskipun mampu menghasilkan data yang lebih mendalam, jenis ini:

1) Lebih sulit dianalisis secara kuantitatif,
2) Serta memberikan kontrol yang lebih terbatas bagi peneliti terhadap variasi jawaban.

Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan kuesioner terbuka relatif lebih jarang karena keterbatasan dalam proses analisis data.

Perbedaan Pertanyaan Terbuka dan Tertutup

Pertanyaan Terbuka

Memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dengan kata-kata sendiri.

Contoh:

Jelaskan alasan Anda menggunakan sabuk pengaman saat berkendara.

Jelaskan pandangan Anda tentang konsumsi alkohol.

Pertanyaan Tertutup

Menyediakan pilihan jawaban yang telah ditentukan.

Contoh:

Seberapa sering Anda menggunakan sabuk pengaman?

a. Tidak pernah
b. Jarang
c. Terkadang
d. Sebagian besar waktu
e. Selalu

Dalam 30 hari terakhir, berapa kali Anda mengemudi setelah mengonsumsi alkohol?

a. 0 kali
b. 1 kali
c. 2–3 kali
d. 4–5 kali
e. ≥6 kali

Pedoman Penyusunan Pertanyaan dalam Kuesioner

Penyusunan pertanyaan dalam kuesioner merupakan tahap krusial untuk memastikan data yang diperoleh valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan:

a. Gunakan Pertanyaan yang Spesifik

Pertanyaan yang spesifik akan menghasilkan jawaban yang lebih terarah dan relevan. Pertanyaan yang terlalu umum dapat menimbulkan interpretasi yang luas dan tidak fokus. **Contoh:** Kurang tepat: "Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diterima?" Lebih tepat: "Bagaimana Anda menilai kesempatan

untuk menyampaikan preferensi dalam perawatan Anda (sangat baik hingga buruk)?"

b. Gunakan Bahasa yang Sederhana dan Sesuai

Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang responden. Penggunaan istilah teknis perlu dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik responden. **Contoh:** Untuk masyarakat umum: "Apakah menurut Anda kasus kanker paru meningkat, menurun, atau tetap?" Untuk tenaga kesehatan: pertanyaan perlu lebih spesifik dengan menyebutkan periode waktu, populasi, dan indikator epidemiologi.

c. Satu Pertanyaan untuk Satu Konsep

Setiap item pertanyaan harus hanya mengukur satu konsep. Pertanyaan ganda dapat membingungkan responden dan menyulitkan interpretasi data. **Contoh:** Kurang tepat: "Apakah Anda memakai sabuk pengaman saat mengemudi?" Lebih tepat: "Seberapa sering Anda menggunakan sabuk pengaman saat berada di dalam mobil?"

d. Batasi Referensi Waktu

Pertanyaan harus menyebutkan periode waktu yang jelas untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Contoh: Kurang jelas: "Apakah Anda sering berolahraga?"

Lebih jelas: "Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda berolahraga?"

e. Gunakan Pernyataan yang Netral

Pertanyaan harus disusun secara netral dan tidak mengarahkan responden pada jawaban tertentu. Contoh: Kurang netral: "Apakah Anda tidak setuju bahwa pelayanan ini buruk?"

Netral: "Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut?"

Merancang Jawaban yang Baik dalam Kuesioner

Penyusunan pertanyaan yang efektif dalam kuesioner tidak terlepas dari perancangan bentuk jawaban yang tepat. Jenis jawaban yang dipilih akan menentukan kualitas data yang diperoleh serta kemudahan dalam analisis. Secara umum, terdapat tiga jenis respons utama dalam kuesioner, yaitu respons terbuka, respons kategoris, dan respons berkelanjutan.

a. Respons Terbuka

Respons terbuka memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian atau pernyataan bebas sesuai dengan pandangan mereka.

Pada tahap eksplorasi awal penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan sebagai pelengkap terhadap pertanyaan tertutup Namun demikian, respons terbuka memiliki keterbatasan, terutama dalam proses

analisis. Data yang dihasilkan umumnya tidak langsung dapat dianalisis menggunakan komputer, sehingga perlu dilakukan proses **pengkodean (coding)** terlebih dahulu. Proses ini sering kali memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar.

b. Respons Kategoris

Respons kategoris merupakan bentuk jawaban tertutup di mana responden diminta memilih satu jawaban dari beberapa alternatif yang telah disediakan.

Dalam menyusun respons kategoris, terdapat beberapa prinsip penting:

Pilihan jawaban harus lengkap, mencakup semua kemungkinan yang relevan. Dapat ditambahkan opsi "Lainnya: sebutkan ..." untuk mengakomodasi jawaban yang jarang muncul . Setiap kategori harus saling eksklusif, artinya tidak boleh tumpang tindih. Contoh yang kurang tepat: Usia: 18–21, 21–35, 36–65, ≥65 (terdapat tumpang tindih pada angka 21) Contoh yang lebih tepat: Usia: 18–20, 21–35, 36–65, ≥66 .

Selain itu, beberapa pertanyaan sebaiknya dipisahkan menjadi beberapa item jika mencakup lebih dari satu kondisi. **Contoh:** Kurang tepat: "Apakah Anda memiliki diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi?" Lebih tepat: dipisahkan menjadi beberapa pertanyaan dengan jawaban ya/tidak untuk masing-masing kondisi.

c. Respons Berkelanjutan (Continuous Response)

Respons berkelanjutan memungkinkan responden memberikan jawaban dalam rentang nilai tertentu yang bersifat kontinu. Data yang dihasilkan biasanya berbentuk numerik dan dapat langsung dianalisis tanpa perlu proses pengkodean tambahan.

Contoh variabel:

- Usia
- Berat badan
- Tinggi badan
- Tekanan darah

Dalam menggunakan respons berkelanjutan, peneliti perlu:

- Menentukan **satuan pengukuran** yang digunakan
- Menetapkan **tingkat ketelitian (presisi)** data

Contoh:

- Pada penelitian bayi baru lahir: berat badan diukur hingga setengah ons, usia dalam bulan
- Pada penelitian dewasa: berat badan cukup dalam kilogram atau pon, usia dalam tahun

2. Skala Penilaian

   Skala penilaian digunakan untuk mengukur atribut psikososial yang tidak bisa diukur langsung dengan meteran atau timbangan.

   a. Skala Likert (Tingkat Persetujuan):
      - Pernyataan: "Saya merasa nyaman berkomunikasi dengan perawat malam."
      - Skor: 1 (STS - Sangat Tidak Setuju) s/d 5 (SS - Sangat Setuju).
   b. Skala Diferensial Semantik: Menggunakan dua kata sifat yang berlawanan di ujung garis.
      - Contoh (Menilai Lingkungan RS): "Dingin |---|---|---|---|---| Hangat".
   c. Visual Analog Scale (VAS): Garis 100 mm tanpa tanda angka di tengah.
      - Contoh (Mengukur Nyeri): Pasien menandai garis antara "Tidak Nyeri" (0 mm) dan "Nyeri Sangat Hebat" (100 mm). Peneliti mengukur posisi tanda tersebut menggunakan penggaris.
   d. Q-Sort: Responden diberikan kartu-kartu berisi pernyataan (misal: 60 pernyataan tentang kepuasan kerja) dan diminta menyusunnya dalam bentuk distribusi normal (piramida) dari "Paling Setuju" hingga "Paling Tidak Setuju".

3. Daftar Periksa (*Checklist*)

   a. Pengertian Daftar Periksa (*Checklist*)

      Menurut Gray dan Grove (2021), daftar periksa (*checklist*) adalah instrumen pengumpulan data yang berisi daftar indikator, perilaku, atau atribut yang telah ditentukan sebelumnya untuk diamati atau diverifikasi keberadaannya. Dalam riset keperawatan, *checklist* digunakan untuk mencatat apakah suatu tindakan atau kondisi "Muncul" atau "Tidak Muncul", "Dilakukan" atau "Tidak Dilakukan". Berbeda dengan skala (seperti Likert), *checklist* tidak mengukur derajat atau intensitas, melainkan fokus pada aspek dikotomis (Ya/Tidak). Instrumen ini sangat efektif untuk mengurangi bias pengamat karena peneliti hanya perlu menandai poin-poin yang sudah terstandarisasi.

   b. Cara Pengukuran dan Penilaian

      Pengukuran menggunakan *checklist* dilakukan dengan cara observasi langsung atau pemeriksaan dokumen. Peneliti memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

      Sistem Skor:

      - Kuantitatif: Jawaban "Ya" biasanya diberi skor 1, dan "Tidak" diberi skor 0. Total skor kemudian dipersentasekan untuk menentukan tingkat kepatuhan atau kelengkapan.
      - Kualitatif: Hasil *checklist* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kesalahan atau langkah-langkah yang paling sering terabaikan dalam prosedur klinis.

Validitas: Untuk menjamin validitas, *checklist* harus disusun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi atau panduan praktik klinis yang berlaku (Polit & Beck, 2022).

c. Contoh Instrumen Daftar Periksa (*Checklist*)

Berikut adalah contoh *checklist* yang sering digunakan dalam riset manajemen keperawatan atau keselamatan pasien:

Judul Instrumen: Daftar Periksa Kepatuhan Prosedur Pemasangan Infus

Nama Peneliti: ..... Tanggal Observasi: .....

No	Indikator Observasi (Langkah Prosedur)	Dilakukan (1)	Tidak Dilakukan (0)	Keterangan
1	Menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien (*Informed Consent*)			
2	Melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum tindakan			
3	Menyiapkan alat secara ergonomis dan steril			
4	Memakai sarung tangan bersih/steril sesuai indikasi			
5	Melakukan desinfeksi area penusukan secara sirkular			
6	Memasukkan abocath dengan sudut 15-30 derajat			
7	Melakukan fiksasi transparan dan rapi			
8	Memberikan label tanggal dan jam pemasangan pada infus			
9	Membuang sampah tajam ke *Safety Box*			
10	Melakukan cuci tangan setelah tindakan selesai			
Total Skor			.... / 10	

Kriteria Penilaian:

- Patuh: 80% - 100% (Skor 8-10)

- Cukup Patuh: 60% - 79% (Skor 6-7)
- Tidak Patuh: < 60% (Skor < 6)

4. Pengukuran Biofisik

   Pengukuran ini menggunakan peralatan medis canggih untuk mendapatkan data fisiologis subjek secara akurat (Luan et al., 2024).
   - Contoh In Vivo (Langsung pada tubuh): Mengukur curah jantung (*cardiac output*) menggunakan alat hemodinamik invasif di ICU.
   - Contoh In Vitro (Di luar tubuh): Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kadar HbA1c pada pasien Diabetes Melitus.
   - Prinsip Utama: Alat harus dikalibrasi (tera ulang) dan operator harus memiliki sertifikasi kompetensi untuk memastikan validitas data.
5. Sop pengukuran data kuantitatif (Kuesioner)
   a. Persiapan: Pastikan instrumen (kuesioner) sudah lolos uji validitas dan reliabilitas. Siapkan alat tulis atau perangkat digital (jika menggunakan *Google Form/ODK*).
   b. Perizinan: Bawa surat izin penelitian dari institusi dan bukti layak etik (*Ethical Clearance*).
   c. Rekrutmen: Identifikasi responden yang memenuhi kriteria inklusi.
   d. Penjelasan: Berikan Lembar Penjelasan kepada responden mengenai tujuan, manfaat, dan risiko penelitian.
   e. Persetujuan: Mintalah responden menandatangani Lembar Persetujuan (Informed Consent) tanpa paksaan.
   f. Pelaksanaan: Berikan kuesioner. Jika responden mengalami kendala membaca, peneliti dapat membacakan pertanyaan secara netral (tanpa mengarahkan jawaban).
   g. Verifikasi: Cek kembali kelengkapan jawaban sebelum responden meninggalkan lokasi. Jika ada yang kosong, tanyakan kembali saat itu juga.
   h. Terminasi: Ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi (jika ada)

D. Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Dalam paradigma kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci (*researcher as a key instrument*). Polit dan Beck (2022) merinci metodenya sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)
   a. Pengertian

      Menurut **Polit dan Beck (2022)**, wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi tatap muka yang intens antara peneliti (pewawancara) dan informan (narasumber) dengan tujuan

untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, perasaan, atau kepercayaan informan mengenai suatu fenomena tertentu.

Dalam riset keperawatan, metode ini sering disebut sebagai "percakapan dengan tujuan" (*conversation with a purpose*). Peneliti tidak hanya mencari jawaban "Ya" atau "Tidak", melainkan mencari narasi yang kaya untuk memahami dunia dari sudut pandang informan.

b. Jenis-Jenis Wawancara

Nieswiadomy dan Bailey (2018) mengklasifikasikan wawancara berdasarkan tingkat strukturnya:

1) Wawancara Terstruktur: Menggunakan kuesioner formal dengan pertanyaan yang sama bagi semua informan. Biasanya digunakan untuk data demografi dalam studi kualitatif.
2) Wawancara Semi-Terstruktur: Peneliti memiliki panduan wawancara (*interview guide*) berisi daftar topik atau pertanyaan kunci, namun urutan dan cara penyampaiannya fleksibel tergantung alur pembicaraan. Ini adalah jenis yang paling sering digunakan dalam riset keperawatan.
3) Wawancara Tidak Terstruktur (Naratif): Tidak ada pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Peneliti memulai dengan satu pertanyaan umum (misal: "Ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali didiagnosis kanker") dan membiarkan informan bercerita secara bebas.

c. Syarat Pelaksanaan Wawancara Mendalam

Agar data yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

1) Keahlian Peneliti: Peneliti harus memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif (*active listening*) dan mampu melakukan *probing* (teknik menggali lebih dalam).
2) Suasana Terapeutik: Lokasi wawancara harus tenang, privat, dan nyaman agar informan merasa aman untuk berbagi informasi sensitif.
3) Instrumen Penunjang: Tersedianya alat perekam suara (*audio recorder*) yang berfungsi baik dan buku catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat bahasa tubuh atau ekspresi informan.
4) Ethical Clearance: Adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) dan jaminan kerahasiaan identitas informan.

d. Tujuan Wawancara Mendalam

1) Eksplorasi Makna: Mengungkap makna di balik perilaku atau peristiwa medis (misal: mengapa pasien tidak patuh minum obat).
2) Identifikasi Fenomena Baru: Mendapatkan informasi yang belum pernah tercatat dalam teori atau literatur sebelumnya.

3) Konteks Kehidupan: Memahami bagaimana latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi memengaruhi kesehatan individu.

e. Contoh Prosedur dan Pertanyaan

Skenario **Riset:** Eksplorasi Pengalaman Psikologis Perawat saat Menghadapi Kematian Pasien Pertama Kali.

1) Pertanyaan Pembuka: "Bisa Anda ceritakan kembali situasi saat pertama kali Anda merawat pasien yang kemudian dinyatakan meninggal dunia?"
2) Teknik Probing (Gali Dalam): * Informan: "Saat itu saya merasa sangat bersalah."
   - Peneliti: "Bisa Anda jelaskan lebih lanjut, apa yang Anda maksud dengan perasaan 'sangat bersalah' tersebut?"
3) Pertanyaan Penutup: "Dari semua yang telah kita diskusikan, apa hal yang paling mengubah cara pandang Anda dalam merawat pasien saat ini?"

2. Observasi Partisipatif

a. Pengertian

Menurut Polit dan Beck (2022), observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas sehari-hari kelompok yang sedang diteliti. Peneliti tidak hanya berdiri sebagai pengamat luar, tetapi juga berinteraksi dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut untuk menangkap nuansa perilaku dan budaya yang tidak terungkap melalui wawancara.

Dalam riset keperawatan, metode ini memungkinkan peneliti melihat perbedaan antara apa yang "dikatakan" oleh perawat (dalam wawancara) dengan apa yang sebenarnya "dilakukan" (dalam praktik klinis).

b. Jenis-Jenis Peran Pengamat

Nieswiadomy dan Bailey (2018) membagi peran pengamat menjadi empat tingkat:

1) Pengamat Penuh (*Complete Observer*): Peneliti hanya mengamati tanpa interaksi sama sekali (sering kali tersembunyi).
2) Pengamat sebagai Partisipan: Peneliti melakukan observasi namun interaksinya dengan subjek sangat terbatas dan formal.
3) Partisipan sebagai Pengamat: Peneliti terlibat aktif dalam aktivitas kelompok dan identitasnya sebagai peneliti diketahui oleh subjek. Ini adalah peran yang paling umum dalam riset kualitatif keperawatan.
4) Partisipan Penuh (*Complete Participant*): Peneliti menjadi anggota penuh kelompok tersebut dan identitas penelitiannya disembunyikan (sering memicu perdebatan etik).

c. Syarat dan Instrumen

Catatan Lapangan (*Field Notes*): Instrumen utama yang berisi deskripsi detail mengenai waktu, tempat, orang, interaksi, dan kejadian.

1) Log Book: Catatan harian mengenai jadwal dan apa yang dilakukan peneliti setiap harinya.
2) Refleksivitas: Peneliti harus sadar akan keberadaannya (apakah kehadirannya mengubah perilaku subjek—*Hawthorne Effect*).
3) Izin Etik: Memerlukan persetujuan dari institusi (misal: Komite Etik RS) untuk berada di area pelayanan pasien.

d. Tujuan Observasi Partisipatif

Tujuan dilakukan observasi partisipasi Adalah:

1) Memahami Konteks: Melihat situasi lingkungan yang memengaruhi kesehatan (misal: kebersihan bangsal, kebisingan).
2) Validasi Data: Melakukan triangulasi (mencocokkan) hasil wawancara dengan fakta di lapangan.
3) Menemukan Pola Perilaku: Mengidentifikasi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan tenaga medis atau keluarga pasien.

e. Contoh Prosedur dan Catatan Lapangan

Skenario**:** Budaya Keselamatan Pasien dalam Prosedur Serah Terima (*Handover*) di Ruang Bedah.

- Aktivitas: Peneliti ikut hadir dalam operan shift pagi dan sore selama 2 minggu.
- Contoh Catatan Lapangan (Field Notes):
  "Pukul 07.15 WIB, di nurse station terlihat 4 perawat berkumpul. Perawat A tampak terburu-buru dan hanya membacakan diagnosa medis tanpa menyebutkan rencana keperawatan yang belum tuntas. Perawat B beberapa kali menguap dan tidak mencatat instruksi dokter yang disampaikan. Suasana sangat bising karena suara renovasi di koridor sebelah..."

3. Focus Group Discussion (FGD)

a. Pengertian

Menurut Polit dan Beck (2022), *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode pengumpulan data kualitatif yang mengumpulkan sekelompok orang (biasanya dengan latar belakang atau pengalaman yang serupa) untuk mendiskusikan topik tertentu yang dipandu oleh seorang moderator.

Kekuatan utama FGD bukan sekadar pada jawaban individu, melainkan pada interaksi antarpeserta. Dinamika kelompok ini sering kali memicu munculnya pandangan, memori, atau ide yang mungkin tidak akan terungkap dalam wawancara individu secara tatap muka.

b. Komposisi dan Jumlah Peserta

Agar diskusi berjalan efektif dan mendalam, **Gray dan Grove (2021)** menyarankan standar berikut:

1) Jumlah Peserta: Idealnya berjumlah 6 hingga 12 orang. Jika terlalu sedikit, diskusi tidak dinamis; jika terlalu banyak, sulit bagi moderator untuk mengontrol pembicaraan.
2) Homogenitas: Peserta sebaiknya memiliki karakteristik yang serupa (misal: sesama perawat pelaksana, atau sesama penyintas penyakit tertentu) agar mereka merasa nyaman berbicara terbuka tanpa adanya rasa sungkan atau dominasi hirarki.

c. Peran dalam FGD

Dalam pelaksanaan FGD, diperlukan peran-peran spesifik agar data terselamatkan:

1) Moderator (Fasilitator): Bertugas memandu alur diskusi, memastikan semua peserta mendapat kesempatan bicara, dan menjaga agar topik tidak melenceng.
2) Notulis (*Note-taker*): Mencatat poin-poin penting, dinamika kelompok (siapa yang setuju/tidak setuju), serta bahasa tubuh peserta.
3) Logistik/Perekam: Memastikan alat perekam suara atau video mencakup seluruh suara peserta di ruangan tersebut.

d. Syarat dan Tujuan

1) Syarat: Lokasi harus netral (bukan di ruangan atasan jika responden adalah bawahan), berbentuk lingkaran agar posisi setara, dan adanya aturan main (*ground rules*) di awal diskusi.
2) Tujuan: * Mendapatkan berbagai variasi perspektif dalam waktu singkat.
   - Mengidentifikasi norma kelompok atau nilai-nilai bersama dalam sebuah komunitas keperawatan.
   - Membantu pengembangan instrumen kuesioner dengan memahami istilah yang biasa digunakan oleh target populasi.

e. Contoh Prosedur dan Pertanyaan

Skenario Riset: Eksplorasi Hambatan Pelaksanaan *Patient Safety* di Ruang Rawat Inap.

1) Pertanyaan Pemicu (*Ice Breaking*): "Apa yang terlintas di pikiran Bapak/Ibu saat mendengar istilah 'Kesalahan Medis'?"
2) Pertanyaan Inti: "Beberapa dari kita mungkin pernah merasa terburu-buru saat memberikan obat. Bagaimana pendapat kelompok mengenai pengaruh beban kerja terhadap ketelitian kita?"

3) Dinamika yang Diharapkan: Peserta A bercerita tentang kelelahan, Peserta B menimpali dengan masalah kurangnya personil, dan Peserta C menambahkan tentang kurangnya dukungan sarana.

4. SOP Pengumpulan Data Kualitatif (Wawancara Mendalam)
   a. Pra-Wawancara: Hubungi informan untuk menyepakati waktu dan tempat yang tenang serta privat (menjaga kerahasiaan).
   b. Peralatan: Pastikan alat perekam (*audio recorder*) memiliki baterai cukup dan ruang penyimpanan tersedia. Siapkan buku catatan lapangan (*field notes*).
   c. Bina Hubungan (*Rapport*): Mulailah dengan percakapan ringan untuk mencairkan suasana agar informan merasa nyaman.
   d. Kontrak Etik: Jelaskan bahwa wawancara akan direkam dan identitas mereka akan disamarkan (anonim). Mintalah tandatangan *Informed Consent*.
   e. Proses Wawancara: Gunakan pertanyaan terbuka. Biarkan informan bercerita tanpa banyak interupsi. Gunakan teknik *probing* (menggali lebih dalam) pada poin-poin penting.
   f. Observasi Non-Verbal: Catat bahasa tubuh, nada suara, atau tangisan informan dalam catatan lapangan.
   g. Penutup: Ringkas poin-poin utama yang didapat dan tanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan.
   h. Pasca-Wawancara: Segera buat transkrip (verbatim) selagi ingatan masih segar.

E. Manajemen Data Penelitian

Manajemen data adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang dikumpulkan selama penelitian. Manajemen data memastikan data yang telah dikumpulkan tidak hilang, rusak, atau salah tafsir (Jones & Brown, 2024). Terdapat 3 (tiga) aktivitas peneliti dalam manajemen data ini, yaitu:

1. Penyusunan Buku Kode (*Codebook*)

   Codebook adalah dokumen teknis (kamus data) yang merinci daftar variabel, definisi operasional, dan kode angka yang digunakan untuk mewakili setiap kategori jawaban dalam dataset. Daftar yang merinci setiap variabel dalam dataset. Manfaat:
   a. Menjamin konsistensi saat melakukan entri data ke aplikasi statistik (seperti SPSS atau Excel).
   b. Memudahkan peneliti lain atau auditor untuk memahami struktur data yang telah dikumpulkan.
   c. Mengurangi risiko kesalahan interpretasi variabel di masa depan.

   SOP pelaksanaan Penyusunan *Codebook*:

a. Identifikasi Variabel: Tuliskan semua variabel dari kuesioner (misal: Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan).
b. Penamaan Singkat (*Variable Name*): Buat nama singkat maksimal 8 karakter (misal: JK, PND, SKOR_NYR).
c. Labeling: Berikan deskripsi lengkap dari variabel tersebut.
d. Coding (Pemberian Kode): Tentukan angka untuk kategori non-numerik, *Contoh:* Pria = 1, Wanita = 2
e. Handling Missing Value: Tentukan kode untuk data yang tidak diisi (misal: 999)

2. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Data Cleaning adalah proses pemeriksaan kembali data yang telah di-*entry* untuk mendeteksi, memperbaiki, atau menghapus data yang salah, tidak konsisten, atau tidak masuk akal. Proses krusial sebelum analisis dilakukan (White et al., 2021):

a. Check for Outliers: Mencari angka yang mustahil (misal: Usia tertulis 250 tahun).
b. Missing Data: Menentukan kebijakan terhadap data kosong (apakah akan dibuang atau diisi dengan nilai rata-rata/imputasi).

Manfaat:

a. Meningkatkan akurasi analisis statistik.
b. Memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi responden, bukan karena kesalahan input

SOP Pembersihan Data:

a. Cek *Outliers* (Nilai Ekstrem): Periksa angka yang berada di luar jangkauan logika. (Contoh: Pada variabel tekanan darah sistolik, jika tertulis 20 mmHg atau 400 mmHg, ini harus dikonfirmasi ulang ke kuesioner asli).
b. Cek Konsistensi (*Logic Check*): Pastikan jawaban antar variabel masuk akal. (Contoh: Jika variabel jenis kelamin adalah "Laki-laki", namun pada variabel "Jumlah Kehamilan" terisi angka 2, maka terdapat kesalahan).
c. Penanganan Data Kosong (*Missing Data*): Cek apakah ada pertanyaan yang terlewat. Jika ditemukan, peneliti harus memutuskan apakah akan menghubungi responden kembali atau membuang sampel tersebut.
d. Distribusi Frekuensi: Lakukan uji frekuensi sederhana pada semua variabel untuk melihat apakah ada kode angka yang tidak terdaftar di *codebook*

3. Penyimpanan dan Keamanan

Penyimpanan dan keamanan data adalah praktik melindungi data penelitian dari kerusakan fisik, kehilangan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang selama dan setelah penelitian selesai. Data digital harus disimpan di media penyimpanan awan (*cloud*) yang terenkripsi dan data fisik harus berada di lemari

terkunci dengan akses terbatas. Berdasarkan standar internasional, data penelitian keperawatan wajib disimpan selama minimal 5 tahun untuk kebutuhan audit atau pembuktian keaslian temuan.

Manfaat:

a. Melindungi privasi dan kerahasiaan (*confidentiality*) responden.
b. Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak luar.
c. Memenuhi standar hukum dan etik penelitian kesehatan.

SOP Penyimpanan dan Keamanan:

a. Anonimitas: Ganti nama responden dengan kode unik (misal: R001, R002) pada lembar kerja digital.
b. Penyimpanan Digital: Gunakan penyimpanan awan (*cloud storage*) yang terenkripsi dan terlindungi kata sandi. Lakukan pencadangan (*backup*) secara berkala.
c. Penyimpanan Fisik: Simpan kuesioner kertas dan lembar *informed consent* dalam lemari besi/kayu yang terkunci di ruangan dengan akses terbatas.
d. Pemisahan Data: Jangan simpan daftar nama responden (identitas asli) di dalam file yang sama dengan hasil jawaban penelitian.
e. Durasi Penyimpanan: Simpan data minimal 5 tahun sesuai standar Polit dan Beck (2022), setelah itu data dimusnahkan (dihancurkan/dihapus permanen) untuk menjaga privasi permanen.

F. Format penjelasan penelitian

Judul Penelitian: [Masukkan Judul Penelitian Anda] **Peneliti:** [Nama Anda/Tim]
Bapak/Ibu/Saudara diajak untuk berpartisipasi dalam penelitian yang bertujuan untuk [Jelaskan tujuan secara singkat dan sederhana].

Apa yang harus saya lakukan? Anda akan diminta untuk [Mengisi kuesioner / Diwawancarai selama kurang lebih 30-45 menit]. **Apakah ada risikonya?** Penelitian ini tidak memberikan risiko fisik. Namun, mungkin ada ketidaknyamanan saat menceritakan pengalaman pribadi. Anda berhak menghentikan partisipasi kapan saja tanpa sanksi apa pun. **Manfaat:** Partisipasi Anda akan sangat membantu pengembangan ilmu keperawatan dalam hal [Sebutkan manfaatnya]. **Kerahasiaan:** Semua data yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama Anda tidak akan dicantumkan dalam laporan akhir (menggunakan kode/inisial).

Format lembar persetujuan terlibat dalam penelitian
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama (Inisial) : _____
Usia : _____
Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Saya memahami bahwa keikutsertaan saya bersifat **sukarela** dan saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu.

Dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA** *) untuk ikut serta sebagai responden penelitian.
[Kota, Tanggal, Bulan, Tahun]

Responden, Peneliti,

(.....) (.....)

G. Ringkasan Bab

Prosedur pengumpulan data adalah jantung dari penelitian keperawatan. Keberhasilan riset ditentukan oleh keselarasan antara tujuan penelitian dan metode yang digunakan, baik itu kuantitatif dengan skalanya yang terukur, maupun kualitatif dengan kedalaman maknanya. Manajemen data yang disiplin melalui *coding*, *cleaning*, dan penyimpanan aman adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya penelitian yang kredibel dan beretika.

Aktivitas Mahasiswa dan Rubrik Penilaian

Aktivitas Mahasiswa 1: Simulasi Etik & SOP

1. **Tugas:** Mahasiswa dibagi berpasangan. Satu menjadi peneliti, satu menjadi responden.
2. **Instruksi:** Praktikkan pemberian Lembar Penjelasan dan pengambilan *Informed Consent* menggunakan SOP yang telah dipelajari. Observer akan menilai menggunakan rubrik penilaian komunikasi penelitian

Rubrik Penilaian Etik & SOP (RB-01)

Aspek Penilaian	**1 (Kurang)**	**2 (Cukup)**	**3 (Baik)**	**4 (Sangat Baik)**
Pemberian Informasi	Langsung meminta tandatangan	Menjelaskan tapi sangat singkat	Menjelaskan tujuan & prosedur	Menjelaskan hak responden & kerahasiaan secara detail
Kepatuhan SOP	Alur berantakan	Alur benar tapi ada yang terlewat	Alur sesuai SOP	Alur sangat sistematis & tenang
Etika & Sikap	Memaksa responden	Kurang sopan	Sopan & menghargai	Sangat empatik & menjaga kenyamanan subjek

Aktivitas Mandiri 1: Konstruksi Pertanyaan Kuesioner

Tugas: Mahasiswa diminta menyusun 5 pertanyaan kuesioner tentang "Kepatuhan Mencuci Tangan".

1. Ketentuan: * 2 Pertanyaan menggunakan bentuk Kuesioner Tertutup (Dikotomi Ya/Tidak).
2. 2 Pertanyaan menggunakan Skala Likert (1-5).
3. 1 Pertanyaan menggunakan Kuesioner Terbuka.

Luaran: Lembar draf kuesioner yang siap diuji keterbacaannya.

Aktivitas Kelompok 1: Simulasi Pengukuran Biofisik & Skala

- **Instruksi:** Bentuk kelompok terdiri dari 3 orang (1 Peneliti, 1 Pasien, 1 Observer).
- **Skenario:** Melakukan pengukuran tingkat nyeri dan tanda-tanda vital pada pasien pasca-operasi.
- **Langkah Kerja:**

1. Peneliti mengukur intensitas nyeri pasien menggunakan **Visual Analog Scale (VAS)**.
2. Peneliti melakukan pengukuran **Biofisik** (Tekanan Darah dan Nadi) menggunakan tensimeter digital.
3. Observer mencatat apakah peneliti melakukan kalibrasi alat (memastikan baterai cukup/posisi nol) dan posisi manset yang benar.

- **Luaran:** Laporan hasil pengukuran dan analisis korelasi sederhana antara tingkat nyeri (Skala) dengan perubahan nadi (Biofisik)

Analisis Kasus

Kasus: Seorang mahasiswa perawat sedang meneliti "Pengaruh Terapi Musik terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi". Mahasiswa tersebut menggunakan **Skala Diferensial Semantik** untuk mengukur kecemasan dan **Termometer Infrared** untuk mengukur suhu kulit sebagai data biofisik tambahan.

Pertanyaan Pemantik:

1. Jika pasien menandai area di luar garis 100mm pada skala VAS/Diferensial Semantik karena sangat cemas, bagaimana peneliti harus menyikapinya dalam tahap manajemen data?
2. Mengapa pengukuran suhu kulit (Biofisik) dianggap kurang valid dibandingkan kuesioner kecemasan jika alat tidak dikalibrasi terlebih dahulu?
3. Sebutkan satu contoh "pertanyaan mengarahkan" yang harus dihindari saat menyusun kuesioner kecemasan!

Rubrik Penilaian OBE (Kuantitatif)

RB-09.1 Rubrik Penilaian Instrumen Kuantitatif (Skala 1–4)

Aspek Penilaian	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Penyusunan Kuesioner	Pertanyaan membingungkan & bias	Pertanyaan jelas tapi tidak relevan	Pertanyaan relevan, pilihan jawaban tepat	Struktur sistematis, valid secara konten & bahasa operasional
Aplikasi Teknik Penskalaan	Salah menggunakan jenis skala	Skala benar, tapi instruksi pengisian salah	Skala & instruksi benar, namun layout membingungkan	Penggunaan VAS/Likert sangat akurat & instruksi sangat jelas

Aspek Penilaian	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Ketepatan Pengukuran Biofisik	Mengabaikan kalibrasi & prosedur	Kalibrasi dilakukan, prosedur kurang tepat	Prosedur tepat, hasil dicatat dengan benar	Prosedur sangat akurat, alat dikalibrasi, & posisi subjek sempurna
Integritas Manajemen Data	Data dimanipulasi/asal isi	Data asli tapi banyak kesalahan input	Data bersih, *codebook* sederhana	*Data cleaning* sempurna & *codebook* sangat detail

Aktivitas Mahasiswa 2: Latihan Mandiri

Tugas:

1. Pilihlah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) keperawatan (misalnya: SOP Ganti Balutan atau SOP Pemberian Obat Oral).
2. Susunlah instrumen daftar periksa (*checklist*) berdasarkan langkah-langkah dalam SOP tersebut.
3. Lakukan simulasi observasi terhadap teman sejawat saat melakukan prosedur tersebut dan berikan penilaian menggunakan *checklist* yang telah Anda buat.

Rubrik Penilaian Instrumen Checklist (RB-09.1)

Aspek Penilaian	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Relevansi Indikator	Indikator tidak sesuai SOP	Indikator kurang lengkap	Indikator sesuai SOP namun urutan acak	Indikator sangat lengkap & urut sesuai SOP
Kejelasan Bahasa	Bahasa membingungkan	Bahasa terlalu medis/rumit	Bahasa cukup jelas	Bahasa operasional & mudah diamati
Sistem Scoring	Tidak ada sistem skor	Skor tidak konsisten	Skor jelas	Skor & kriteria penilaian sangat detail

Aktivitas Mahasiswa (Praktik Lab Komunikasi Riset)

Tugas Kelompok (Role Play):

1. Bentuk pasangan (Pewawancara dan Informan).
2. Pewawancara menyusun *Interview Guide* singkat (3-5 pertanyaan) tentang tema: "Persepsi Mahasiswa Keperawatan terhadap Praktik Klinik di Masa Pandemi".
3. Lakukan simulasi wawancara selama 10 menit.
4. Gunakan alat perekam di ponsel masing-masing.
5. Lakukan transkrip (ketik kata demi kata) dari hasil rekaman tersebut sepanjang 1 halaman

Rubrik Penilaian Wawancara Mendalam (RB-09.1)

Aspek Penilaian	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Teknik Bertanya	Pertanyaan tertutup/mengarahkan	Pertanyaan terbuka namun kaku	Pertanyaan mengalir dengan baik	Mampu melakukan *probing* yang tajam & dalam
Empati & Komunikasi	Tidak menunjukkan empati	Terlalu banyak memotong pembicaraan	Menunjukkan empati yang cukup	Membangun *rapport* yang sangat kuat & nyaman
Kualitas Transkrip	Banyak kata yang hilang	Transkrip diringkas (tidak verbatim)	Transkrip verbatim tapi tanpa catatan emosi	Transkrip sangat detail (termasuk jeda, tangis, tawa)

Aktivitas Mahasiswa (Mini Etnografi)

Tugas Mandiri:

1. Pergilah ke kantin kampus atau perpustakaan selama 30 menit.
2. Duduklah di sudut yang memungkinkan Anda melihat interaksi orang-orang di sana.
3. Buatlah **Catatan Lapangan** yang deskriptif (bukan interpretatif). Hindari kata "Mereka tampak malas", gunakan kata "Tiga orang mahasiswa menyandarkan kepala di meja dan memejamkan mata selama 10 menit".
4. Identifikasi satu pola perilaku yang Anda temukan dari hasil observasi tersebut

Rubrik Penilaian Mini Etnografi (RB-09.1)

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Ketajaman Deskripsi	Deskripsi sangat dangkal	Hanya mencatat hal umum	Deskripsi cukup detail	Deskripsi sangat kaya (panca indera)
Objektivitas	Terlalu banyak opini pribadi	Masih ada asumsi subjektif	Minim opini, fokus fakta	Murni deskriptif & objektif
Refleksivitas	Tidak ada refleksi	Refleksi sangat singkat	Ada refleksi posisi peneliti	Refleksi mendalam terkait bias

Aktivitas Mahasiswa (Simulasi FGD)

Tugas Kolaboratif:

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 8 orang.
2. Tunjuk 1 orang sebagai Moderator, 1 orang Notulis, dan 6 orang sebagai Peserta (misal: Perawat di Puskesmas).
3. Angkat tema: "Tantangan Komunikasi dengan Keluarga Pasien yang Agresif".
4. Lakukan diskusi selama 15 menit.
5. Tugas Notulis: Buatlah sosiogram sederhana (peta interaksi) yang menunjukkan siapa yang paling aktif bicara dan siapa yang pasif, serta rangkum kesepakatan kelompok yang muncul.

Rubrik Penilaian FGD (RB-09.1)

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Moderasi	Dominan bicara sendiri	Gagal mengontrol dominasi peserta	Mampu memandu diskusi dengan lancar	Sangat mahir memancing interaksi antarpeserta
Dinamika Kelompok	Tidak ada interaksi antarpeserta	Interaksi sangat terbatas	Interaksi cukup hidup	Terjadi diskusi yang kaya & saling menanggapi

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kedalaman Topik	Hanya menyentuh permukaan	Menjawab poin tanpa pengembangan	Menjelaskan alasan & konteks	Menggali makna filosofis & praktis yang mendalam

Aktivitas Mahasiswa: Simulasi Manajemen Data

Tugas Kelompok (3-4 orang):

1. Disediakan dataset mentah dalam bentuk tabel Excel yang berisi 10 baris data "kotor" (ada kesalahan ketik, usia 200 tahun, dan jenis kelamin yang tidak konsisten).
2. Tugas:
   a. Buatlah Buku Kode sederhana untuk data tersebut.
   b. Lakukan Pembersihan Data dan beri tanda (highlight) pada data yang Anda perbaiki.
   c. Susun Rencana Keamanan Data (Tuliskan di mana Anda akan menyimpan data tersebut dan bagaimana cara mengamankannya).

Rubrik Penilaian Manajemen Data (RB-09.2)

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penyusunan Codebook	Tidak ada codebook	Codebook tidak lengkap	Codebook lengkap & rapi	Codebook sangat detail & profesional
Ketelitian Cleaning	Tidak ada perbaikan data	Menemukan < 50% kesalahan	Menemukan > 80% kesalahan	Menemukan 100% kesalahan & memberi solusi
Keamanan Data	Mengabaikan privasi	Rencana keamanan lemah	Rencana keamanan logis	Rencana keamanan sangat kuat & etis

Referensi

Fein, J. A. (2017). *Reading Understanding and Applying Nursing Research Fifth Edition*. Philadelphia: F. A. Davis Company.

Gray, J. R., & Grove, S. K. (2021). *The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence* (9th ed.). Elsevier.

Jones, A., & Brown, L. (2024). Digital data management in nursing clinical trials: A protocol paper. *Journal of Advanced Nursing*, 80(4), 312-325.

Luan, M., et al. (2024). *Data integrity in healthcare education*. Nurse Education in Practice, 75, 103-112.

Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). *Foundations of Nursing Research*. United States: Pearson Education, Inc.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2022). *Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Smith, J., et al. (2023). *Framing research questions in evidence-based practice*. International Journal of Nursing Studies.

White, S., et al. (2021). *Strategies for data cleaning in large nursing datasets*. Evidence-Based Nursing.

BAB 3

ANALISIS DATA KUANTITATIF DASAR

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Analisis Data Kuantitatif Dasar	3.1 Memilih teknik analisis deskriptif dan uji dasar sesuai jenis data dan tujuan analisis.	3.2 Menginterpretasi output analisis dan melaporkan hasil secara ringkas (parameter kunci dan makna klinis).	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Ujian/penugasan rancangan metode (protocol brief)	Kesesuaian desain dengan pertanyaan dan ketepatan rencana sampling/ukuran sampel (skor rubrik).	15	Protocol brief metode
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan identifikasi isu	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik pada skenario				

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

A. Pendahuluan

Bab ini membahas konsep dasar analisis data kuantitatif dalam penelitian keperawatan sebagai bagian penting dari implementasi *Evidence-Based Nursing* (EBN). Analisis kuantitatif berperan dalam mengolah data numerik untuk mendeskripsikan fenomena kesehatan, menguji hipotesis, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara ilmiah. (dkk & Ibrahim, 2020)

Dalam praktik keperawatan modern, penggunaan analisis statistik menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, yang mengintegrasikan hasil penelitian, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien (Sudijanto, 2025)

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis data kuantitatif dalam kerangka EBN terbukti meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, termasuk peningkatan pengetahuan perawat, kepatuhan terhadap standar prosedur, serta kepuasan pasien secara signifikan ($p < 0,05$) . (Sudijanto, 2025) Namun demikian, studi terbaru juga mengungkapkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman analisis dan interpretasi data di kalangan perawat maupun mahasiswa, sehingga diperlukan penguatan kompetensi statistik dalam pendidikan keperawatan . (X, 2026)

Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari analisis deskriptif (seperti mean, median, dan standar deviasi) untuk menggambarkan karakteristik data, serta analisis inferensial dasar (seperti uji t, ANOVA, dan chi-square) untuk menguji hubungan dan perbedaan antar variabel. Pemilihan uji statistik yang tepat didasarkan pada jenis data, distribusi, dan tujuan penelitian, yang merupakan kompetensi penting dalam menghasilkan penelitian yang valid dan reliabel.

Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk menginterpretasikan hasil analisis statistik secara ilmiah dan klinis, sehingga tidak hanya memahami makna signifikansi statistik, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan implikasi praktik keperawatan. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan keperawatan yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis bukti guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (harun, Herliani, & Setyawati, 2019)

Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kompetensi analisis data kuantitatif yang sistematis, akurat, dan aplikatif dalam praktik *Evidence-Based Nursing*.

B. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep dasar analisis data kuantitatif
2. Melakukan analisis deskriptif
3. Memilih dan melakukan uji statistik inferensial dasar
4. Menginterpretasikan hasil analisis secara ilmiah dan klinis

C. Konsep Dasar Analisis Data Kuantitatif dalam keperawatan

Analisis data kuantitatif adalah proses sistematis dalam mengolah, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data numerik menggunakan teknik statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif.Dalam penelitian keperawatan, analisis ini bertujuan untuk:

- Menguji hipotesis klinis
- Menentukan hubungan antar variabel kesehatan
- Mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa analisis kuantitatif menjadi pendekatan utama dalam penelitian keperawatan karena mampu menghasilkan bukti objektif dan terukur untuk praktik klinis (Afriana, Sianturi, & Lina, 2024)

1. Karakteristik Analisis Kuantitatif

   Analisis data kuantitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

   a. Data Berbentuk Numerik

      Data berupa angka yang diperoleh dari:

      - Pengukuran klinis (tekanan darah, suhu tubuh)
      - Skor kuesioner
      - Frekuensi kejadian

   b. Menggunakan Statistik

      - Pengolahan data menggunakan
      - Statistik deskriptif
      - Statistik inferensial

      Penelitian keperawatan tahun 2024 menunjukkan bahwa analisis statistik seperti univariat dan bivariat digunakan secara luas untuk memahami karakteristik dan hubungan variabel (Padilero , Masluhiya, & Devi, 2024)

2. Peran Analisis Kuantitatif dalam Keperawatan

   Analisis kuantitatif memiliki peran penting dalam praktik keperawatan modern:

   a. Mendukung Evidence-Based Nursing (EBN)

      Data kuantitatif digunakan untuk:

      - Menentukan intervensi terbaik

- Membandingkan efektivitas terapi

b. Pengambilan Keputusan Klinis

Penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis statistik (misalnya p-value dan odds ratio) membantu perawat dalam menentukan tindakan klinis yang tepat . (Usman, Aksar, & Alim, 2024)

c. Evaluasi Kualitas Pelayanan

Analisis kuantitatif digunakan untuk:

- Mengukur kepuasan pasien
- Menilai kualitas pelayanan keperawatan

Sebagai contoh, penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien ($p < 0,05$) . (harun, Herliani, & Setyawati, 2019)

3. Jenis Data dalam Analisis Kuantitatif

Pemahaman jenis data sangat penting karena menentukan jenis uji statistik yang digunakan.

a. Data Berdasarkan Skala

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran data dalam Anlisis kuantitatif keperawatan

Skala	**Karakteristik**	**Contoh**
Nominal	Kategori tanpa urutan	Jenis kelamin
Ordinal	Ada urutan	Tingkat nyeri
Interval	Jarak sama, tanpa nol absolut	Suhu
Rasio	Memiliki nol absolut	Berat badan

b. Data Berdasarkan Distribusi

- **Normal (parametrik)** → menggunakan uji parametrik
- **Tidak normal (non-parametrik)** → menggunakan uji non-parametrik

Penelitian menunjukkan pentingnya uji normalitas sebelum analisis karena memengaruhi pemilihan uji statistik

4. Tahapan Analisis Data Kuantitatif

Berdasarkan literatur penelitian keperawatan, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap utama:

a. Data Cleaning (Manajemen Data)

1) Memeriksa data hilang (missing data)
2) Mengidentifikasi kesalahan input
3) Melakukan coding variabel

Tahap ini sangat penting karena kesalahan data dapat memengaruhi validitas hasil penelitian (Utami, 2023)

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data.

1) Ukuran Pemusatan
   a) Mean
   b) Median
   c) Modus
2) Ukuran Penyebaran
   a) Standar deviasi
   b) Range

Statistik deskriptif membantu memahami pola data sebelum dilakukan analisis lanjutan. (Akbar, suleman, & noprianty, 2020)

Contoh Keperawatan:

Rata-rata tingkat nyeri pasien sebelum dan sesudah intervensi relaksasi.

5. Uji Normalitas

Digunakan untuk menentukan jenis uji statistik selanjutnya:

a. Shapiro-Wilk
b. Kolmogorov-Smirnov

Data normal → uji parametrik

Data tidak normal → uji non-parametrik

6. Analisis Inferensial Dasar

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis.

a. Uji Perbedaan
   1) Uji t → dua kelompok
   2) ANOVA → lebih dari dua kelompok
b. Uji Hubungan
   1) Chi-square → data kategorik

Penelitian menunjukkan bahwa uji statistik menghasilkan nilai probabilitas (p-value) yang digunakan untuk menentukan signifikansi hubungan atau perbedaan. (Utami, 2023)

Contoh:

Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pasien sebelum dan sesudah terapi.

7. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi merupakan tahap penting dalam penelitian keperawatan.

a. p-value
   1) $p < 0,05$ → signifikan
   2) $p > 0,05$ → tidak signifikan

b. Confidence Interval (CI)
   1) Menunjukkan rentang estimasi
c. Effect Size
   1) Menunjukkan besar pengaruh

   Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tidak hanya bergantung pada p-value tetapi juga effect size untuk pengambilan keputusan klinis. (Utami, 2023)

8. Aplikasi dalam Evidence-Based Nursing

   Analisis kuantitatif digunakan dalam:

   a. Evaluasi intervensi keperawatan
   b. Pengembangan standar praktik klinis
   c. Pengambilan keputusan berbasis bukti

   Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan analisis kuantitatif meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien. (Kontronoulas, 2023)

9. Contoh Kasus

   Seorang perawat ingin mengetahui efektivitas terapi musik terhadap penurunan nyeri pasien. (Choeron & Nofiana, 2023)

   Langkah:

   a. Analisis deskriptif → rata-rata nyeri
   b. Uji normalitas
   c. Uji t → sebelum vs sesudah
   d. Interpretasi p-value

D. Kesimpulan

Analisis data kuantitatif terdiri dari dua komponen utama, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dan menguji hipotesis penelitian (Kontronoulas, 2023)

Pemilihan uji statistik harus disesuaikan dengan jenis data, skala pengukuran, dan distribusi data, agar hasil analisis valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Awaludin et al., 2024).

Interpretasi hasil analisis tidak hanya berfokus pada nilai statistik seperti *p-value*, tetapi juga harus dikaitkan dengan konteks klinis, sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam praktik keperawatan (Polit & Beck, 2017).

Secara keseluruhan, analisis data kuantitatif berperan penting dalam mendukung Evidence-Based Nursing (EBN), yaitu pengambilan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

LATIHAN SOAL DAN PENILAIAN

A. Soal

1. Jelaskan perbedaan antara mean dan median!
2. Kapan digunakan uji t dan ANOVA?
3. Apa perbedaan regresi linear dan regresi logistik?
4. Mengapa uji normalitas penting dalam analisis data?
5. Interpretasikan hasil berikut: p = 0,03

B. Kriteria Penilaian (Rubrik Analitik)

Skor	Kriteria
4 (Sangat Baik)	Jawaban lengkap, konsep benar, menggunakan istilah statistik dengan tepat, dan mampu mengaitkan dengan konteks keperawatan
3 (Baik)	Jawaban cukup lengkap, konsep sebagian besar benar, ada sedikit kekurangan dalam penjelasan atau aplikasi
2 (Cukup)	Jawaban kurang lengkap, konsep masih umum, belum jelas dalam konteks keperawatan
1 (Kurang)	Jawaban tidak tepat atau sangat terbatas, tidak menunjukkan pemahaman konsep

Bobot Penilaian:

- Setiap soal = 20 poin
- Total nilai maksimal = 100

Referensi

dkk, S. i., & Ibrahim, S. (2020). *Metodologi Penelitian Keperawatan.* Bandung: Media Sains Indonesia.

Sudijanto, D. A. (2025). Evaluasi Implementasi Model Keperawatan Berbasis Bukti dalam Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12-22.

X, L. W. (2026). Persepsi Perawat Tentang Evidence Based Nursing Practice (EBNP) di Rumah Sakit. *Jurnal Endurance*, 449-658.

harun, H., Herliani, Y. K., & Setyawati, A. (2019). PENGETAHUAN, SIKAP DAN KESIAPAN MAHASISWA PROGRAM PROFESI NERS DALAM PENERAPAN EVIDENCE BASED PRACTICE. *jurnal PPNI*, 177-122.

Afriana, D., Sianturi, S. R., & Lina, R. N. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis Komputer. *Dunia Keperawatan*, 126-134.

Tingkat Pengetahuan Berhubungan Dengan Praktik Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Dewasa Awal Di Wilayah Kerja Puskesmas Pakisaji. (2024). *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 322-333.

Padilero , F. F., Masluhiya, S., & Devi, H. M. (2024). Tingkat Pengetahuan Berhubungan Dengan Praktik Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Dewasa Awal Di Wilayah Kerja Puskesmas Pakisaji. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 322-333.

Usman, U., Aksar, S. M., & Alim, A. M. (2024). A Rare Case Of ib Chondroma in a 71 yea-old man. *Intisari Sains Medis*, 1175-1179.

Utami, R. A. (2023). Manajemen dan Analisis Data Penelitian Kuantitatif Kesehatan. *penelitian kuantitatif kesehatan*, 82-89.

Akbar, H., suleman, i., & noprianty, R. (2020). *Metodologi Penelitian Keperawatan.* bandung: CV media Sains Indonesia.

Kontronoulas, G. a. (2023). Data management,analysis and interpretation in quantitative research. *seminar onkologi nursing*, 899-997.

Choeron, R. C., & Nofiana, I. (2023). Kesalahan penggunaan Teknik Sampling Pada penelitian Kuantitatif di bidang Ilmu keperawatan. *Nursing News Jurnal ilmiah keperawatan*, 195-201.

BAB 4

CRITICAL APPRAISAL DAN HIRARKI BUKTI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Critical Appraisal dan Hirarki Bukti	4.1 Melakukan critical appraisal menggunakan checklist yang relevan untuk menilai risiko bias dan kualitas studi.	4.2 Menetapkan tingkat bukti dan kekuatan rekomendasi untuk keputusan praktik/penelitian lanjutan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-3

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep inti EBN/etika dan ketepatan identifikasi isu etik pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-3	Tugas telaah pustaka ringkas + matriks literatur	Reproducibility strategi pencarian (kriteria jelas) dan kualitas sintesis/kerangka konsep (skor rubrik).	15	Matriks literatur; kerangka konsep
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan identifikasi isu etik pada skenario	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

Aktivitas Belajar (*Scaffolding*)

A. Pendahuluan

Critical appraisal merupakan salah satu komponen penting dalam proses *systematic review* karena memungkinkan penelaah untuk menilai kualitas dan kredibilitas penelitian yang menjadi dasar penyusunan pengetahuan ilmiah. Pada proses *critical appraisal* peneliti tidak hanya mengumpulkan hasil penelitian yang relevan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat dipercaya dan menghasilkan temuan yang valid. *Critical appraisal* membantu memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam systematic review berasal dari penelitian yang memiliki kualitas metodologis yang baik (Dziri & Fingerhut, 2025).

Critical appraisal dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai kekuatan, keterbatasan, dan potensi bias dalam suatu penelitian dengan berfokus pada aspek metodologi yang digunakan. Tanpa adanya telaah kritis terhadap penelitian yang dikaji, pembaca akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan hasil penelitian secara tepat, khususnya dalam memahami sejauh mana temuan tersebut dapat dipercaya dan diterapkan dalam praktik. Kemampuan melakukan telaah kritis menjadi keterampilan penting bagi peneliti maupun praktisi dalam menilai kualitas bukti ilmiah yang tersedia (Kinnunen et al., 2025).

Pemahaman yang baik mengenai konsep *critical appraisal*, peranannya dalam *systematic review*, serta cara pelaksanaannya akan membantu peneliti dan pembaca memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bukti ilmiah yang ada. Hasil telaah kritis juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan dan mensintesis temuan penelitian secara lebih objektif (Amir et al., 2023). Pada bab ini akan dibahas mengenai critical appraisal yang meliputi definisi telaah kritis, manfaatnya dalam penelitian, serta berbagai isu konseptual yang dapat memengaruhi pelaksanaan proses telaah kritis.

B. Apakah Critical Appraisal itu?

Critical appraisal merupakan proses menilai secara cermat dan sistematis terhadap tingkat kepercayaan serta ketelitian suatu penelitian. Penilaian yang baik dilakukan melalui langkah yang jelas dan terstruktur bukan berdasarkan kesan umum atau persepsi peneliti. Proses ini mencakup penilaian terhadap kualitas metodologis, pertimbangan etis, dan kekuatan dasar teoretis penelitian. *Critical appraisal* dipengaruhi oleh pengalaman dan kebijaksanaan praktis penelaah yang diperoleh dari kegiatan membaca maupun melakukan penelitian. Hasil *critical*

appraisal dipengaruhi juga latar belakang peneliti, pengalaman, dan jenis kelamin dapat memengaruhi cara peneliti untuk melakukan *critical appraisal* (Tod et al., 2022).

Critical appraisal pada umumnya dibahas pada bagian hasil dan pembahasan suatu publikasi ilmiah. Penelaah sering menggunakan *checklist* untuk menjaga konsistensi dan transparansi, sehingga setiap studi dapat dinilai secara sistematis dan eksplisit. Pada penelitian kuantitatif, misalnya *checklist* dapat digunakan untuk menilai alasan penentuan besar sampel, ketepatan teknik analisis data, dan kualitas instrumen seperti kuesioner. Berbagai *checklist* telah tersedia untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif, termasuk alat untuk menilai risiko bias pada penelitian *randomized controlled trial*. Tidak semua *checklist* memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung penggunaannya, sehingga penelaah tetap perlu berhati-hati dalam memilih alat evaluasi yang tepat (Barker et al., 2022, 2025).

Critical appraisal pada penelitian *systematic review* menilai kesesuaian (*suitability*) studi terhadap tujuan tinjauan. Kesesuaian ini meliputi dua aspek utama, yaitu kesesuaian desain dan relevansi studi. Kesesuaian desain berhubungan dengan sejauh mana metode penelitian mampu menjawab pertanyaan penelitian secara tepat. Hal ini sering terlihat pada penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, misalnya ketika penelaah menilai efektivitas suatu intervensi pada studi eksperimental baik yang acak terkontrol maupun tidak (Amir et al., 2023).

Sementara itu, relevansi studi berkaitan dengan kesesuaian antara konteks penelitian yang ditinjau dengan konteks penerapan temuan pada praktik klinik. Penelaah perlu mempertimbangkan karakteristik partisipan, lingkungan penelitian, dan kondisi pengukuran variabel agar hasil sintesis benar-benar dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi praktik. Jika penelitian yang disintesis melibatkan partisipan dan situasi yang beragam, maka pembahasan mengenai relevansi menjadi sangat penting pada tahap interpretasi hasil. Kesimpulannya adalah *critical appraisal* tidak hanya menilai kualitas metodologis penelitian, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang dihasilkan benar-benar bermakna dan dapat diterapkan secara tepat dalam praktik klinik maupun pengembangan ilmu pengetahuan (Tod et al., 2022).

C. Mengapa Melakukan *Critical Appraisal*?

Tingkat kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian dipengaruhi oleh cara data diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dan bagaimana peneliti merefleksikan proses tersebut. Refleksi ini meliputi keyakinan, asumsi, dan sudut pandang peneliti yang dapat memengaruhi proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Evaluasi terhadap ketelitian metodologis, kesesuaian desain, dan relevansi studi menjadi penting untuk memastikan praktik yang benar-benar berbasis bukti dan efektif (Almutairi et al., 2024; Tod et al., 2022).

Penelitian berperan membantu praktisi klinik atau petugas kesehatan di masyarakat dalam menentukan cara terbaik untuk menolong klien secara efektif, aman, etis, dan manusiawi. Tingkat kualitas, jenis, dan penerapan penelitian sangat beragam, sehingga tidak semua temuan dapat langsung dijadikan dasar keputusan. *Critical appraisal* dapat menilai seberapa besar kepercayaan yang dapat diberikan pada suatu penelitian sebelum menggunakannya sebagai pedoman tindakan. Tanpa sikap kritis terhadap bukti ilmiah, praktisi berisiko memberikan intervensi yang tidak efektif bahkan berpotensi membahayakan klien (Waldrop et al., 2025).

Keterbatasan dalam penelitian dapat memengaruhi hasil penelitian. *Critical appraisal* membantu menilai kekuatan dan kelemahan penelitian, menentukan tingkat kepercayaan terhadap temuan, dan memberikan arahan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. *Critical appraisal* mendukung transparansi dalam menilai penelitian dengan memahami kekuatan dan keterbatasan metode yang digunakan. *Critical appraisal* membantu memastikan setiap studi dinilai dengan kriteria yang sama, sehingga prosesnya lebih terstandar. Langkah-langkah dalam proses *critical appraisal* menjadikan hasil penelitian lebih objektif, transparan, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. *Critical appraisal* dapat menilai berbagai macam bias dalam penelitian misalnya bias dalam analisis data atau saat penilaian dilakukan secara independen atau tidak (Long et al., 2020; Reynolds et al., 2026).

D. Bagaimana Melakukan *Critical Appraisal*?

1. Mengenal Struktur Artikel Ilmiah

   Model IMRAD merupakan pola penulisan artikel penelitian yang paling banyak digunakan dalam jurnal ilmiah. IMRAD adalah singkatan dari *Introduction*, *Methods*, *Results*, dan *Discussion*. Model ini menjadi kerangka berpikir dalam menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis dan transparan. Struktur artikel ini membantu peneliti menulis laporan penelitian yang dilakukan melalui proses yang jelas, memiliki metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menyajikan hasil yang dapat dievaluasi oleh pembaca atau reviewer. IMRAD sangat relevan dalam konteks *evidence-based practice* dan *critical appraisal*, sebab struktur ini membantu pembaca menilai kualitas suatu artikel secara runtut (Özkan Çelik & Al, 2024; Shen et al., 2024). Berikut penjelasan struktur artikel ilmiah:

a. Judul Artikel

Bagian yang pertama adalah Judul Artikel yang memberikan makna yang jelas mengenai apa yang telah dilakukan dalam penelitian. Judul dapat mencerminkan topik, proses, konteks penelitian, bidang kajian, lokasi, jenis penelitian, dan hasil penelitian. Proses penelitian dapat menyoroti intervensi, observasi, survei, wawancara, jenis analisis, atau alat yang digunakan untuk analisis. Peneliti sebaiknya menjaga panjang judul antara 10–12 kata, sehingga pemilihan unsur yang akan dimasukkan pada judul harus dilakukan sesuai topik penelitian. Judul artikel yang baik tidak menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami, angka, atau singkatan yang belum dikenal luas di bidang kesehatan (Kumar, 2023).

b. Abstrak

Pada bagian abstrak menjelaskan menjelaskan urgensi, relevansi, dan keberlanjutan penelitian yang dilakukan, sekaligus menyoroti celah penelitian, bidang kajian, metode, analisis, instrumen penelitian, hasil utama, dan implikasi praktis secara singkat. Sebuah abstrak yang baik menekankan motivasi penelitian, perumusan masalah, pendekatan atau cara penyelesaian masalah beserta variabel yang digunakan, hasil signifikan, serta kesimpulan yang mencakup implikasi dan keterbaruan penelitian. Abstrak juga harus mengikuti jumlah kata yang ditetapkan oleh jurnal, dan dapat disajikan secara terstruktur (misalnya Pendahuluan, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan) atau tidak terstruktur (Codina, 2022).

c. Pendahuluan

Bagian *Introduction* atau Pendahuluan berfungsi menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Pada bagian ini penulis memaparkan latar belakang masalah, menjelaskan kondisi atau fenomena yang melatarbelakangi penelitian, dan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Pendahuluan juga menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan atau masalah yang belum terjawab (*gap research*), sehingga pembaca memahami urgensi penelitian. Di akhir bagian ini dicantumkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, atau hipotesis. Pendahuluan yang baik tidak terlalu panjang, tetapi cukup jelas untuk memberikan gambaran konteks dan arah penelitian (Eriksson, 2024).

Beberapa artikel menyebutkan bahwa pada pendahuluan perlu menampilkan kerangka teori. Kerangka teori menyajikan teori atau konsep yang relevan secara detail atau kondisi terkini terkait topik penelitian. Bagian ini bisa menjadi bagian dari pendahuluan atau dibuat terpisah, tergantung standar atau ketentuan jurnal penelitian. Kajian teori ini menjelaskan

pandangan utama terkait permasalahan penelitian sekaligus menunjukkan kekurangan atau celah penelitian yang ada. Kerangka teori berguna bagi penelitian yang memerlukan tinjauan literatur mendalam, baik menggunakan metode tinjauan tradisional maupun sistematis (Eriksson, 2024; Özkan Çelik & Al, 2024).

d. Metode

Bagian *Methods* atau Metode menjelaskan bagaimana pelaksanaan penelitian dilakukan. Pada bagian ini, penulis menguraikan desain penelitian yang digunakan, misalnya deskriptif, *cross-sectional*, *cohort*, atau *randomized controlled trial*. Hal lain yang perlu diuraikan adalah subjek penelitian, bagaimana teknik pengambilan sampel dilakukan, instrumen penelitian apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, bagaimana prosedur pengumpulan, dan analisis data dilaksanakan. Penjelasan metode harus rinci agar pembaca dapat menilai apakah cara yang digunakan sudah tepat dan bebas dari kesalahan mendasar (Eriksson, 2024).

e. Hasil

Bagian *Results* atau Hasil berisi temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data. Pada bagian ini penulis menyajikan data secara objektif tanpa menambahkan interpretasi yang berlebihan. Hasil dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk memudahkan pembaca memahami temuan utama. Penyajian hasil harus sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Pada *critical appraisal*, bagian hasil menjadi fokus penting karena di sinilah pembaca menilai apakah data yang disajikan mendukung kesimpulan yang diambil (Kumar, 2023).

f. Pembahasan

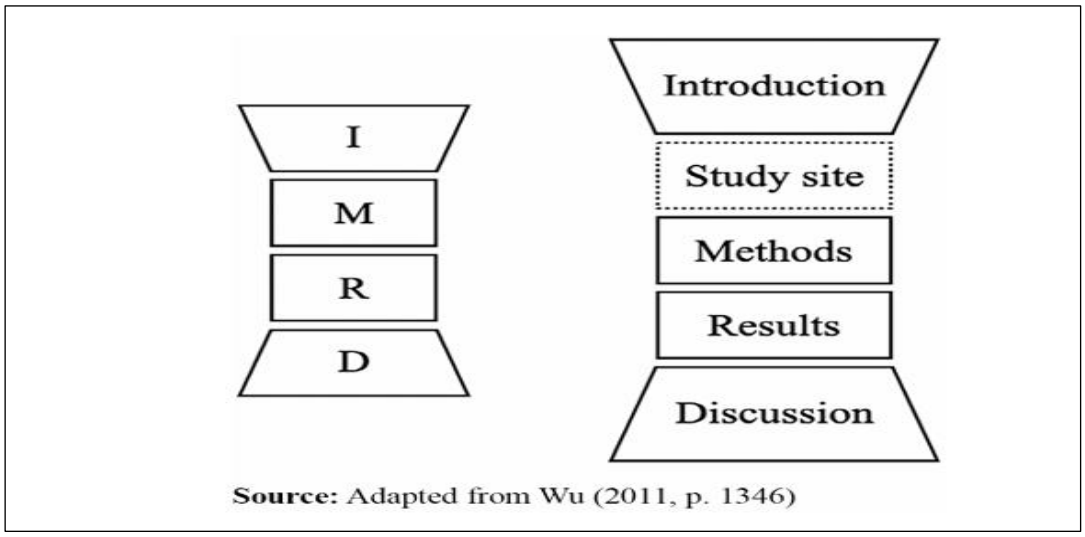
Bagian terakhir adalah *Discussion* atau pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan makna dari hasil penelitian dan mengaitkannya dengan teori maupun penelitian sebelumnya. Pembahasan menunjukkan kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu atau praktik klinis. Penulis juga menjelaskan implikasi temuan, kekuatan dan keterbatasan penelitian, serta kemungkinan pengembangan penelitian di masa mendatang. Pada beberapa jurnal, bagian kesimpulan dapat dituliskan terpisah atau menjadi bagian akhir dari pembahasan. Pembahasan yang baik tidak hanya mengulang hasil, tetapi memberikan penjelasan yang logis dan reflektif terhadap temuan penelitian.

g. Penghargaan dan Referensi

Pada bagian *Acknowledgments* dan *References* ini penulis memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian, termasuk lembaga pendanaan, institusi, dan pihak yang memberikan dukungan finansial.

Semua sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian harus dicantumkan dalam daftar pustaka dan sitasi sesuai dengan gaya yang ditetapkan oleh jurnal yang dituju. Beberapa jurnal menggunakan gaya referensi seperti *Vancouver*, APA, atau *Harvard* yang memiliki aturan khusus dalam penulisan sitasi di dalam teks maupun daftar pustaka. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti *Mendeley* atau *EndNote* untuk mempermudah pengelolaan referensi dan menjaga konsistensi format sitasi (Kumar, 2023).

IMRAD dapat digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif selama memiliki proses pengumpulan data yang jelas dan metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. IMRAD pada dasarnya menekankan keteraturan, keterlacakan, dan transparansi dalam pelaporan penelitian. Pemahaman terhadap struktur IMRAD sangat penting dalam proses *critical appraisal*, karena membantu pembaca menilai kualitas artikel secara sistematis mulai dari latar belakang hingga implikasi hasil penelitian (Codina, 2022; Kumar, 2023).



Gambar 5. 1 Struktur Artikel Ilmiah Sumber: (Eriksson, 2024)

2. Langkah-Langkah Melakukan *Critical Appraisal*

Langkah-langkah *critical appraisal* meliputi tiga poin utama antara lain menilai tingkat bukti yang disediakan studi, kualitas metodologi atau cara penelitian dilakukan, dan kegunaan studi untuk praktik klinis. Studi yang dianggap layak kemudian akan dilanjutkan ke tahap evaluasi dan sintesis. Pada tahap sintesis temuan dari berbagai studi digabungkan untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat membantu meningkatkan hasil layanan kesehatan. Setelah mengumpulkan penelitian, tim *evidence-based practice* menentukan tingkat bukti dengan mengelompokkan penelitian berdasarkan desain penelitian,

seperti *systematic review*, *randomized controlled trial*, *cohort*, kualitatif, dan deskriptif (Kumar, 2023; Santesso et al., 2020). Berikut tingkatan bukti pada desain penelitian:

Tabel 5. 1 *Level of Evidence* Penelitian Sumber: Kumar (2023)

Tipe Bukti	***Level of Evidence***	**Deskripsi**
Systematic review atau meta-analisis	I	Sintesis bukti dari semua *randomized controlled trials* yang relevan.
Randomized controlled trial	II	Eksperimen dengan subjek diacak ke kelompok perlakuan atau kontrol.
Controlled trial tanpa randomisasi	III	Eksperimen dengan subjek secara non-acak ditempatkan pada kelompok perlakuan atau kontrol.
Case-control atau *cohort study*	IV	*Case-control:* membandingkan subjek dengan kondisi tertentu (kasus) dan tanpa kondisi (kontrol) untuk menentukan karakteristik yang mungkin memprediksi kondisi. *Cohort:* mengamati satu atau beberapa kelompok untuk menentukan perkembangan hasil tertentu, seperti penyakit.
Systematic review dari studi kualitatif atau deskriptif	V	Sintesis bukti dari studi kualitatif atau deskriptif untuk menjawab pertanyaan klinis.
Qualitative atau *descriptive study*	VI	Studi kualitatif: mengumpulkan data perilaku manusia untuk memahami mengapa dan bagaimana keputusan dibuat. Studi deskriptif: memberikan informasi dasar tentang apa, di mana, dan kapan suatu topik terjadi.
Expert opinion atau *consensus*	VII	Pendapat otoritatif dari komite ahli.

Pada proses *critical appraisal*, tim menggunakan *checklist* penilaian kritis untuk mengevaluasi studi, yang berisi pertanyaan tentang elemen penting penelitian, seperti tujuan studi, ukuran sampel, dan validitas serta reliabilitas instrumen variabel utama. Fokus awal penilaian adalah menjawab tiga pertanyaan

utama: mengapa studi dilakukan, berapa ukuran sampelnya, dan apakah instrumen variabel utama valid dan reliabel. Data dari setiap studi kemudian dicatat dalam tabel evaluasi studi, yang memudahkan pencatatan elemen penting dan membantu proses *critical appraisal* terhadap studi-studi yang dianalisis (Almutairi et al., 2024).

Pada proses *critical appraisal*, tim menggunakan *checklist* penilaian kritis untuk mengevaluasi studi, yang berisi pertanyaan tentang elemen penting penelitian, seperti tujuan studi, ukuran sampel, dan validitas serta reliabilitas instrumen variabel utama. *Checklist* yang sering digunakan dalam proses telaah kritis antara lain dari *Joanna Briggs Institute* (JBI), yang menyediakan berbagai instrumen penilaian untuk desain penelitian yang berbeda seperti studi kualitatif, *cross-sectional*, *cohort*, dan *randomized controlled trial*. Panduan dan *checklist* tersebut dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi JBI pada alamat https://jbi.global/critical-appraisal-tools, sehingga peneliti dapat memilih instrumen *appraisal* yang sesuai dengan jenis studi yang ditelaah (Barker et al., 2022, 2025; Evans et al., 2025). Berikut langkah-langkah *critical appraisal*:

a. Menilai Kesesuaian Pertanyaan Penelitian dengan Tujuan Penelitian

   Langkah pertama dalam *critical appraisal* adalah memastikan pertanyaan penelitian relevan, spesifik, jelas, dan sesuai dengan tujuan studi. Pertanyaan penelitian yang baik mampu menghasilkan jawaban yang mendalam terhadap masalah yang dikaji. Pertanyaan penelitian yang relevan dapat memberikan dampak pada praktik klinis, seperti meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki luaran layanan kesehatan, dan mendorong perubahan dalam prosedur atau protokol. Peneliti perlu memastikan bahwa pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan tetap berkaitan dengan masalah yang diteliti (Tod et al., 2022).

b. Menilai Keunikan (*Novelty*) Dibandingkan dengan Penelitian Terdahulu

   Pada proses *critical appraisal*, peneliti menilai apakah suatu penelitian memberikan kontribusi baru terhadap bukti ilmiah yang sudah ada. Penilai mengevaluasi relevansi pertanyaan penelitian dan menilai apakah studi tersebut menghasilkan temuan, wawasan, atau pengetahuan baru di bidang yang diteliti. Penilai juga mengajukan pertanyaan penting seperti apakah penelitian tersebut menambahkan informasi baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti dan praktisi dapat menentukan nilai, keaslian, serta kontribusi penelitian dalam memperkaya literatur dan pengetahuan yang sudah ada (Waldrop et al., 2025).

c. Memahami Berbagai Desain Penelitian dan Perbedaannya

Pada *critical appraisal*, langkah penting adalah memahami desain studi dan kemampuannya untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat. Penilaian ini mencakup apakah studi telah menghindari bias dan faktor perancu yang umum terjadi, baik pada studi observasional maupun pada penelitian eksperimen dengan kelompok perlakuan dan kontrol. Penilai mengkaji bias penelitian yang memengaruhi validitas penelitian sebelum menilai hasilnya akan mempermudah proses *critical appraisal* (Polit & Beck, 2018).

Hubungan sebab-akibat dapat dinilai lebih baik jika studi menggunakan desain yang kuat dan jelas. Desain yang lemah memungkinkan banyak bias penelitian, sehingga sulit menentukan hubungan sebab-akibat. Studi eksperimental *double-blind*, *placebo-controlled* umumnya dianggap desain terbaik; sedangkan studi observasional *double-blind* merupakan desain yang paling dapat diandalkan dalam konteks observasional (Salmond & Bennett, 2021).

Setelah desain studi ditentukan, dapat dinilai apakah jenis studi yang digunakan paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi klinis dapat berupa *cohort* untuk mengikuti kelompok pasien dari waktu ke waktu, atau *case-control* untuk membandingkan kelompok pasien dengan karakteristik tertentu. Pemahaman tentang berbagai desain studi memberikan kerangka awal yang penting untuk menilai kekuatan dan kelemahan studi (Almutairi et al., 2024; Polit & Beck, 2018).

Penting untuk membedakan antara studi eksperimen dan observasional. Pada studi eksperimen, peneliti melakukan intervensi untuk mengubah jalannya peristiwa; sedangkan pada studi observasional, peneliti hanya mengamati peristiwa yang terjadi secara alami. Setiap desain memiliki kelebihan dan keterbatasan, serta validitas dan kemampuan generalisasi temuan harus dinilai sesuai desainnya. Studi yang kuat secara desain sering kali memberikan informasi lebih dapat diandalkan dibandingkan studi kompleks dengan desain lemah (Almutairi et al., 2024).

Pada tahap ini penting juga untuk menilai apakah studi mempertimbangkan *confounding*, yaitu variabel yang dapat memengaruhi hubungan antara paparan dan hasil, sehingga dapat diketahui bias interpretasi hubungan sebab-akibat. Pada *randomized controlled trial*, *confounding* dapat dikendalikan melalui pembatasan kriteria inklusi dan eksklusi atau stratifikasi; sedangkan pada studi observasional dapat dikendalikan dengan penyesuaian variabel *confounding* atau analisis multivariat. Pemahaman tentang cara studi menangani bias dan *confounding* membantu menilai kekuatan penelitian dan

efektivitas metode yang digunakan. Penelitian yang baik mampu menjelaskan langkah-langkah secara jelas agar pembaca dapat memahami sejauh mana bias telah dikurangi dan apakah hubungan antara paparan dan hasil dapat dipercaya (Almutairi et al., 2024).

d. Menilai Penyimpangan Pelaksanaan Penelitian dengan Rencana Protokol Penelitian

Pada tahap ini, penilai mengkaji penyimpangan dari rencana protokol penelitian. Penilai menentukan apakah penyimpangan tersebut dapat menyebabkan kesalahan tipe II, yaitu hasil negatif palsu yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara intervensi dan kontrol padahal sebenarnya ada efek positif. Kesalahan tipe II dapat terjadi jika penyimpangan menyebabkan hilangnya kekuatan statistik, misalnya melalui perubahan kriteria inklusi atau eksklusi, perubahan besar sampel, dan analisis statistik dapat memengaruhi kekuatan penelitian (Almutairi et al., 2024; Tod et al., 2022).

Penilaian dampak penyimpangan sebaiknya dilakukan dalam kerangka pengujian hipotesis, di mana hipotesis nol menyatakan bahwa penyimpangan tidak memengaruhi hasil studi. Hipotesis alternatif dapat disesuaikan dengan jenis penyimpangan yang diuji, misalnya menyatakan bahwa penyimpangan tersebut telah mengubah hasil sehingga mendukung intervensi. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana perubahan protokol memengaruhi validitas dan interpretasi hasil penelitian (Kinnunen et al., 2025; Santhanam et al., 2025).

e. Mengidentifikasi Hipotesis Penelitian

Pada tahap ini penilai mengidentifikasi hipotesis yang berasal dari teori atau pengalaman sebelumnya. Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus studi. Hipotesis penelitian mampu memungkinkan pengujian teori yang ada, memprediksi hubungan yang diharapkan antar fenomena, dan mengurangi risiko *false positive*. Hipotesis penelitian menjadi dasar penting untuk menentukan validasi hasil penelitian. Hipotesis membantu peneliti menjelaskan hubungan yang jelas antara suatu fenomena, sehingga peneliti dapat melakukan pengujian empiris serta mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian (Almutairi et al., 2024; Waldrop et al., 2025).

f. Menilai Ketepatan Analisis Data

Analisis statistik penting untuk menafsirkan data dan memperoleh kesimpulan yang bermakna. Pada tahap ini dinilai kesesuaian metode statistik dengan desain studi, pertanyaan penelitian, dan karakteristik data. Menilai kesesuaian analisis statistik membantu memastikan bahwa hasil yang

diperoleh valid dan dapat diandalkan (Polit & Beck, 2018; Quan et al., 2023; Stone et al., 2023).

Metode statistik disesuaikan desain penelitian. Pada penelitian *randomized controlled trial* (RCT), analisis data yang digunakan pada umumnya adalah t-independen untuk menilai perbandingan rata-rata antara dua kelompok perlakuan. Pada penelitian *case-control*, hubungan antara paparan dan hasil dianalisis menggunakan regresi logistik untuk memperkirakan *odds ratio* dan variabel *convounding*. Pada penelitian *cross-sectional*, analisis *chi-square* digunakan untuk menilai hubungan antara dua variabel. Dengan memilih metode statistik yang tepat, peneliti dapat memastikan hasil studi mencerminkan hubungan yang sebenarnya dalam data (Polit & Beck, 2018; Quan et al., 2023).

Pada penilaian analisis statistik, penilai perlu memeriksa apakah asumsi statistik seperti normalitas data telah terpenuhi. Jika asumsi tidak terpenuhi, peneliti dapat menggunakan teknik alternatif, misalnya uji non-parametrik atau transformasi variabel, agar inferensi tetap akurat. Penilai juga perlu mengkaji transparansi dalam melaporkan cara menangani data yang hilang, misalnya melalui analisis kasus lengkap, imputasi, atau analisis sensitivitas untuk menjaga integritas hasil penelitian. Pada penelitian yang melakukan banyak uji statistik atau menganalisis banyak luaran, penilai perlu mengkaji apakah terdapat penyesuaian untuk *multiple testing* seperti *Bonferroni correction* untuk mengontrol risiko *false positive* (Dahlan, 2021; Evans et al., 2025).

Langkah terakhir adalah menilai kesesuaian interpretasi temuan statistik dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Hal ini meliputi ukuran efek, interval kepercayaan, dan nilai p diinterpretasikan dengan benar, dan didukung data penelitian. Penilaian analisis statistik secara menyeluruh bertujuan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas hasil penelitian (Almutairi et al., 2024; Dahlan, 2020).

g. Menilai Kesimpulan Berdasarkan Data Penelitian

Pada proses *critical appraisal*, penilai mengkaji apakah kesimpulan penelitian didukung oleh data, tujuan, hasil, dan diskusi penelitian. Kesimpulan mencakup temuan utama, justifikasi dari hasil analisis, dan rekomendasi studi. Data yang digunakan dapat berupa data demografi, frekuensi, korelasi, temuan visual, atau analisis komparatif. Kesimpulan yang baik mencerminkan temuan data dan analisis penelitian. Pemeriksaan kesimpulan harus dilakukan setelah menilai bagian hasil untuk memastikan kesesuaian dan keandalan temuan (Almutairi et al., 2024; Özkan Çelik & Al, 2024).

h. Konflik Kepentingan

Pada proses *critical appraisal* perlu mengkaji kemungkinan *conflict of interest* atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan seperti hubungan keuangan atau afiliasi industri dapat memengaruhi hasil penelitian dan kualitas publikasi. Penelitian seharusnya mengungkapkan konflik kepentingan untuk menjaga transparansi dan integritas penelitian. Konflik kepentingan perlu diperhitungkan untuk menjamin keamanan subjek dan meninjau literatur. Peneliti harus mengenali dan melaporkan setiap potensi konflik yang dapat memengaruhi pemilihan studi maupun keabsahan temuan (Almutairi et al., 2024).

i. Pertimbangan Etik Penelitian

Penilai perlu mempertimbangkan aspek etika seperti menyajikan karya orang lain secara jujur, menjaga makna asli dari kutipan, dan menghindari plagiarisme melalui penggunaan parafrasa dengan kata-kata sendiri. Penting juga untuk memastikan kredibilitas sumber dengan merujuk pada artikel dan buku yang telah ditinjau. Penilai perlu mempertimbangkan apakah peneliti mempertahankan sikap tidak bias dengan meninjau seluruh literatur yang relevan dan menjelaskan kekurangan area yang masih menjadi perdebatan dalam penelitian (Almutairi et al., 2024; Kumar, 2023).

j. Peningkatan Kualitas *Critical Appraisal* di Bidang Kesehatan Melalui *Artificial Intelligence* (AI)

Penggunaan AI pada proses *critical appraisal* semakin mengubah cara menilai bukti dalam praktik berbasis bukti. Teknologi AI, seperti *machine learning* dan *natural language processing*, digunakan untuk mengidentifikasi pola, menilai integritas statistik, dan mengevaluasi kesesuaian temuan dan proses penelitian dengan cepat. Hal ini mempercepat proses penilaian dan meningkatkan akurasi dan kelengkapan evaluasi, sehingga profesional kesehatan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti berkualitas tinggi (Almutairi et al., 2024).

Tabel 5. 2 Fokus *Critical* Appraisal Penelitian Sumber: Almutairi et al. (2024)

Komponen Penelitian	Deskripsi/Fokus Penilaian
Overview of the Paper	Periksa jurnal penerbit, tahun, judul artikel, penulis, institusi, dan apakah ada proses *peer review*.
Abstract	Evaluasi kejelasan tujuan studi dan metode; pastikan pertanyaan penelitian jelas dengan fokus pada peserta, intervensi, perbandingan, hasil, dan desain studi (PICOS).

Komponen Penelitian	Deskripsi/Fokus Penilaian
Methods	Periksa kriteria kelayakan studi, sumber informasi, strategi pencarian, proses seleksi studi, metode ekstraksi data, dan penilaian risiko bias.
Results	Tinjau detail seleksi studi, karakteristik studi, risiko bias dalam studi, hasil meta-analisis, dan metode analisis tambahan.
Discussion	Analisis ringkasan temuan utama, pembahasan keterbatasan studi dan luaran, dan interpretasi hasil dalam konteks bukti lain.
Funding	Periksa sumber dan peran pendana untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan.
Additional Considerations	Tinjau relevansi pertanyaan penelitian, kontribusi studi terhadap bukti baru, kecocokan desain dengan pertanyaan penelitian, kontrol bias, kesesuaian analisis statistik, validitas kesimpulan, konflik kepentingan, dan manfaat hasil untuk praktik klinis.

A. Aktivitas 2 — *Shows How*

Mini Case: Pencegahan Nyeri pada Anak Saat Imunisasi

Kasus

Seorang anak laki-laki berusia 12 bulan datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Ibu anak tersebut mengatakan bahwa pada imunisasi sebelumnya anak menangis sangat keras dan tampak sangat kesakitan setelah penyuntikan. Perawat ingin menggunakan metode nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri selama prosedur imunisasi, seperti pemberian distraksi atau menyusui sebelum tindakan.
Seorang perawat menemukan sebuah artikel penelitian yang meneliti efektivitas teknik distraksi dalam mengurangi nyeri pada anak saat imunisasi. Sebelum menerapkan intervensi tersebut, perawat perlu menilai kualitas penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dipercaya dan diterapkan dalam praktik keperawatan. Perawat mengidentifikasi intervensi keperawatan untuk menangani kasus tersebut.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut. Pertanyaan Diskusi:

1. Cari satu artikel penelitian jurnal yang relevan dengan topik keperawatan anak (misalnya kecemasan anak saat hospitalisasi, manajemen nyeri, atau terapi bermain).
2. Unduh artikel *full text* dan baca secara menyeluruh bagian berikut: Pendahuluan; Metode penelitian; Hasil penelitian; Pembahasan; Kesimpulan; Penghargaan; Konflik Kepentingan; Pertimbangan Etik; dan Referensi.
3. Tentukan desain penelitian yang digunakan pada artikel tersebut (misalnya *randomized controlled trial*, *cohort study*, *case-control*, atau *cross-sectional*).
4. Pilih *checklist critical appraisal* dari JBI yang sesuai dengan desain penelitian. Checklist JBI dapat diakses pada: https://jbi.global/critical-appraisal-tools
5. Tentukan *level of evidence* penelitian.

Simulasi *Critical Appraisal* Artikel Penelitian

Fokus kegiatan pada:

1. memahami struktur artikel penelitian
2. menilai kualitas metodologi penelitian
3. mengidentifikasi bias penelitian
4. menentukan kekuatan bukti (*level of evidence*)
5. menilai kelayakan penerapan hasil penelitian dalam praktik kesehatan

Mahasiswa berlatih melakukan *critical appraisal* secara sistematis menggunakan *checklist* JBI melalui analisis artikel penelitian.

Catatan untuk penulis:

1. Kegiatan pembelajaran tidak langsung menuju penilaian akhir.
2. Mahasiswa terlebih dahulu memahami konsep *critical appraisal*, kemudian berlatih menilai artikel penelitian sebelum dilakukan asesmen.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	**Metode**
Knows/Knows How	*Self-check* konsep *critical appraisal* + analisis *mini case* artikel penelitian
Shows How	*Critical appraisal* artikel penelitian menggunakan *checklist* JBI + presentasi hasil

Catatan untuk Penulis:

1. Kegiatan pembelajaran tidak langsung menuju penilaian akhir.
2. Mahasiswa terlebih dahulu memahami konsep *critical appraisal*, kemudian berlatih menilai artikel penelitian sebelum dilakukan asesmen.

***Critical Items* (Wajib Lulus)**

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila tidak mampu:

1. Mengidentifikasi desain penelitian dengan benar.
2. Menggunakan *checklist JBI* sesuai desain penelitian.
3. Mengidentifikasi potensi bias penelitian.
4. Menentukan *level of evidence* penelitian.

Cuplikan Rubrik Penilaian

Kriteria	4	3	2	1
Identifikasi desain penelitian	Tepat dan jelas	Tepat	Kurang tepat	Salah
Analisis kualitas penelitian	Sistematis dan lengkap	Cukup	Terbatas	Tidak dianalisis
Penggunaan *checklist* JBI	Lengkap dan benar	Cukup	Tidak lengkap	Tidak sesuai
Interpretasi hasil penelitian	Kritis dan jelas	Cukup	Kurang tepat	Keliru

Catatan untuk Penulis:

1. Pada tahap ini menilai kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menilai artikel penelitian.
2. Penilaian difokuskan pada analisis metodologi penelitian dan kekuatan bukti ilmiah.
3. Aktivitas ini sesuai dengan kompetensi *Evidence-Based Practice* dalam pendidikan kesehatan.

Penugasan *Critical Appraisal*

No	Komponen	Isi
1	Judul tugas	*Critical Appraisal* Artikel Penelitian Kesehatan
2	Waktu	30–45 menit
3	Tujuan	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan *critical appraisal* artikel penelitian menggunakan checklist JBI.
4	Kompetensi	1. Analisis artikel ilmiah 2. *Critical appraisal* 3. Penentuan *level of evidence* 4. Interpretasi hasil penelitian
5	Instruksi mahasiswa	Mahasiswa membaca artikel penelitian yang diberikan dan melakukan *critical appraisal* menggunakan *checklist* JBI.
6	Tugas mahasiswa	1. Identifikasi tujuan penelitian 2. Tentukan desain penelitian 3. Analisis metodologi penelitian

		4. Identifikasi bias penelitian 5. Nilai kesesuaian kesimpulan dengan data 6. Tentukan *level of evidence*
7	Penilaian	Berdasarkan ketepatan analisis menggunakan rubrik penilaian.

FORM PENILAIAN *CRITICAL APPRAISAL* ARTIKEL PENELITIAN

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Identifikasi masalah dan tujuan penelitian	Mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian pada artikel.					1	
2	Identifikasi desain penelitian	Menentukan desain penelitian yang digunakan secara tepat.					2	
3	Analisis metodologi penelitian	Menilai kesesuaian metode penelitian, teknik pengambilan sampel, dan prosedur penelitian.					3	
4	Identifikasi potensi bias dan keterbatasan	Mampu mengidentifikasi kemungkinan bias penelitian dan keterbatasan studi.					2	
5	Interpretasi hasil penelitian	Menganalisis apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan yang ditarik oleh peneliti.					2	
6	Penentuan level of evidence	Menentukan *level of evidence* berdasarkan hierarki bukti penelitian.					2	

Jumlah	**12**	



Nilai Akhir = (Jumlah Skor/36) x 100

DESKRIPSI PERFORMA TIAP SKOR

Kompetensi	**Skor 0**	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**
Identifikasi masalah dan tujuan penelitian	Tidak mampu mengidentifikasi tujuan penelitian	Mengidentifikasi tujuan tetapi tidak jelas atau tidak tepat	Mengidentifikasi tujuan penelitian cukup tepat tetapi belum lengkap	Mengidentifikasi tujuan penelitian secara tepat, jelas, dan lengkap
Identifikasi desain penelitian	Tidak mampu menentukan desain penelitian	Menyebutkan desain tetapi tidak tepat	Menentukan desain cukup tepat namun penjelasan kurang lengkap	Menentukan desain penelitian secara tepat dan mampu menjelaskan karakteristiknya
Analisis metodologi penelitian	Tidak melakukan analisis metodologi	Analisis sangat terbatas dan tidak sistematis	Analisis cukup baik tetapi belum lengkap	Analisis metodologi secara sistematis, kritis, dan lengkap
Identifikasi bias penelitian	Tidak mampu mengidentifikasi bias	Mengidentifikasi bias sangat terbatas	Mengidentifikasi beberapa bias namun belum lengkap	Mengidentifikasi potensi bias secara jelas dan lengkap
Interpretasi hasil penelitian	Tidak mampu menginterpretasikan hasil penelitian	Interpretasi sangat terbatas dan tidak tepat	Interpretasi cukup tepat namun kurang mendalam	Interpretasi hasil penelitian secara kritis dan logis

Penentuan level *of evidence*	Tidak mampu menentukan *level evidence*	Menentukan *level evidence* tetapi tidak tepat	Menentukan *level evidence* cukup tepat	Menentukan *level evidence* secara tepat sesuai hierarki bukti

DOPS (Does) pada Critical Appraisal

DOPS di Lahan Akademik/Praktik Evidence-Based Practice

1. Observasi langsung kemampuan mahasiswa melakukan *critical appraisal* artikel penelitian.
2. Menggunakan *checklist critical* appraisal dari JBI.
3. Disertai umpan balik singkat dari dosen/pembimbing.
4. Keputusan penilaian: kompeten/perlu supervisi/remedial.

Catatan untuk penulis

1. Pembelajaran bergerak dari analisis simulasi artikel → diskusi ilmiah nyata.
2. Memberikan bukti autentik kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam *evidence-based practice.*

PENERAPAN DOPS PADA *CRITICAL APPRAISAL*

Komponen	**Deskripsi**	***Critical Appraisal***
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa mahasiswa saat melakukan tugas akademik atau klinik.	Dosen mengamati secara langsung mahasiswa ketika melakukan analisis artikel penelitian menggunakan *checklist* JBI.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan metodologi penelitian, analisis kritis, dan interpretasi hasil penelitian.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori penelitian, tetapi mampu menilai kualitas metodologi penelitian dan kekuatan bukti ilmiah.
Kasus/materi	Materi diambil dari artikel penelitian kesehatan yang	Mahasiswa menganalisis artikel penelitian tentang

Komponen	Deskripsi	*Critical Appraisal*
	relevan dengan praktik klinik.	intervensi keperawatan pada pasien tertentu menggunakan *checklist* JBI.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan analisis artikel secara sistematis mulai dari identifikasi tujuan penelitian sampai penentuan *level of evidence.*	Mahasiswa membaca artikel, mengidentifikasi desain penelitian, menilai metodologi, mengidentifikasi potensi bias, dan menyimpulkan kekuatan bukti penelitian.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan analisis metodologi penelitian, identifikasi bias, interpretasi hasil penelitian, dan penentuan *level of evidence*.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menilai validitas penelitian, kesesuaian metode analisis data, serta relevansi hasil penelitian terhadap praktik keperawatan.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas proses berpikir kritis mahasiswa dalam menilai artikel penelitian.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil penelitian dengan praktik berbasis bukti dalam keperawatan.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah proses observasi untuk memperbaiki kemampuan analisis mahasiswa.	Dosen dapat memberikan masukan terkait cara mengidentifikasi bias penelitian atau menilai kekuatan bukti penelitian.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan *critical appraisal* secara sistematis dan tepat.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian	Mahasiswa tidak hanya memahami teori *evidence-based practice* tetapi mampu menerapkan *critical appraisal*

Komponen	Deskripsi	*Critical Appraisal*
	pembelajaran pada level **Does** dalam piramida Miller.	dalam menilai artikel penelitian secara mandiri.

PORTOFOLIO

Tabel 5. 3 Portofolio Critical Appraisal

Komponen	Deskripsi	Contoh
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan *critical appraisal* artikel penelitian.	Mahasiswa mengumpulkan beberapa hasil analisis artikel penelitian kesehatan yang telah dinilai menggunakan *checklist* JBI.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam menilai kualitas penelitian dan kekuatan bukti ilmiah.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan menilai validitas metodologi penelitian dan relevansi hasil penelitian terhadap praktik kesehatan.
Analisis artikel	Mahasiswa melakukan *critical appraisal* artikel secara sistematis.	Mahasiswa mengidentifikasi desain penelitian, metode sampling, potensi bias, dan kesesuaian analisis data.
Refleksi pembelajaran	Mahasiswa menuliskan pembelajaran yang diperoleh dari proses *appraisal*.	Mahasiswa menyadari pentingnya menilai kualitas metodologi sebelum menggunakan hasil penelitian sebagai dasar praktik.
Feedback dosen	Dosen memberikan masukan terkait kualitas analisis mahasiswa.	Dosen menyarankan mahasiswa memperdalam analisis bias dan

		interpretasi hasil penelitian.
Makna dalam OBE	Portofolio menunjukkan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan prinsip *evidence-based practice*.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori penelitian tetapi mampu menilai kualitas bukti ilmiah secara kritis.

E. RINGKASAN

Critical appraisal merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas, kredibilitas, dan relevansi suatu penelitian sebelum hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah maupun praktik klinis. *Critical appraisal* berperan penting untuk memastikan bahwa bukti yang disintesis berasal dari penelitian dengan kualitas metodologis yang baik. Pada proses *critical appraisal*, penelaah tidak hanya mengumpulkan hasil penelitian yang relevan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana metode yang digunakan dapat dipercaya serta mampu menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Critical appraisal juga dapat dipahami sebagai proses evaluasi terhadap kekuatan, keterbatasan, serta potensi bias dalam suatu penelitian. Penilaian dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek metodologi, pertimbangan etis, serta dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Tanpa adanya telaah kritis, pembaca akan kesulitan menafsirkan hasil penelitian secara tepat, khususnya dalam menentukan apakah temuan tersebut dapat dipercaya dan diterapkan dalam praktik. Kemampuan melakukan *critical appraisal* menjadi keterampilan penting bagi peneliti maupun praktisi kesehatan dalam menilai kualitas bukti ilmiah.

Pada saat melakukan *critical appraisal*, pemahaman terhadap struktur artikel ilmiah sangat penting. Sebagian besar artikel penelitian mengikuti model IMRAD yang terdiri dari *Introduction*, *Methods*, *Results*, dan *Discussion*. Struktur ini membantu pembaca menilai kualitas penelitian secara sistematis mulai dari latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, hingga interpretasi temuan penelitian. Artikel ilmiah juga memuat judul, abstrak, serta bagian *acknowledgments* dan *references* yang menjelaskan dukungan penelitian dan sumber referensi yang digunakan.

Proses *critical appraisal* umumnya dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, penilai menilai kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian untuk memastikan bahwa studi yang dilakukan relevan dan mampu

menjawab masalah yang diteliti. Kedua, penilai mengevaluasi keunikan atau kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang telah ada. Ketiga, penilai memahami desain penelitian yang digunakan serta menilai kekuatan dan keterbatasannya dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat. Penilai juga menilai kemungkinan adanya bias dan faktor perancu yang dapat memengaruhi validitas hasil penelitian.

Langkah berikutnya meliputi penilaian terhadap kemungkinan penyimpangan dari protokol penelitian, identifikasi hipotesis penelitian, serta evaluasi kesesuaian metode analisis data dengan desain penelitian dan karakteristik data. Penilai juga perlu menilai apakah kesimpulan penelitian didukung oleh data dan hasil analisis yang disajikan. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan konflik kepentingan serta pertimbangan etika penelitian yang dapat memengaruhi integritas studi.

Pada praktik *evidence-based practice*, *critical appraisal* sering dilakukan menggunakan *checklist* penilaian yang membantu menjaga konsistensi dan transparansi dalam proses evaluasi penelitian. Salah satu *checklist* yang banyak digunakan adalah instrumen dari JBI yang menyediakan berbagai alat penilaian untuk berbagai desain penelitian seperti studi kualitatif, *cross-sectional*, *cohort*, dan *randomized controlled trial*.

Kesimpulan dari uraian di atas, *critical appraisal* bertujuan memastikan bahwa bukti ilmiah yang digunakan dalam praktik kesehatan memiliki kualitas yang baik, bebas dari bias yang signifikan, dan relevan dengan konteks praktik. Peneliti dan praktisi dapat membuat keputusan yang lebih objektif, transparan, dan berbasis bukti dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. *Critical appraisal* membantu praktisi memilih penelitian yang valid dan berkualitas dalam penyelesaian masalah kesehatan.

Tabel 5. 4 Red Flags dan Eskalasi

Red Flags	**Makna Akademik/Metodologis**	**Tindakan Eskalasi**
Tujuan penelitian tidak jelas atau tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian.	Penelitian memiliki fokus yang tidak jelas sehingga sulit menilai relevansi hasil penelitian.	Mahasiswa mendiskusikan kembali dengan dosen atau kelompok untuk memperjelas fokus penelitian sebelum melanjutkan *appraisal.*
Desain penelitian tidak disebutkan dengan jelas.	Pembaca tidak dapat menilai kesesuaian metode penelitian dengan tujuan penelitian.	Mahasiswa mencari informasi tambahan pada bagian metode atau sumber lain dan mendiskusikannya dengan dosen.
Metode pengambilan sampel tidak dijelaskan.	Validitas hasil penelitian sulit dinilai karena tidak diketahui bagaimana sampel dipilih.	Mahasiswa mencatat keterbatasan tersebut sebagai potensi bias dalam penelitian.
Ukuran sampel sangat kecil tanpa penjelasan.	Hasil penelitian mungkin tidak representatif dan memiliki kekuatan bukti yang rendah.	Mahasiswa menandai hal tersebut sebagai keterbatasan dalam interpretasi hasil.
Analisis data tidak dijelaskan dengan jelas.	Pembaca tidak dapat menilai apakah analisis yang digunakan sudah sesuai.	Mahasiswa mendiskusikan metode analisis dengan dosen atau referensi metodologi penelitian.
Hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian.	Terdapat ketidakkonsistenan antara tujuan, hasil, dan pembahasan penelitian.	Mahasiswa mengidentifikasi inkonsistensi tersebut sebagai kelemahan penelitian.
Kesimpulan tidak didukung oleh data penelitian.	Peneliti menarik kesimpulan yang tidak sepenuhnya didukung oleh hasil penelitian.	Mahasiswa mencatat hal tersebut dalam bagian kritik atau evaluasi penelitian.
Tidak ada pembahasan mengenai keterbatasan penelitian.	Penelitian tidak transparan dalam menjelaskan kekurangan studi.	Mahasiswa mengidentifikasi sendiri kemungkinan keterbatasan penelitian.

Tidak disebutkan pertimbangan etika penelitian.	Integritas penelitian dapat dipertanyakan.	Mahasiswa mendiskusikan kemungkinan implikasi etika dengan dosen atau kelompok.
Tidak ada sumber pendanaan atau konflik kepentingan.	Ada kemungkinan bias yang tidak dilaporkan dalam penelitian.	Mahasiswa mencatat potensi konflik kepentingan sebagai bagian dari evaluasi penelitian.

Form Checklist

"Saya Sudah Bisa..."

Bab :
Nama Mahasiswa :
NIM :
Tanggal :
Mata Kuliah :

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian *critical appraisal* dalam penelitian kesehatan.	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan melakukan *critical appraisal* terhadap artikel penelitian.	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi pertanyaan penelitian dalam suatu artikel ilmiah.	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menentukan tujuan penelitian yang terdapat dalam artikel.	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi desain penelitian yang digunakan dalam artikel.	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menilai kesesuaian metode penelitian dengan tujuan penelitian.	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi metode pengambilan sampel dalam penelitian.	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi potensi bias dalam penelitian.	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menilai kesesuaian analisis data dengan desain penelitian.	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menilai apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan peneliti.	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mengidentifikasi keterbatasan penelitian yang dilaporkan oleh peneliti.	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan *level of evidence* dari penelitian yang dianalisis.	☐	☐	_____

13	Saya sudah bisa menggunakan *checklist* atau panduan penilaian artikel penelitian secara sistematis.	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyampaikan hasil *critical appraisal* secara singkat dan sistematis.	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap objektif, teliti, dan kritis dalam menilai artikel penelitian.	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa

Tuliskan pengalaman atau pembelajaran yang diperoleh setelah melakukan *critical appraisal* artikel penelitian.

.....

.....

.....

.....

.....

Referensi

Almutairi, R., Alsarraf, A., Alkandari, D., Ashkanani, H., & Albazali, A. (2024). Dissecting through the literature: A review of the critical appraisal process. *Cureus*, *16*(5), e59658. https://doi.org/10.7759/cureus.59658

Amir, H., Permatananda, P. A. N. K., Cahyani, D. D., Langelo, W., Rosita, R., Sajodin, S., Noprianty, R., Astuti, A., Suhari, S., Wahyuningsih, S., Kusumawati, P. D., Swamilaksita, P. D., Sudarman, S., & Syaiful, S. (2023). Enhancing skill conceptualization, critical thinking, and nursing knowledge through reflective case discussions: A systematic review. *Journal of Medicine and Life*, *16*(6), 851–855. https://doi.org/10.25122/jml-2023-0042

Barker, T. H., Hasanoff, S., Aromataris, E., Stone, J. C., Leonardi-Bee, J., Sears, K., Habibi, N., Klugar, M., Tufanaru, C., Moola, S., Liu, X. L., & Munn, Z. (2025). The revised JBI critical appraisal tool for the assessment of risk of bias for cohort studies. *JBI Evidence Synthesis*, *23*(3), 441–453. https://doi.org/10.11124/JBIES-24-00103

Barker, T. H., Stone, J. C., Sears, K., Klugar, M., Leonardi-Bee, J., Tufanaru, C., Aromataris, E., & Munn, Z. (2022). Revising the JBI quantitative critical appraisal tools to improve their applicability: An overview of methods and the development process. *JBI Evidence Synthesis*, *21*(3), 478–493. https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00125

Codina, L. (2022). The IMRaD model: What is it and how can it be applied to articles in the humanities and social sciences? *Hipertext.Net*, (24), 1–8. https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2022.i24.01

Dahlan, S. (2020). *Besar sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan* (5th. Ed). Penerbit Salemba Medika.

Dahlan, S. (2021). *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan* (6th Ed.). Epidemiologi Indonesia.

Dziri, C., & Fingerhut, A. (2025). Up-to-date composition and critical appraisal of meta-analyses of comparative studies. *Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery*, *10*, 1. https://doi.org/10.21037/ales-24-26

Eriksson, D. (2024). The art and science of scholarly writing: Framing symmetry of specificity beyond IMRAD. *European Business Review*, *36*(2), 141–153. https://doi.org/10.1108/EBR-01-2023-0004

Evans, C., Hassanein, Z. M., Bains, M., Bennett, C., Bjerrum, M., Edgley, A., Edwards, D., Porritt, K., & Salmond, S. (2025). Addressing equity, diversity, and inclusion in JBI qualitative systematic reviews: A methodological scoping review. *JBI Evidence Synthesis*, *23*(3), 454–479. https://doi.org/10.11124/JBIES-24-00025

Kinnunen, A., Hagman, T., Paakkonen, H., & Saaranen, T. (2025). Constructing critical care nursing expertise: An integrative literature review. *Nurse Education Today*, *149*, 1–2. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106668

Kumar, P. (2023). Improving IMRaD for writing research articles in social, and health sciences. *IRJEMS International Research Journal of Economics and Management Studies*, *2*(1), 1–4. https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V2I1P107

Long, H. A., French, D. P., & Brooks, J. M. (2020). Optimising the value of the critical appraisal skills programme (CASP) tool for quality appraisal in qualitative evidence synthesis. *Research Methods in Medicine & Health Sciences*, *1*(1), 31–42. https://doi.org/10.1177/2632084320947559

Özkan Çelik, A. E., & Al, U. (2024). Structured abstract generator (SAG) model: Analysis of IMRAD structure of articles and its effect on extractive summarization. *International Journal on Digital Libraries*, *25*(4), 787–801. https://doi.org/10.1007/s00799-024-00402-8

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). *Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice* (9th ed.). Wolters Kluwer.

Quan, C., Clark, N., Costigan, C. L., Murphy, J., Li, M., David, A., Ganesan, S., Guzder, J., & Cross, B. (2023). JBI systematic review protocol of text/opinions on how to best collect race-based data in healthcare contexts. *BMJ Open*, *13*(5), 1–7. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069753

Reynolds, S. S., Waldrop, J. B., & Dunlap, J. J. (2026). Evidence-based practice quality improvement reporting guidelines. *Journal of Nursing Care Quality*, *41*(1), 17–21. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000912

Salmond, S., & Bennett, M. J. (2021). JBI manual for evidence synthesis. In *Comprehensive Systematic Review for Advanced Practice Nursing, Third Edition* (Number April). JBI. https://doi.org/10.1891/9780826152268.0012

Santesso, N., Glenton, C., Dahm, P., Garner, P., Akl, E. A., Alper, B., Brignardello-Petersen, R., Carrasco-Labra, A., De Beer, H., Hultcrantz, M., Kuijpers, T., Meerpohl, J., Morgan, R., Mustafa, R., Skoetz, N., Sultan, S., Wiysonge, C., Guyatt, G., & Schünemann, H. J. (2020). GRADE guidelines 26: Informative statements to communicate the findings of systematic reviews of interventions. *Journal of Clinical Epidemiology*, *119*, 126–135. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2019.10.014

Santhanam, S., Ravindran, V., & Wincup, C. (2025). Critical appraisal of an original research article. *Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh*, *55*(4), 347–357. https://doi.org/10.1177/14782715251369964

Shen, S., Hua, B., Xie, J., Li, S., Liu, J., Zhao, Z., Wu, N., & Wang, X. (2024). Research on the structure function recognition of PLOS. *Frontiers in Artificial Intelligence*, *7*, 1–8. https://doi.org/10.3389/frai.2024.1254671

Stone, J. C., Barker, T. H., Aromataris, E., Ritskes-Hoitinga, M., Sears, K., Klugar, M., Leonardi-Bee, J., & Munn, Z. (2023). From critical appraisal to risk of bias assessment: Clarifying the terminology for study evaluation in JBI systematic reviews. *JBI Evidence Synthesis*, *21*(3), 472–477. https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00434

Tod, D., Booth, A., & Smith, B. (2022). Critical appraisal. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, *15*(1), 52–72. https://doi.org/10.1080/1750984X.2021.1952471

Waldrop, J. B., Dunlap, J. J., & Reynolds, S. S. (2025). Evidence-based practice quality improvement critical appraisal tool. *Journal of Nursing Care Quality*, *40*(1), 15–23. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000789

BAB 5

IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED NURSING DI PRAKTIK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5 . Implementasi Evidence-Based Nursing di Praktik	5.1 Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.	5.2 Merancang rencana implementasi EBN (stakeholder, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-2

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Tugas perumusan masalah & pertanyaan (template PICOT/SPIDER)	Ketepatan struktur pertanyaan (komponen lengkap) dan keterukuran tujuan/outcome (skor rubrik).	10	Dokumen pertanyaan & tujuan
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan identifikasi isu etik pada skenario	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

Pendahuluan

Perkembangan hasil riset keperawatan yang berkualitas tinggi dan diterbitkan pada jurnal penelitian yang bereputasi belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan pada aplikasi praktik klinis keperawatan berdasarkan temuan hasil riset. Gagasan dan bukti ilmiah yang sangat kuat mungkin telah dibuktikan melalui uji klinis acak atau *Randomized Control Trial* (RCT) berskala besar bisa saja terhenti, memudar, dan gagal diadaptasi di praktik klinis keperawatan. Mengapa praktik keperawatan yang sudah dilakukan bertahun-tahun yang diartikan sebagai tradisi seringkali sulit diubah meskipun sudah ada bukti penelitian yang lebih baik? Apakah fakta lain yang menunjukkan bahwa sering kali dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun bagi sebuah temuan riset untuk benar-benar dapat diterapkan menjadi rutinitas asuhan keperawatan klinis sehari-hari adalah fenomena yang akan terus berlanjut?

Hambatan sistemik pada tatanan praktik klinis mungkin dipicu oleh berbagai dinamika yang kompleks di tatanan layanan kesehatan seperti praktik keperawatan yang memiliki beban kerja tinggi dan ritme yang cepat. Serta, perawat sering kali berhadapan dengan budaya organisasi yang resisten terhadap perubahan dan hambatan kultural yang menyakini rutinitas praktik yang telah ada membuat pasien tetap baik-baik saja. Selain hambatan kultural, kegagalan implementasi juga sering disebabkan oleh kurangnya dukungan dari manajemen khususnya *decision makers*, ketiadaan *agen of change* di ruangan perawatan, hingga ketiadaan infrastruktur yang mendukung. Tanpa strategi manajemen perubahan yang kuat, matang, dan komprehensif, intervensi keperawatan yang unggul akan dengan mudah ditolak oleh sistem yang sudah berjalan.

Integrasi bukti ilmiah dalam asuhan keperawatan praktik keperawatan modern menjadi sangat penting dan tidak lagi dapat bergantung semata-mata pada tradisi, intuisi, atau kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-temurun oleh perawat. *Evidence-Based Nursing* (EBN) mengambil peran sentral sebagai fondasi asuhan yang berkualitas. Implementasi EBN di praktik klinis sangat krusial karena pendekatan ini secara proaktif mengintegrasikan bukti penelitian terbaik dengan keahlian klinis perawat dan preferensi pasien. Penerapan EBN secara konsisten telah terbukti mampu meminimalkan intervensi yang tidak perlu, meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*), mengoptimalkan efisiensi biaya perawatan, dan secara signifikan mempercepat proses penyembuhan. Implementasi integrasi hasil riset pada asuhan keperawatan pasien bukan sekadar tuntutan akademis, melainkan tanggung jawab etis profesi keperawatan.

Implementasi untuk menjembatani riset dan praktik klinis telah menunjukkan tantangan yang besar yang tidak hanya membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi namun membutuhkan ilmu pengetahuan tersendiri yaitu *implementation science*. Bab buku ajar ini menjelaskan tetang informasi implementasi EBN tidak hanya untuk mengetahui dan melatih bagaimana mensintesis penelitian secara kritis, tetapi juga melatih untuk menyusun strategi perubahan yang merangkul *stakeholder*, merancang indikator keberhasilan yang terukur, dan mengevaluasinya melalui siklus audit klinis. Tujuannya adalah mencetak perawat yang tidak hanya bertindak sebagai konsumen riset, melainkan sebagai agen perubahan yang tangguh di dunia nyata praktik klinis keperawatan yang profesional.

Tujuan Instruksional Umum

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan hasil riset ke dalam praktik keperawatan klinis secara komprehensif, mulai dari mensintesis literatur yang relevan hingga merancang strategi implementasi dan evaluasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan di tatanan layanan kesehatan.

Tujuan Instruksional Khusus

Untuk mencapai tujuan umum, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dua subcapaian pembelajaran dengan rincian indikator sebagai berikut:

Subcapaian pembelajaran 1: Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa mampu:

1. Menguraikan perbedaan mendasar antara merangkum literatur (*summarizing*) dan mensintesis bukti (*synthesizing*) dalam konteks keperawatan.
2. Mengekstraksi dan menyusun data dari berbagai desain penelitian ke dalam bentuk Matriks Sintesis Literatur yang sistematis.
3. Menganalisis kualitas, kekuatan, dan kepastian bukti ilmiah (*level of evidence*) menggunakan instrumen penilaian standar.
4. Merumuskan rekomendasi asuhan keperawatan berbasis bukti yang aplikatif, aman, dan selaras dengan sumber daya klinis serta preferensi pasien.

Subcapaian pembelajaran 2: Merancang rencana implementasi EBN (*stakeholder*, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur.

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa mampu:

1. Merancang rencana aksi (*action plan*) implementasi EBN dengan mengadaptasi model perubahan
2. Mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* kunci serta menganalisis kesiapan budaya organisasi sebelum memulai perubahan praktik di ruang rawat.

3. Menentukan indikator evaluasi yang spesifik dan terukur, baik pada ranah proses (kepatuhan staf) maupun *outcome* (dampak pada pasien atau sistem).
4. Mengembangkan mekanisme audit klinis terstruktur (siklus PDSA) dan strategi pemberian umpan balik (*feedback*) yang konstruktif guna memastikan keberlanjutan (*sustainability*) dari EBN yang diterapkan.

Uraian Materi

A. Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.

Tahap penyusunan sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan perumusan rekomendasi berbasis bukti adalah proses terstruktur yang berangkat dari tahap membaca artikel penelitian hingga merumuskan draf rekomendasi klinis yang siap diterapkan di praktik keperawatan. Tahap transisi ini menuntut pemahaman yang ketat atas bagaimana temuan riset dapat diolah menjadi rekomendasi yang konsisten, dapat direplikasi, dan relevan bagi konteks klinik keperawatan. Pada kerangka keperawatan, model "bedside-to-*bench*" maupun "*bench-to-bedside*" telah didiskusikan untuk menyeimbangkan kebutuhan klinisi dengan peluang inovasi ilmiah, di mana keduanya diakui sebagai bagian dari satu spektrum *translational research* yang dinamis (Cowman, 2014; 2017). Pentingnya peran komunitas klinik dalam desain penelitian dan perbaikan kualitas praktik, misalnya melalui pembentukan kelompok interdisipliner untuk meningkatkan produktivitas riset dan relevansi klinis, serta integrasi riset ke dalam program pendidikan dan praktik rutin (Tsai et al., 2024). Hal ini mendukung gagasan bahwa draft rekomendasi klinis sebaiknya lahir dari proses kolaboratif yang menggabungkan keahlian klinik, riset, dan manajemen implementasi untuk memperkecil kesenjangan antara bukti dan praktik nyata. Pendekatan sintesis bukti yang diusulkan berakar pada prinsip-prinsip sistematis dapat diilustrasikan pada gambar 13.1.



Gambar 6. 1 Tahapan Pendekatan Sintesis Bukti Dengan Prinsip-Prinsip Sistematis

Secara praktis, proses transisi dari membaca artikel penelitian menuju penyusunan draf rekomendasi melibatkan pemetaan bukti ke dalam kerangka tindakan klinis yang spesifik, yang diawali identifikasi masalah atau pertanyaan praktik, sintesis temuan dengan penggunaan kriteria dan tinjauan yang berkulaiatas dan sistematis dan dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda, perancangan draft intervensi berbasis bukti yang realistis menjadi protokol implementasi, serta perencanaan evaluasi berkelanjutan yang menggabungkan data proses dan hasil pasien. Dengan demikian, penyusunan sintesis bukti dan rekomendasi berbasis bukti untuk praktik keperawatan transisi secara efektif dari pembacaan artikel penelitian ke draft rekomendasi klinis yang siap pakai.

1. Konsep Dasar Sintesis Bukti dalam Keperawatan

   Dalam keperawatan, dua aktivitas pengetahuan yang sering muncul adalah merangkum literatur (*summarizing*) dan mensintesis bukti (*synthesizing*). Kedua aktivitas ini berperan penting dalam pembentukan praktik berbasis bukti, namun memiliki tujuan, metodologi, output, dan kontribusi yang berbeda terhadap kualitas keputusan klinis dan kebijakan. Berdasarkan literatur metodologi keperawatan, terdapat konsensus bahwa merangkum literatur berkutat pada penyajian ringkas aspek-aspek utama dari sejumlah studi, sedangkan mensintesis bukti menuntun kepada pemahaman terintegrasi yang menggabungkan temuan dari berbagai studi untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan dalam konteks praktis. Perbedaan ini tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis mengenai bagaimana bukti dibaca, dinilai, dan diangkat untuk tindakan keperawatan.

   Merangkum literatur adalah proses menyeleksi, menyusun, dan menyajikan ringkasan singkat tentang temuan-temuan dari sejumlah studi atau sumber

literatur terkait topik tertentu. Tujuannya adalah memberikan gambaran ringkas tentang apa yang telah dipelajari, tanpa mengubah makna asli temuan, serta membantu pembaca memahami lanskap bukti secara. Fokus luarannya adalah ringkasan deskriptif yang menyoroti metodologi, populasi, temuan utama, keterbatasan studi, serta pola umum atau tematik yang terlihat. luaran ini cenderung bersifat naratif atau tabel ringkas yang merangkum studi-studi yang disertakan.

Mensintesis bukti adalah proses menggabungkan temuan dari beberapa studi dengan tujuan menghasilkan pengetahuan baru yang koheren, terintegrasi, dan dapat diaplikasikan dalam praktik, pendidikan, atau kebijakan. Sintesis melibatkan penilaian kritis terhadap kualitas bukti, identifikasi pola hubungan kausal atau konfirmatori, dan penyampaian kesimpulan yang lebih terpadu dibanding sekadar merangkum tiap studi. Fokus luaran merupakan kesimpulan sintetis yang mengabungan bukti dari berbagai desain penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran), metodologi sintesis seperti *systematic reviews, meta-analyses, integrative reviews*, atau *scoping reviews*, serta rekomendasi praktik atau kebijakan berdasarkan bukti gabungan.

Dalam praktik keperawatan berbasis bukti, tiga konstruk metodologis yang sering disebut adalah *literature review, systematic review*, dan sintesis bukti klinis. Meskipun ketiganya berbagi tujuan menilai dan merangkum bukti untuk mendukung keputusan klinis, masing-masing memiliki fokus, metodologi, transparansi, serta produk keluaran yang berbeda. Literature review adalah merupakan ulasan naratif literatur terkait topik tertentu yang disusun secara sintetis tanpa kewajiban mengikuti protokol sistematis dalam seluruh proses seleksi dan evaluasi studi dengan tujuan memberikan gambaran luas, teori, dan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami masalah praktik tanpa metodologis ketat seperti tinjauan sistematis dan menghasilkan tinjauan naratif, kerangka konseptual, dan identifikasi researcg gap. *Systematic review* adalah tinjauan literatur yang mengikuti rancangan metodologis terstandarisasi untuk mencari, menilai kualitas, dan mensintesis bukti dari studi relevan secara terperinci, dengan protokol yang transparan dan reproduktif dengan tujuan: menjawab pertanyaan klinis spesifik dengan menyertakan kriteria inklusi/eksklusi yang jelas, proses seleksi berlapis, penilaian kualitas studi, serta sintesis temuan secara terstruktur yang menghasilkan ringkasan bukti terstruktur dengan tabel kualitas bukti dan diagram alur seperti PRISMA/ *Flow Diagram*.

Sintesis Bukti Klinis (*Clinical Evidence Synthesis*) merupakan proses integratif yang menggabungkan bukti dari berbagai tipe studi (uji efek, studi observasional, ulasan sistematis, pedoman praktik) dengan mempertimbangkan konteks klinik,

sumber data, dan mekanisme implementasi. Tujuannya adalah menghasilkan draft rekomendasi klinis berbasis bukti yang operasional dan siap diterapkan, dengan rencana evaluasi berkelanjutan. Sintesis Bukti Klinis menghasilkan draft rekomendasi klinis berbasis bukti, disertai dengan prosedur implementasi, indikator evaluasi, serta rencana iterasi berbasis data implementasi. Transparansi tergantung pada bagaimana bukti diintegrasikan dengan konteks klinik, serta bagaimana rekomendasi disusun secara operasional (tugas, tanggung jawab, sumber daya, indikator hasil) untuk praktik keperawatan. Kualitas bukti dipertimbangkan dalam kerangka implementasi: tidak hanya apakah intervensi efektif, tetapi juga seberapa feasibel, bagaimana mekanisme implementasinya, bagaimana mengukur dampak, dan bagaimana iterasi (proses pengulangan suatu langkah, tindakan, atau prosedur secara berulang-ulang untuk mencapai hasil, solusi, atau tujuan yang diinginkan) perbaikan berbasis data dilakukan. Hal ini mencakup penilaian konteks budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, dan dinamika kerja tim klinis sebagai bagian dari kualitas bukti implementasi praktik berbasis bukti.

2. Langkah-Langkah Ekstraksi dan Sintesis Data

Penelusuran bukti melibatkan sumber-sumber dengan desain penelitian beragam baik penelitian kuantitatif, kualitatif, dan atau penelitian mix-method. Untuk menjaga transparansi, rekonstruksi bukti, dan memfasilitasi penerapan bukti dalam praktik, ekstraksi data dari desain yang berbeda perlu diorganisasi dalam suatu matriks sintesis literatur yang sistematis. Matriks ini berfungsi sebagai alat integratif yang memungkinkan perbandingan langsung antar variabel kunci seperti pertanyaan penelitian, populasi, desain, ukuran efek, kualitas bukti, tematik, serta konteks klinis dan memudahkan transisi dari rangkuman deskriptif yang komprehensif menjadi sintesis bukti yang terintegrasi.

Ekstraksi data bertujuan mengumpulkan informasi kunci dari setiap studi yang memenuhi kriteria inklusi, dengan struktur terstandar agar perbandingan antar studi bisa dilakukan secara konsisten. Sedangkan, Sintesis data bertujuan merangkum temuan-temuan dari beragam studi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh, mengidentifikasi pola, konsistensi efek, bias risiko, serta konteks implementasi. Matriks sintesis literatur menjadi alat sentral untuk mengorganisasi informasi dan memfasilitasi integrasi temuan menjadi satu narasi koheren.

Komponen utama Matriks Sintesis Literatur dapat dituangkan dalam tabel terstruktur yang memuat kolom-kolom inti yang terdiri dari:

a. Peneliti/Tahun: identitas studi untuk referensi silang dan pelacakan sumber

b. Desain Studi: RCT, kohort, studi potong lintang, ulasan sistematis, dsb., untuk menilai kekuatan desain penelitian
c. Populasi/Setting: karakteristik pasien, setting klinik, lokasi geografis, untuk menilai keterkaitan konteks dengan praktik keperawatan
d. Intervensi/Intervensi yang Dikaji: deskripsi intervensi, dosis/durasi, komponen utama, serta how-to implementasi jika relevan
e. Pembanding: kontrol, perawatan standar, atau intervensi pembanding
f. Hasil Utama: ukuran efek, hasil klinis, variabel proses, atau indikator lain yang dilaporkan studi; sertakan satuan dan arah efek jika tersedia
g. Kualitas Bukti / Risiko Bias: skor kualitas, alat penilaian tingkat bias misal dengan menggunakan *Revised tool for Risk of Bias in randomized trials* (ROB-II), *Risk Of Bias due to Missing Evidence in a synthesis* (ROB-ME) dan batasan yang dilaporkan peneliti
h. Konteks Implementasi: faktor-faktor kontekstual seperti budaya organisasi, sumber daya, hambatan implementasi, dan adaptasi konteks klinik keperawatan
i. Ulasan/Referensi Lanjutan: catatan terkait ulasan sistematis, pedoman praktik, atau sumber rujukan lain yang relevan untuk triangulasi temuan
j. Ringkasan keterkaitan/benang merah: pernyataan singkat mengenai konsistensi temuan, arah efek, dan implikasi klinis yang muncul dari kumpulan studi.

Tahap-tahap praktis pembuatan Matriks Sintesis Literatur antara lain melalui perencanaan ekstraksi data, penentuan inklusi/eksklusi dan sumber data, ekstraksi data terstruktur, validasi antar penilai, sintesis tematik vs kuantitatif, Dokumentasi transparansi. Gambar 13.2 menunjukkan poin penjelasan tiap tahapan pembuatan matriks.

Selanjutnya, setelah matriks terbentuk, adalah proses menggunakan Matriks Sintesis untuk menjawab pertanyaan PICO(T). Untuk *Population* (P) dan I*ntervensi* (I), gunakan Matriks untuk membandingkan apakah efek intervensi serupa antara populasi berbeda. Identifikasi apakah konsistensi temuan muncul di subkelompok pasien atau setting praktik tertentu, sehingga rekomendasi klinis dapat disesuaikan konteks. Untuk *Comparator* (C) dan *Outcome* (O), Ringkas perbandingan efek dan hasil utama secara komparatif. Matriks memungkinkan identifikasi arah efek (aman, efektif, tidak efektif) dan ukuran efek relatif/absolut jika tersedia, sehingga jawaban PICO(T) menjadi lebih tajam. Untuk Time (T), Tampilkan apakah temuan bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Ketidakselarasan temporal antar studi dapat menjadi sumber heterogenitas. Matriks dapat memfasilitasi penandaan konteks waktu studi secara eksplisit.

Gunakan Matriks untuk menggabungkan bukti dari RCT, studi observasional, ulasan sistematis, dan pedoman praktik. Melalui kolom-Konsep, identifikasi konsistensi dan perbedaan yang signifikan antar desain penelitian serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi rekomendasi berbasiskan bukti. Dari matriks, tarik keterkaitannya (consensus tema, efek utama, konteks implementasi) dan terjemahkan ke dalam draft rekomendasi berbasis bukti yang operasional, lengkap dengan indikator evaluasi dan rencana iterasi berbasis data implementasi.



Gambar 6. 2 Penjelasan Tiap Tahapan Pembuatan Matriks Sintesis Literatur

Temuan pada matrik sintesis bukti berbasis PICO(T) untuk praktik keperawatan mungkin saja menunjukkan hasil penelitian yang saling bertentangan atau kontradiktif. Hasil kontradiktif muncul dikarenakan adanya variasi desain studi seperti perbedaan antara RCT, kohort, studi potong lintang, dan studi kualitatif dapat menghasilkan temuan yang tampak bertentangan karena kekuatan desain, ukuran sampel, dan risiko bias yang berbeda. Perbedaan konteks klinik seperti setting fasilitas, budaya organisasi, sumber daya, dan populasi pasien dapat memoderasi efek intervensi, sehingga temuan bisa konsisten dalam satu konteks tetapi tidak di konteks lain. Operasionalisasi intervensi dan outcome juga mempengaruhi jika ditemukan variasi dalam deskripsi intervensi seperti variasi dosis, durasi, kuesioner, ukuran efek serta definisi outcome dapat menyebabkan hasil yang berbeda antara studi yang

terlihat serupa secara judul/topik. Waktu follow-up yang bervariasi seperti efek jangka pendek vs panjang sering berbeda dan perbedaan periode follow-up dapat menimbulkan kesimpulan yang bertentangan mengenai keberlanjutan manfaat atau risiko. Studi dengan risiko bias tinggi atau kualitas bukti rendah cenderung menghasilkan temuan yang kurang dapat diandalkan, sehingga saat digabungkan bisa terlihat saling bertentangan.

Pendekatan praktis dalam konteks keperawatan untuk hasil temuan yang kontradiktif antara lain dengan menggunakan bukti yang lebih kuat dan umpan balik dari praktik ke penelitian (mengidentifikasi area yang perlu diteliti ulang). Kontradiksi bisa menjadi pendorong untuk revisi pedoman atau desain intervensi yang lebih realistis di klinik keperawatan. Pertimbangkan integrasi bukti kualitatif: ketika temuan kuantitatif kontradiktif, data kualitatif tentang persepsi klinisi, pengalaman pasien, dan faktor konteks dapat memberikan wawasan penting tentang mengapa perbedaan muncul dan bagaimana menyesuaikan implementasi.

Dokumentasikan ketidakpastian secara eksplisit dengan menjelaskan batasan ketidakpastian, batasan studi, dan implikasi praktisnya. Keterbukaan mengenai ketidakpastian meningkatkan kepercayaan pembaca dan membantu manajer klinis membuat keputusan berbasis risiko yang tepat. Kontradiksi dalam hasil penelitian adalah hal yang wajar dan memberi peluang bagi peningkatan praktik keperawatan melalui analisis konteks, kualitas bukti, dan desain studi lebih lanjut. Pendekatan sistematis yang menonjolkan transparansi, analisis kontekstual, dan perencanaan evaluasi implementasi dapat mengubah kontradiksi menjadi langkah maju dalam translasi bukti ke praktik klinis yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

3. Menilai Kualitas dan Kekuatan Bukti (*Level of Evidence*)

Penilaian kualitas dan kekuatan bukti adalah proses sistematis untuk menentukan seberapa terpercayanya temuan penelitian dan tingkat ketahanan rekomendasi klinis berbasis bukti dalam konteks keperawatan. Tujuan utamanya adalah memberi bobot interpretatif terhadap temuan studi berdasarkan desain studi, risiko bias, konsistensi temuan, dan relevansi konteks klinik, sehingga praktik keperawatan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik keperawatan, hierarki bukti membantu membedakan antara bukti yang lebih kuat misalnya tinjauan sistematis atau meta-analisis dari RCT dibandingkan bukti berbentuk laporan kasus atau opini ahli, sehingga rekomendasi klinis bisa disusun secara bertahap sesuai kualitas bukti yang tersedia. Setidaknya ada tiga kerangka utama yang sering digunakan untuk menilai *level of evidence* diantaranya adalah *Melnyk & Fineout-Overholt,*

Joanna Briggs Institute (JBI) Levels of Evidence, dan Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Melnyk & Fineout-Overholt model sering digunakan untuk hierarki bukti untuk intervensi atau treatment, yang memiliki struktur berjenjang dari Level I hingga VII, dengan Level I mencakup tinjauan sistematis atau meta-analisis dari RCT (atau pedoman klinis berbasis tinjauan sistematis), hingga Level VII berupa opini ahli atau laporan dari pakar. Penilaian level of evidence ini sangat jelas untuk penilaian langsung pada intervensi klinis dan memudahkan pembentukan skor tingkat rekomendasi dan pedoman klinis berbasis bukti namum kurang fleksibel untuk kekhasan konteks klinik keperawatan yang beragam.

Joanna Briggs Institute (JBI) Levels of Evidence menawarkan panduan dengan kategori berdasarkan desain studi dan menekankan konteks aplikasi bukti dalam praktik klinis melalui kerangka penilaian kualitas dan relevansi implementasi. JBI dianggap sesuai untuk keperawatan karena fokusnya pada keseuaian konteks praktik dan kemampuan implementasi di fasilitas perawatan dan memuat instrumen penilaian kualitas yang terperinci untuk berbagai tipe bukti. Namun, terkadang kurang harmonis dengan skema hierarki tradisional jika diterapkan secara ketat seperti pada *Melnyk & Fineout-Overholt.*

GRADE merupakan sistem global untuk menilai kualitas bukti dengan kategori high, moderate, low, very low dan kekuatan rekomendasi (strong versus conditional), dengan pertimbangan faktor-faktor selain kualitas bukti seperti konsensus, keseimbangan manfaat dan risiko, nilai *patient-important outcomes*, serta ketidakpastian implementasi. GRADE memberi kerangka komparatif yang transparan untuk keputusan kebijakan klinis dan pedoman praktik dan sangat berguna untuk menilai implementabilitas rekomendasi di berbagai setting perawatan. Namun, penggunaan GRADE dianggap kompleks dan memerlukan pelatihan agar konsisten diterapkan, terutama dalam konteks keperawatan yang heterogeny.

Kerangka penilaian *level of evidence* dapat diaplikasikan dalam konteks keperawatan, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. **Langkah 1:** identifikasi tipe bukti yang relevan dengan pertanyaan klinis menggunakan kerangka PICO(T)

   Tentukan apakah fokusnya pada uji efek (intervensi) atau masalah kebijakan/praktik (proses implementasi). Ini menentukan pilihan kerangka (Melnyk, JBI, atau GRADE) yang paling tepat untuk menilai kualitas bukti dan kekuatan rekomendasi.

b. **Langkah 2:** tingkatkan transparansi melalui penilaian desain studi

Gunakan skor risiko bias standar untuk RCT (misalnya ROB 2.0) atau instrumen ROBINS-I untuk studi non-randomized; catat keterbatasan desain yang bisa mempengaruhi tingkat bukti. JBI menyediakan panduan alat penilaian untuk berbagai desain penelitian; sesuaikan dengan konteks studi yang Anda temukan.

c. **Langkah 3:** gabungkan konsistensi temuan dan konteks klinik

Evaluasi konsistensi temuan di berbagai setting (rumah sakit, komunitas, primari care) serta faktor kontekstual seperti budaya organisasi, sumber daya, dan kapasitas implementasi. GRADE mendorong pertimbangan konteks ini secara eksplisit dalam menentukan kekuatan rekomendasi Koivunen et al., 2023), sedangkan Melnyk menekankan penggunaan bukti yang relevan dengan konteks praktik klinis untuk meningkatkan translasi bukti ke lapangan Mustafa, 2020).

d. **Langkah 4:** buat rekomendasi berdasarkan kombinasi kualitas bukti dan implikasi praktis

Gunakan GRADE untuk menyatakan rekomendasi sebagai "strong/conditional" dengan pembenaran berbasis kualitas bukti dan konteks implementasi. Jika konteks sangat beragam atau data bukti rendah, gunakan label "conditional" dan sertakan rencana evaluasi implementasi yang jelas.

e. **Langkah 5:** rancang rencana implementasi dan evaluasi berkelanjutan

Terapkan prinsip implementasi berbasis bukti misalnya model The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS), The Advancing Research and Clinical Practice through Close Collaboration (ARCC) untuk menilai kesiapan organisasi, adopsi praktik, dan dampak pada hasil pasien; dokumentasikan bagaimana temuan bukti akan ditranslasikan secara praktis dan bagaimana evaluasi dilakukan guna iterasi pedoman.

Pertimbangan praktis untuk memilih kerangka penilaian *level of evidence* dapat dipertimbangkan berdasarkan keberagaman setting keperawatan, kebutuhan rekomendasi kebijakan klinis, sumberdaya dan kebutuhan edukasi. JBI dapat dipertimbangan untuk dipilih untuk keberagaman setting keperawatan. JBI lebih fleksibel dalam menangani beragam desain bukti yang lazim di keperawatan (RCT, kohort, observasional, studi kualitatif) dan sangat menekankan konteks implementasi, sehingga sering dipakai untuk panduan praktik berbasis bukti yang berkelanjutan. GRADE dapat digunakan untuk konteks kebutuhan rekomendasi kebijakan klinis dan dianggap sangat sesuai ketika perlu menyajikan rekomendasi dengan tingkat ketidakpastian yang jelas, mempertimbangkan manfaat-risiko,

nilai pasien, serta feasibility implementasi di berbagai fasilitas Kesehatan. Sedangkan jika mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan edukasi, Melnyk & Fineout-Overholt dapat digunakan untuk menekankan pentingnya kemampuan perawat untuk menilai bukti, melakukan sintesis, dan menerapkan temuan ke praktik, penggunaan alat penilaian yang jelas dan konsisten membantu membangun kompetensi praktik berbasis bukti di kalangan perawat. Tabel 13.1 diberikan contoh menyajikan hasil penilaian *level of evidence.*

Penilaian Kualitas dan Kekuatan Bukti adalah dasar yang krusial dalam menyusun rekomendasi klinis berbasis bukti di keperawatan. Memilih kerangka penilaian yang tergantung pada tujuan, konteks implementasi, dan kebutuhan komunikasi dengan pemangku kepentingan klinis. Dalam praktik keperawatan yang beragam, kombinasi penggunaan kerangka penilaian tersebut, misalnya menerapkan GRADE untuk tingkat rekomendasi, sambil menggunakan JBI untuk penilaian desain studi dan konteks implementasi, seringkali memberikan fondasi yang lebih kuat untuk pedoman praktik berbasis bukti yang transparan, dapat direplikasi, dan adaptif terhadap dinamika fasilitas layanan Kesehatan.

Tabel 6. 1 Contoh Hasil Penilaian Level of Evidence.

Penilaian	**Contoh 1**	**Contoh 2**	**Contoh 3**
Topik	Intervensi edukasi pasien untuk manajemen glikemia pada DM2	Program edukasi gaya hidup di komunitas DM2	Perawatan pasca operasi (multimodal analgesia)
Desain	RCT tinggi quality; Risiko Bias rendah	kohort; Risiko bias sedang	metaanalisis; kualitas bukti bervariasi
Validitas	Validitas internal tinggi (RCT dengan kontrol adekuat); Validitas eksternal moderat jika populasi mirip pasien DM2 di tatanan klinik yang akan diterapkan	Validitas eksternal lebih kuat jika populasi lebih luas; Validitas internal bisa rendah jika tidak ada kontrol kontaminasi	konvergen/diskriminan: loading faktor tinggi (≥0,6) dan AVE > 0,5; discriminant validity memenuhi standar
Realibilitas	Alat ukur HbA1c memiliki reliabilitas laboratorium yang	alat ukuran fokus pada perilaku hidup sehat; reliabilitas perlu	Cronbach's Alpha dan CR ≥ 0,7.

Penilaian	Contoh 1	Contoh 2	Contoh 3
	tinggi; skor kepatuhan terapi menggunakan kuesioner yang tervalidasi dengan reliabilitas baik.	dilaporkan (Cronbach alpha) untuk skala perilaku	
Kerangka Penilaian	GRADE: kualitas bukti untuk outcome HbA1c adalah high; rekomendasi kuat untuk praktik di klinik primer dengan catatan adaptasi konteks budaya	JBI/Melnyk & Fineout-Overholt: menilai relevansi dan kualitas temuan dalam konteks riil; GRADE: penilaian tingkat bukti secara umum, mungkin rendah karena desain nonrandom	Melnyk & Fineout-Overholt: untuk hierarki bukti awal, GRADE untuk menyatakan tingkat rekomendasi; JBI untuk evaluasi desain studi
Aplikabilitas/ Implementasi	Relevan bagi praktik klinik primer; perlu adaptasi bahasa budaya dan sumber daya untuk implementasi luas; evaluasi implementasi diperlukan. Dukungan sumber daya dan pelatihan staf diperlukan	Relevansi tinggi untuk praktik komunitas; adaptasi budaya sangat penting. Pertimbangkan faktor konteks sosial dan budaya untuk transfer ke setting klinik	Gunakan alat terstandar di unit bedah untuk memantau nyeri dan respons analgesia; pelatihan staf untuk konsistensi penilaian. Pelatihan SOP nyeri, evaluasi efek jangka pendek & jangka panjang, serta monitor kepatuhan klinik

Rekomendasi praktis untuk penulisan laporan hasil penilaian *level of evidence* diantaranya 1) melaporkan secara eksplisit rancangan kerangka yang dipakai (Melnyk & Fineout-Overholt, JBI, atau GRADE) beserta definisi Level of Evidence yang dipakai, 2) mencantumkan penilaian risiko bias untuk masing-masing studi dan bagaimana hal itu mempengaruhi bobot bukti dalam sintesis, 3) menyajikan rekomendasi dengan tingkat kekuatan dan rentang ketidakpastian yang jelas; sertakan rencana evaluasi implementasi untuk mengatasi

ketidakpastian, 4) dan menggunakan contoh tabel/diagram untuk memvisualisasikan bobot bukti dan struktur rekomendasi seperti membuat hasil ringkasan tingkat bukti per outcome menggunakan warna yang konsisten.

Penilaian kualitas dan kekuatan bukti juga mempertimbangkan validitas dan realibilitas dari riset yang sedang disintesis serta Aplikabilitas/relevansi klinis (translasi ke praktik) Penilaian validitas meliputi validitas internal studi, validitas eksternal (*generalizability*), Validitas isi (*content validity*) dan konstrukt validiti, dan validitas konvergen dan diskriminan. Validitas internal studi untuk menilai bagaimana desain studi mengendalikan bias sistemik (randomisasi, blinding, kontrol pembanding, cegah confounders). Gunakan alat risiko bias yang sesuai seperti ROB-II untuk RCT/ROBINS-I untuk studi non-randomized untuk menilai kualitas internal studi. Validitas eksternal meninjau apakah populasi, setting, dan intervensi serupa dengan konteks praktik keperawatan yang ingin disasar. Bandingkan karakteristik populasi studi dengan populasi klien yang dilayani di fasilitas yang akan digunakan. Validitas eksternal erat terkait relevansi klinis dalam kerangka implementasi dan validitas isi dan konstrukt validity untuk menentukan Jika menggunakan alat ukur seperti skala nyeri, kualitas hidup, kepatuhan. Perlu dipastikan alat tersebut memiliki validitas isi yang memadai dan validitas konstruk apakah alat mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas konstruk dapat dievaluasi melalui faktor analisis konfirmatori (CFA) dan AVE yang memadai (AVEs > 0,5 umumnya diharapkan) serta *discriminant validity*. Validitas konvergen dan diskriminan untuk indikator memiliki loading/komponen yang kuat pada konstruk laten (umumnya loading > 0,6–0,7; AVE > 0,5).

Penilaian realibilitas termasuk reliabilitas instrumen ukur, Konsistensi internal, Reproduktivitas pengukuran. Reliabilitas instrumen ukur dengan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). Nilai CR ≥ 0,7 umumnya dianggap layak; untuk eksplorasi early-stage, beberapa peneliti menerima ≥0,6. Lakukan interpretasi hati-hati jika skor berada di ambang batas. Konsistensi internal untuk mengevaluasi konsistensi item terhadap konstruk laten; jika ada item yang mengurangi reliabilitas secara signifikan, pertimbangkan revisi atau penghapusan item tersebut untuk meningkatkan reliabilitas alat ukur. Sedangkan, reproduktivitas pengukuran dapat berupa uji reliabilitas antar-rater jika ada penilaian klinis berbasis observasi; sertakan dimensi inter-rater reliability seperti kappa*, Intraclass Correlation Coefficient* (ICC) jika relevan dengan alat ukur yang dipakai.

Aplikabilitas/relevansi klinis (translasi ke praktik) mempertimbangkan Relevansi pasien (patient-centeredness, Konteks fasilitas dan sumber daya, Kesesuaian budaya dan etika, Impikasi untuk kebijakan dan pedoman. patient-

centeredness mempertimbangkan apakah outcome yang diukur memiliki nilai klinis langsung bagi pasien (mis. nyeri, kepatuhan terapi, kualitas hidup, keamanan pasien). Bukti yang relevan bagi pasien akan lebih mudah diadopsi jika outcome tersebut lebih bermakna bagi pasien. Untuk Konteks fasilitas dan sumber daya, nilai implementabilitas bergantung pada budaya organisasi, dukungan manajemen, ketersediaan personel, pelatihan, dan infrastruktur. Jika studi dilakukan di setting dengan sumber daya berbeda, gali faktor-faktor moderasi yang dapat mempengaruhi efektivitas intervensi di fasilitas yang akan digunakan. Kesesuaian budaya dan etika memastikan instrument dan pendekatan intervensi sesuai dengan budaya komunikasi, bahasa, dan norma praktik yang ada di lingkungan klinik. Penilaian relevansi harus mencakup aspek etika dan kesesuaian budaya pasien dan tenaga Kesehatan. Selanjutnya, implikasi untuk kebijakan dan pedoman dimana temuan relevan secara klinis dapat diangkat ke pedoman praktik jika validitas, reliabilitas, dan relevansi konsisten dengan konteks implementasi. Gunakan kerangka seperti GRADE untuk menilai tingkat rekomendasi berdasarkan kualitas bukti dan konteks implementasi.

Validitas, reliabilitas, dan relevansi klinis adalah tiga pilar utama dalam menilai bukti untuk praktik keperawatan. Menggunakan kerangka Melnyk-Fineout-Overholt, JBI, atau GRADE secara terpadu dapat meningkatkan keandalan, transparansi, dan kemampuan implementasi temuan ke dalam praktik klinis. Rekomendasi praktis menyarakan untuk menyertakan evaluasi kualitas bukti dan relevansi klinis dalam laporan penelitian atau tinjauan literatur, serta rancang rencana evaluasi implementasi untuk memastikan bahwa temuan bukti dapat diterapkan secara efektif di berbagai setting perawatan.

4. Merumuskan Rekomendasi Berbasis Bukti

Perumusan rekomendasi berbasis bukti dapat dirumuskan secara sistematis melalui kerangka A-B-C-D yang mencakup Asesmen bukti (*Assess*), *Baseline* konteks dan preferensi pasien (*Baseline/contextual factors*), *Choices*/intervensi yang direkomendasikan (*Choices*), dan *Deliverables*/indikator implementasi (*Deliverables*). Pendekatan ini menekankan transparansi, kekuatan bukti, dan konteks implementasi sehingga rekomendasi klinis keperawatan menjadi operasional dan dapat diuji secara berkelanjutan di praktik nyata. Pendekatan A-B-C-D dapat dioperasionalisasi menjadi tahapan praktis untuk menghubungkan alur ini secara eksplisit dalam formulasi dalam menyusun rekomendasi yang siap diterapkan di praktik klinik keperawatan.

A: *Assess* (Penilaian Bukti)

Tahapan ini mengidentifikasi kualitas, validitas, reliabilitas, dan relevansi klinis dari bukti yang ada melalui model seperti Melnyk, JBI, atau GRADE. Gunakan penilaian risiko bias, konsistensi temuan, ukuran efek, serta konteks implementasi untuk menentukan kekuatan rekomendasi. Penilaian ini juga mencakup evaluasi kesesuaian konteks fasilitas, populasi pasien, budaya organisasi, dan sumber daya yang tersedia. Hasil pada tahap ini adalah ringkasan tingkat bukti perhasl seperti *high, moderate,* atau *low* dengan justifikasi konteks dan nilai pasien. Hasil *assess* menjadi dasar untuk langkah berikutnya dalam menentukan rekomendasi yang tepat sasaran.

B: *Baseline/contextual factors* (Konteks dan preferensi)

Tahapan ini merupakan evaluasi konteks klinik tempat rekomendasi akan diimplementasikan (setting rumah sakit vs komunitas, kapasitas SDM, budaya kerja, infrastruktur, kebijakan organisasi, serta preferensi pasien dan nilai budaya). Identifikasi faktor moderating yang dapat memediasi efek intervensi dan mempengaruhi implementasi seperti kesiapan untuk perubahan, penerimaan, kelayakan. Luaran tahap ini adalah matriks konteks implementasi dan profil populasi yang relevan; catatan bagaimana konteks akan memodifikasi rekomendasi misalnya penyesuaian dosis, materi edukasi, dan strategi komunikasi.

C: *Choices* (Pilihan Intervensi/Strategi)

Tahap ini meringkas beberapa opsi intervensi berbasis bukti yang paling relevan dengan pertanyaan PICO(T), beserta kelebihan-kekurangan, biaya, feasibility, dan risiko. Gunakan kriteria seperti manfaat-risiko, nilai bagi pasien, dan kemudahan implementasi. Berikan justifikasi atas pilihan utama, alternatif, dan kondisi kapan alternatif lebih tepat digunakan. Luaran tahap ini adalah daftar rekomendasi dengan urutan prioritas, disertai pembeda antara rekomendasi kuat dan kondisional sesuai dengan tingkat bukti dan konteks implementasi. Sesuaikan bahasa rekomendasi agar jelas bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

D: *Deliverables* (Indikator implementasi dan evaluasi)

Tahapan ini adalah melakukan spesifikasikan indikator implementasi termasuk proses dan hasil, protokol pelaksanaan, rencana evaluasi berkelanjutan, serta mekanisme umpan balik untuk iterasi pedoman. Sertakan rencana pengumpulan data proses dan hasil pasien, serta kriteria penghentian atau modifikasi rekomendasi jika diperlukan. Luaran yang diharapkan adalah terbentuknya pedoman implementasi operasional, daftar indikator kinerja, jadwal evaluasi, dan mekanisme revisi pedoman berbasis data implementasi.

Tabel 6. 2 Contoh Pendekatan A-B-C-D untuk Perumusan Rekomendasi Berbasis Bukti

Pendekatan A-B-C-D	**Contoh 1: Intervensi edukasi pasien untuk manajemen glikemia pada DM2**	**Contoh 2: Perawatan pasca operasi (multimodal analgesia)**
A: *Assess*	Bukti highquality dari metaanalisis RCT mengenai edukasi intensif; risk of bias rendah; outcome HbA1c meningkatkan kepatuhan terapi.	Bukti dari beberapa RCT menunjukkan efikasi lebih baik dibanding analgesia konvensional; kualitas bukti bervariasi tergantung desain dan follow-up
B: *Baseline/contextual*	Klinik primer dengan akses ke materi edukasi berbahasa lokal; budaya komunitas mendukung perubahan perilaku	Rumah sakit berkapasitas operasi tinggi dengan protokol nyeri standar; implementasi memerlukan pelatihan tim bedah/keperawatan.
C: *Choices*	Rekomendasikan program edukasi terpadu dengan dukungan teknologi (aplikasi/mobile reminders) sebagai rekomendasi utama; alternatif adalah edukasi standar.	Terapkan protokol analgesia multimodal sebagai rekomendasi utama, dengan opsi konvensional sebagai cadangan di fasilitas dengan kendala.
D: *Deliverables*	Indikator kepatuhan, HbA1c, kunjungan follow-up; rencana evaluasi 6–12 bulan; pelatihan staf dan materi edukasi adaptif	Indikator nyeri VAS/NRS, waktu mobilisasi, durasi rawat inap, total biaya; evaluasi mingguan selama 4–8 minggu awal implementasi.

Pendekatan A-B-C-D menyediakan kerangka praktis untuk merumuskan rekomendasi berbasis bukti yang jelas, kontekstual, dan implementatif di keperawatan. *Assess* memastikan kualitas, reliabilitas, dan relevansi bukti,

baseline/contextual factors menghubungkan bukti dengan praktik nyata, *choices* menyajikan opsi intervensi dengan justifikasi, dan *deliverables* mengemas implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Penerapan A-B-C-D memerlukan dokumentasi transparan, rencana evaluasi berkelanjutan, serta komunikasi yang jelas kepada pemangku kepentingan klinis dan manajemen fasilitas.

B. Merancang rencana implementasi EBN (*stakeholder*, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur

Implementasi praktik berbasis bukti atau *Evidence Based Nursing Practice* (EBN) di fasilitas keperawatan merupakan proses translasional yang menuntut koordinasi berbagai stakeholder atau lintas unit dan fungsi, kepemimpinan yang visioner, dan mekanisme implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Rencana implementasi EBN tidak hanya menyentuh aspek teknis intervensi klinis, tetapi juga bagaimana pemangku kepentingan yang terlibat, bagaimana indikator proses dan hasil dirumuskan secara terukur, serta bagaimana audit dan umpan balik digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Penekanan pada desain yang terukur memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menilai dampak pada kualitas perawatan serta kepuasan pasien. Suksesnya implementasi adopsi EBN bergantung pada tiga elemen inti yaitu konteks seperti budaya organisasi, kesiapan perubahan, alokasi sumber daya, fasilitator yang meliputi kepemimpinan klinis dan manajerial, tim implementasi, pelatihan), serta bukti itu sendiri termasuk ketersediaan, akses, dan relevansi.

Selain itu, tiga pilar utama pada struktur kerangka rencana implementasi EBN adalah pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*), fokus pada indikator proses–hasil dan mekanisme audit-umpan balik. Pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai level baik pasien, perawat klinis, manajer fasilitas, pemimpin organisasi, hingga pembuat kebijakan merupakan hal penting sebagai kunci untuk meningkatkan adopsi, kepatuhan, dan keberlanjutan intervensi berbasis bukti. Indikator proses–hasil dan mekanisme audit umpan balik menjadi pusat bagi evaluasi kualitas layanan keperawatan, karena keduanya menyediakan sumber data yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan praktis dan perumusan pedoman kebijakan internal rumah sakit maupun fasilitas pelayanan primer.

1. Pengenalan Model Implementasi EBN

   Model Implementasi EBN yang dapat menjadi pilihan model yang tepat berdasarkan konteks rumah sakit atau fasilitas layanan Kesehatan antara lain seperti *Iowa Model of EBP, Johns Hopkins Nursing EBP Model,* atau *Stetler Model.*

a. *Iowa Model of EBP*

Iowa Model of EBP berfokus pada identifikasi masalah praktik, pengumpulan dan penilaian bukti, serta perancangan implementasi di unit klinis secara berulang menggunakan siklus perencanaan, pelaksanaan, peninjauan seperti pendekatan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) atau pendekatan *Plan-Do-Study-Act* (PDSA). Model ini sangat kuat untuk masalah praktik spesifik di tingkat unit dengan fokus operasional yang jelas. Kelebihan utamanya adalah fokus operasional dan kemampuannya untuk memandu perubahan praktik pada tingkat unit. Kekurangan bisa terkait kebutuhan sumber daya pelatihan dan adopsi lintas fungsi untuk implementasi pedoman di seluruh fasilitas. Unit perawatan bedah atau unit perawatan intensif dengan SOP ketat dan kebutuhan standardisasi proses bisa diuntungkan oleh Iowa Model karena kemampuannya mengarahkan implementasi pedoman secara operasional di tingkat unit. Unit bedah dengan SOP ketat dan kebutuhan edukasi staf yang kontinu. Iowa Model menawarkan kerangka operasional yang jelas untuk identifikasi masalah, evaluasi bukti, dan perumusan pedoman implementasi di tingkat unit dengan alur yang terdefinisi.

b. *Johns Hopkins Nursing EBP Model*

Johns Hopkins Nursing EBP Model (JHNEBP) menekankan empat langkah inti antara lain 1) identifikasi masalah/pertanyaan klinis, 2) pengumpulan dan penilaian bukti, 3) rekomendasi, dan 4) perumusan pedoman, serta implementasi dengan evaluasi berkelanjutan. Model ini sangat cocok untuk organisasi yang mengutamakan penilaian kualitas bukti secara formal dan keterlibatan lintas profesi serta manajemen perubahan. Keunggulan utama adalah struktur evaluasi bukti yang jelas dan dukungan lintas profesi, tetapi implementasinya bisa memerlukan sumber daya manajerial dan pelatihan yang lebih intensif serta dokumentasi yang rinci. Rumah sakit berskala besar dengan budaya pembelajaran dan infrastruktur teknologi informatika yang baik mungkin mendapatkan manfaat dari JHNEBP karena kebutuhan integrasi bukti, evaluasi kualitas, dan kerja lintas fungsi yang kuat.

c. *Stetler Model*

Stetler Model berfokus pada kontekstualisasi bukti melalui proses enam langkah yang berorientasi pada evaluasi internal, translasi bukti, dan sustainment di lingkungan klinik yang variatif. Model ini fleksibel untuk adaptasi di fasilitas dengan kapasitas sumber daya berbeda dan menekankan peran fasilitator internal sebagai agen perubahan. Fokus kontekstual dan adaptif sesuai untuk fasilitas dengan variasi budaya organisasi, namun mungkin kurang menyediakan pedoman implementasi komprehensif untuk

skala besar tanpa kombinasi kerangka lain. Fasilitas dengan keterbatasan sumber daya namun perlu pendekatan implementasi yang lebih sederhana bisa menggunakan Stetler Model untuk menstrukturkan translasi bukti secara kontekstual dan bertahap. Puskesmas dengan sumber daya terbatas dan fokus pada praktik standar yang konsisten. Stetler Model bisa menjadi pilihan awal karena pendekatannya kontekstual, fleksibel, dan lebih mudah disesuaikan dengan keterbatasan tanpa menambah beban administrasi yang berat.

Pemilihan model yang tepat berdasarkan karakteristik rumah sakit dan tujuan menjadi pertimbangan implementasi adopsi model EBN. Proses evaluasi pemilihan model atau *pragmatic decision framework* dapat mengikuti tahapan-tahapan berikut ini antara lain:

1) Tahap 1: Pemetaan konteks organisasi
   Identifikasi ukuran fasilitas (RS besar, RS regional, puskesmas, klinik spesialis), budaya keselamatan pasien, kesiapan perubahan, infrastruktur IT, dan kapasitas pelatihan. Konteks ini menentukan tingkat dukungan yang diperlukan bagi implementasi EBN dan kompatibilitas dengan model pilihan.
2) Tahap 2: Penilaian kebutuhan implementasi
   Pertimbangkan kebutuhan alat penilaian kualitas bukti (seperti tim literasi bukti, akses database, alat appraisal), kemampuan monitoring implementasi, serta mekanisme audit-umpan balik yang diinginkan oleh fasilitas. Model yang lebih eksplisit soal evaluasi bukti (seperti JHNEBP) mungkin lebih sesuai jika evaluasi berkala diperlukan.
3) Tahap 3: Kesesuaian fitur model dengan kebutuhan organisasi
   Iowa Model cocok untuk organisasi yang mengutamakan alur langkah-langkah operasional di tingkat unit dan memiliki budaya perbaikan berkelanjutan melalui PDCA/PDSA. JHNEBP lebih sesuai jika ada komitmen lintas profesi, manajemen perubahan yang kuat, dan kebutuhan pedoman berbasis bukti yang terstruktur. Stetler Model lebih tepat untuk konteks yang dinamis dengan variasi fasilitas, terutama ketika kapasitas sumber daya terbatas atau perubahan budaya diperlukan secara bertahap.
4) Langkah 4: Penilaian sumber daya dan kapasitas
   Pertimbangkan ketersediaan tenaga ahli EBN, akses ke basis bukti, kemampuan analisis kualitas bukti, pelatihan staf, serta dukungan manajemen. Model yang menuntut pelatihan intensif seperti JHNEBP memerlukan alokasi waktu dan anggaran yang memadai; sedangkan Stetler bisa lebih ramah sumber daya jika diatur dengan pendekatan bertahap.

5) Langkah 5: Rencana implementasi dan evaluasi

Tetapkan rencana implementasi yang jelas: timeline, peran sponsor eksekutif, clinical champions, indikator proses–hasil, serta rencana audit-umpan balik. Pastikan rencana ini sesuai dengan praktik kebijakan internal rumah sakit/puskesmas serta mekanisme pelaporan kepada komite mutu/kualitas.

6) Langkah 6: Pertimbangan konteks organisasi *multi-site*

Untuk organisasi multi-site atau jaringan fasilitas, kombinasi model atau adopsi model inti dengan kerangka *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR)/*Promoting Action on Research Implementation in Health Services* (PARIHS) untuk kontekstualisasi bisa lebih efektif. Misalnya, mengadopsi JHNEBP sebagai kerangka inti untuk pedoman dan implementasi lintas situs, sambil menggunakan Stetler sebagai pendekatan kontekstual di fasilitas dengan kebutuhan adaptasi budaya yang lebih kuat.

2. Analisis stakeholder dan kesiapan budaya organisasi sebelum memulai perubahan praktik di ruang rawat

Perancangan rencana implementasi *Evidence-Based Nursing* (EBN) di ruang rawat, identifikasi dan pemetaan stakeholder kunci, serta penilaian kesiapan budaya organisasi adalah langkah krusial sebelum memulai perubahan praktik. Keterlibatan stakeholder yang tepat dari berbagai sektor untuk menyusun fondasi dukungan, alokasi sumber daya, dan percepatan adopsi praktik berbasis bukti. Analisis kesiapan budaya organisasi (*organizational readiness for change*) membantu mengidentifikasi kekuatan, hambatan, serta kebutuhan intervensi untuk memastikan perubahan praktik dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Kerangka konseptual ini sejalan dengan literatur implementasi yang menekankan bahwa faktor konteks organisasi, budaya, dan kepemimpinan memoderasi keberhasilan perubahan klinis berbasis bukti.

Stakeholder utama yang memegang peran kunci dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi EBN di ruang rawat antara lain pimpinan unit, kepala bidang keperawatan, perawat, dokter, tenaga pendukung, pasien dan keluarga, tim audit, tim teknologi dan informasi, dan tim keuangan). Identifikasi stakeholder ini sekaligus menentukan peran, harapan, kebutuhan informasi, serta potensi resistensi atau dukungan terhadap perubahan praktik keperawatan berbasis bukti yang menghasilkan komunikasi terarah dalam sebuah komite implementasi yang representatif. Pemetaan pemangku kepentingan secara praktik dapat dibuat dengan kolom matriks berisi siapa stakeholder yang terlibat, peran, tingkat pengaruh, kepentingan, kebutuhan informasi, strategi keterlibatan.

Analisis kesiapan budaya organisasi (*Organizational Readiness*) mengacu pada keyakinan bersama tentang kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan, komitmen terhadap perubahan, serta sumber daya dan infrastruktur pendukung yang diperlukan. Alat ukur yang relevan mencakup ORIC (*Organizational Readiness for Implementing Change*) yang menilai kapasitas collective efficacy, valensi perubahan, serta komitmen organisasi terhadap perubahan. Aspek yang perlu dieksplorasi antara lain Leadership engagement yaitu tingkat dukungan pimpinan terhadap inisiatif perubahan dan peran mereka sebagai agen perubahan dan sumber daya dan kapasitas: ketersediaan waktu, anggaran, infrastruktur data, serta kemampuan tim untuk menjalankan aktivitas implementasi dan evaluasi. Keberlanjutan dan adaptabilitas juga perlu diperhatikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan intervensi dengan konteks lokal dan kebutuhan pasien tanpa kehilangan fokus pada bukti. Survei ORIC pada level unit/organisasi, wawancara kelompok fokus dengan pemangku kepentingan kunci, serta analisis konteks inner setting menggunakan *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR) untuk mengidentifikasi barrier dan facilitators sebelum perubahan. Penilaian komitmen tim, kesiapan individu, dan persepsi terhadap manfaat jangka panjang perubahan melalui wawancara semi-terbuka dan kuesioner terstruktur.

Langkah operasional yang dapat dilakukan sebelum memulai perubahan praktik antara lain:

a. Identifikasi pemangku kepentingan inti dengan Menyusun daftar pemangku kepentingan dengan kriteria pengaruh dan kepentingan, lalu tentukan focal persons (leadership champions) dari setiap kelompok untuk memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan berkelanjutan
b. Petakan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan. Definisikan jenis informasi yang dibutuhkan (tujuan EBN, manfaat bagi pasien, dampak operasional), frekuensi komunikasi, dan bentuk umpan balik yang diharapkan; rancang kanal komunikasi yang inklusif dan transparan
c. Penilaian kesiapan budaya dengan menggunakan ORIC untuk menilai dan memahami budaya organisasi, iklim pembelajaran, dan kesiapan untuk perubahan.
d. Desain strategi keterlibatan stakeholder dengan menetapkan peran pemimpin perubahan (*nurse champions, physician champions, administrative champions*), mekanisme partisipasi (workshops, komunitas pembelajaran, forum umpan balik), dan rencana komunikasi dua arah yang aktif antara manajemen dan *front-line staff*.

e. Perancangan konteks evaluasi awal dengan menentukan indikator proses dan hasil yang akan memandu evaluasi awal serta bagaimana hasil evaluasi akan membentuk perbaikan perencanaan implementasi.

Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder kunci serta menganalisis kesiapan budaya organisasi adalah fondasi penting untuk merancang implementasi EBN yang efektif di ruang rawat. Pemetaan stakeholder memastikan dukungan luas dan kolaborasi lintas fungsi, sedangkan analisis kesiapan budaya membantu mengantisipasi hambatan struktural dan budaya, sehingga strategi keterlibatan serta rencana audit–umpan balik dapat dirancang secara tepat sasaran. Integrasi kedua komponen ini dengan kerangka kerja implementasi serta peran pemimpin perubahan akan meningkatkan peluang adopsi praktik berbasisi bukti secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas perawatan pasien.

3. Menyusun Indikator Evaluasi: Proses dan Hasil (*Outcome*)

Penyusunan indikator evaluasi yang terukur sangat penting untuk memantau keberhasilan implementasi dari dua dimensi utama: proses dan hasil klinis atau manajerial. Indikator proses mengukur perubahan perilaku perawat serta kepatuhan terhadap SOP, sedangkan indikator hasil mengevaluasi dampak intervensi terhadap pasien, efisiensi biaya, dan kepuasan pasien. Indikator yang dirancang secara SMART (Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, Berbatas waktu) memastikan bahwa evaluasi bersifat praktis, dapat direplikasi, dan memberikan umpan balik yang konkret untuk perbaikan berkelanjutan. Strategi ini selaras dengan rekomendasi metodologis terkait evaluasi intervensi keperawatan berbasis bukti yang menekankan pentingnya jelasnya kriteria pengukuran dan transparansi pelaporan.

Indikator Proses merupakan ukuran yang menggambarkan perubahan perilaku, aktivitas, atau perubahan praktik yang langsung berkaitan dengan implementasi SOP atau intervensi pendidikan. Contoh: kepatuhan terhadap SOP baru, kehadiran peserta pelatihan, partisipasi dalam sesi edukasi, penggunaan checklist di klinik/prosedur, dan frekuensi audit internal. Tujuan evaluasi proses untuk memantau adopsi intervensi, kualitas pelaksanaan, dan kesetiaan terhadap standar operasional. Indikator Hasil ukuran dampak yang lebih jauh terhadap pasien, manajemen fasilitas, atau kepuasan pelanggan/pasien contohnya penurunan insiden luka tekanan, efisiensi biaya perawatan, tingkat kepuasan pasien, waktu tunggu pelayanan, serta outcome klinis lainnya yang relevan dengan intervensi EBN. Tujuan evaluasi hasil untuk menilai manfaat klinis, operasional, dan pengalaman pasien sebagai hasil dari perubahan praktik. Kaitan antara kedua indikator tersebut adalah bahwa indikator proses menjadi mekanisme antara input (pelatihan, SOP) dan hasil klinis/manajerial. Keduanya

perlu terintegrasi melalui rancangan perbaikan kualitas, sehingga perubahan perilaku secara jelas dikaitkan dengan perubahan hasil yang terukur.

Penyusunan indikator menggunakan Prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

a. *Specific* (Spesifik)

Indikator harus jelas menggambarkan perilaku atau hasilyang diinginkan, misalnya persentase perawat yang mengisi checklist kepatuhan SOP baru pada setiap tindakan klinis atau persentase pasien yang mengalami kepuasan tinggi terhadap edukasi pasien keluarga. Hindari bahasa ambigu dan tentukan populasi, konteks, dan tindakan yang tepat.

b. *Measurable* (Terukur)

Menggunakan ukuran kuantitatif yang dapat diobservasi atau dihitung misalnya persentase, skor skala, rata-rata waktu. Tentukan unit ukur, alat ukur seperti form audit, temuan EHR, kuesioner kepuasan dan cara pengumpulan data yang konsisten.

c. *Achievable* (Dapat dicapai)

Sesuaikan target dengan sumber daya, personil, akses data. Target yang realistis meningkatkan peluang keberhasilan dan akurasi evaluasi. Diskusikan kapasitas audit, ketersediaan data, dan sumber daya pelatihan saat menetapkan target.

d. *Relevant* (Relevan)

Indikator harus relevan dengan tujuan implementasi EBN, kebutuhan pasien, dan prioritas institusi. Hindari indikator yang terlalu teknis atau tidak langsung terkait dengan praktik klinis yang diubah.

e. *Time-bound* (Berbatas waktu)

Tetapkan kerangka waktu untuk pengukuran misalnya bulan ke-3, kuartal ke-2, 12 bulan pasca-implementasi agar evaluasi memiliki kontinuitas dan dapat membentuk umpan balik berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Tabel 6. 3 Contoh desain operasional indikator proses dan hasil Implementasi EBN

Indikator Proses	**Indikator Hasil**
1. Kepatuhan terhadap SOP baru: persentase tindakan klinis yang diikuti sesuai SOP baru, dinilai melalui audit observasional selama bulan-bulan pasca implementasi	1. Hasil klinis: penurunan insiden luka tekanan pada unit rawat inap yang menerapkan SOP baru; peningkatan hasil klinis spesifik terkait intervensi seperti kontrol infeksi, manajemen nyeri

2. Kehadiran dan partisipasi pelatihan SOP: persentase staf yang menghadiri pelatihan SOP, persentase yang menyelesaikan *modul e-learning*, dan skor partisipasi dalam diskusi 3. Tingkat penggunaan checklist: frekuensi penggunaan checklist SOP pada prosedur kritis misalnya operasi, catatan pasien, pemberian obat per bulan 4. Ketepatan dokumentasi: persentase dokumentasi yang lengkap dan tepat waktu dalam rekam medis terkait intervensi yang didorong EBN 5. Hasil audit lintas desain: skor kualitas tinjauan/ringkasan bukti yang menjadi dasar SOP (mengacu pada pedoman terkait kualitas tinjauan seperti PRISMA, AMSTAR, MMAT jika applicable) untuk memastikan fondasi bukti yang konsisten sebelum integrasi ke praktik	2. Efisiensi biaya: perubahan total biaya perawatan per pasien setelah implementasi, misalnya biaya per pasien per hari atau total biaya per kasus 3. Kepuasan pasien: skor rata-rata kepuasan pasien terkait edukasi, komunikasi, dan pelayanan klinis 4. Indikator sistem/manajerial: waktu tunggu layanan, tingkat kepatuhan gabungan terhadap protokol keamanan pasien, atau metrik keamanan klinis lain yang relevan dengan tujuan EBN

Beberapa hal mungkin dihadapi sebagai tantangan umum seperti keterbatasan data bukti desain studi penelitian, validitas dan realibilitas pengukuran, interpretasi konteks implementasi, dan kesesuaian proses dan hasil. Ketidakcocokan desain studi dapat mempengaruhi interpretasi indikator hasil. Gunakan definisi operasional yang konsisten, jelaskan konteks desain studi, dan gunakan triangulasi data untuk memperkuat Kesimpulan. Jenis instrumen seperti checklist, kuesioner, form audit, harus dipastikan divalidasi, meminimalkan bias pengamat, dan dilakukan pelatihan bagi pengamat. Sertakan rujukan ke pedoman MMAT/PRISMA-AMSTAR dalam pelaporan evaluasi desain studi yang menjadi dasar indikator. Interpretasi konteks implementasi dapat meliputi perbedaan setting (rumah sakit, unit spesial, pandemi) mempengaruhi hasil dan hasl ini perlu didokumentasikan konteks tempat studi dan jelaskan bagaimana konteks tersebut mempengaruhi pencapaian target SMART. Kesesuaian antara

proses dan hasil perlu dipastikan hubungan logis antara perubahan perilaku (proses) dan dampak pada pasien/biaya (hasil) yang dapat dianalisis secara eksplisit; gunakan regresi sederhana atau analisis trend jika data memungkinkan, dan jelaskan faktor kontekstual yang memoderasi hubungan tersebut.

Penyusunan indikator evaluasi proses dan hasil yang SMART adalah kunci untuk mengukur dampak implementasi EBN secara komprehensif. Indikator proses menyediakan ukuran perubahan perilaku dan adopsi SOP, sedangkan indikator hasil menilai dampak klinis, manajerial, dan pengalaman pasien. Integrasi keduanya melalui kerangka SMART memungkinkan perawat dan manajemen rumah sakit bekerja secara terkoordinasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Pendekatan ini juga memfasilitasi umpan balik yang konkret untuk iterasi peningkatan, sehingga implementasi EBN menjadi proses belajar organisasi yang kontinu.

4. Audit Klinis, Umpan Balik (*Feedback*), dan Sustainabilitas

Audit klinis, umpan balik (*feedback*), dan sustainabilitas adalah tiga pilar penting dalam memastikan kelanjutan praktik berbasis bukti (EBN) setelah pedoman klinis diimplementasikan. Audit klinis berfungsi sebagai mekanisme verifikasi apakah praktik klinis memenuhi standar pedoman. Umpan balik (feedback) menjadi jembatan antara penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan, sustainabilitas menilai kemampuan organisasi untuk mempertahankan perubahan perilaku klinis dan dampaknya dalam jangka panjang. Ketiganya saling terkait, membentuk siklus waktu nyata dari implementasi hingga perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan pasien dapat ditingkatkan secara berkelanjutan (White & Dudley-Brown, 2024; Tucker et al., 2021).

Peran audit, umpan balik, dan sustainabilitas dalam konteks keperawatan perlu dipahami sebagai proses terintegrasi, bukan rangkaian terpisah. Audit memberikan data nyata tentang kepatuhan terhadap pedoman, umpan balik yang tepat waktu, jelas, dan konstruktif mendorong perubahan perilaku klinis, dan sustainabilitas memastikan perubahan tersebut bertahan meskipun ada perubahan personel, kebijakan, atau tekanan organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka implementasi seperti PARIHS, CFIR, dan ARCC yang menekankan konteks, strategi implementasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk adopsi jangka panjang (Tucker et al., 2021).

a. Audit klinis

Audit klinis merupakan proses sistematis untuk menilai kepatuhan praktik klinis terhadap pedoman berbasis bukti, standar mutu, atau indikator kinerja utama, dengan tujuan identifikasi kesenjangan, perencanaan perbaikan, dan

pemantauan dampaknya secara berkelanjutan. Audit dapat bersifat *pre-implementation, concurrent* (selama implementasi), atau *post-implementation*, dan sering menggunakan data rekam medis, observasi langsung, atau data proses/hasil pasien (White & Dudley-Brown, 2024)

b. Feedback (umpan balik)

Feedback merupakan mekanisme komunikasi terstruktur yang memberikan informasi mengenai kinerja aktual dibandingkan dengan standar atau target yang ditetapkan. Umpan balik yang efektif bersifat dengan waktu, spesifik, berbasis data, dan disampaikan dengan bahasa yang mendorong perbaikan tanpa menyalahkan individu, sehingga memelihara budaya pembelajaran dan peningkatan kualitas.

c. Sustainabilitas

Sustainabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan perubahan praktik berbasis bukti dalam jangka panjang, termasuk integrasi pedoman ke dalam SOP, alur kerja, pelatihan berkelanjutan, serta budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Sustainabilitas memerlukan perencanaan jangka panjang, alokasi anggaran, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk melihat dampak terhadap outcome pasien dan proses layanan.

d. Kerangka konseptual hubungan audit–feedback–sustainability

Audit memberikan data fakta terkait kepatuhan dan dampak perubahan; feedback mengubah data tersebut menjadi tindakan konkret melalui komunikasi efektif; sustainabilitas memastikan bahwa tindakan perbaikan menjadi bagian dari budaya kerja dan operasi rutin. Model-model implementasi seperti PARIHS, CFIR, ARCC menekankan bahwa konteks organisasi, dukungan manajemen, dan kemampuan pelaksanaan risiko perlu dipertimbangkan dalam merancang audit-umpan balik yang berkelanjutan. Integrasi ketiganya mendukung perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan konteks klinik. Siklus berkelanjutan: audit (apa yang terjadi) → umpan balik (apa yang perlu diubah) → perubahan implementasi → audit ulang. Siklus ini berulang untuk menjaga kualitas perawatan, memantau dampak terhadap outcome klinis, dan memastikan kelangsungan perubahan hingga menjadi bagian dari kebijakan organisasi.

e. Menggunakan siklus PDSA (Plan-Do-Study-Act) untuk *pilot project*

PDSA adalah kerangka perbaikan berkelanjutan yang memungkinkan uji coba perubahan secara bertahap sebelum implementasi luas. Dalam konteks EBN, PDSA digunakan untuk menguji intervensi berbasis bukti pada skala kecil,

mempelajari hambatan, mengukur dampak, dan menyesuaikan rencana sebelum ekspansi penuh. Prinsipnya adalah belajar sambil melakukan dengan iterasi berulang untuk meningkatkan proses dan hasil pasien. Umumnya, siklus ini mengusung fokus pada belajar cepat, adaptasi konteks, dan evaluasi singkat misalnya 2–6 minggu per putaran. Tahapan praktis PDSA antara lain:

1) *Plan*: merumuskan tujuan uji coba, menetapkan prediksi dampak, merencanakan data apa yang perlu dikumpulkan, menentukan perubahan yang akan diuji, serta menyiapkan sumber daya.
2) *Do*: menjalankan perubahan dalam unit pilot dengan pengawasan ketat, melakukan dokumentasi proses, serta mengumpulkan data secara real-time.
3) *Study*: menganalisis data untuk melihat apakah perubahan membawa perbaikan yang diharapkan, mengidentifikasi hambatan proses, serta mengevaluasi apakah hasilnya relevan secara klinis.
4) *Act*: jika hasil menunjukkan perbaikan, adopsi secara lebih luas; jika tidak, perbaiki atau hentikan perubahan tersebut dan rancang siklus baru.

f. Strategi audit klinis tanpa membuat staf merasa dihakimi (budaya blame-free)

Audit klinis harus dipandang sebagai alat peningkatan mutu, bukan hukuman. Budaya blame-free membantu staf merasa aman untuk melaporkan kesalahan atau deviasi tanpa takut sanksi, sehingga data audit lebih jujur dan akurat untuk tindakan perbaikan. Budaya seperti ini meningkatkan partisipasi staf dalam audit, transparansi, dan pembelajaran kolektif. Praktik terbaik untuk budaya *blame-free* anatar lain:

1) Fasilitasi lingkungan aman: klarifikasi bahwa audit berfokus pada proses, bukan individu; jelaskan tujuan, manfaat, dan rencana perbaikan secara jelas.
2) Gunakan pendekatan 'no-blame' bersama evaluasi sistemik: identifikasi faktor sistemik (kelangkaan waktu, beban kerja, akses alat) yang menyebabkan deviasi, bukan sekadar menilai perilaku individu.
3) Reduksi tekanan psikologis: berikan umpan balik yang empatik, gunakan bahasa yang netral, fokus pada solusi, dan lakukan umpan balik pribadi hanya jika diperlukan.
4) Transparansi data: bagikan hasil audit secara anonim untuk menjaga privasi, tetapi tetap adil dalam menginformasikan tim.
5) Pelatihan dan dukungan: sediakan pelatihan tentang analisis proses, diagram alir proses, serta penggunaan data audit untuk perbaikan.
6) Audit proses berbasiskan bukti: fokus pada kepatuhan terhadap SOP baru, waktu respons, dan akurasi dokumentasi; hindari evaluasi personalisasi terhadap individu.

7) Audit berkelanjutan tanpa gangguan kualitas layanan: lakukan audit saat workflow berjalan normal atau di saat beban kerja tidak sangat tinggi untuk meminimalkan beban kerja tambahan.
8) Umpan balik kolaboratif: adakan sesi diskusi kelompok kecil untuk memahami hambatan implementasi dan mengidentifikasi solusi bersama. 4) Hasil yang diharapkan
9) Peningkatan keterlibatan staf, peningkatan akurasi data, dan perubahan perilaku klinis yang lebih konsisten terhadap pedoman berbasis bukti.
10) Peningkatan budaya keselamatan pasien dan kepercayaan tim terhadap proses mutu.

Audit klinis, umpan balik, dan sustainabilitas adalah rangkaian kunci untuk memastikan adopsi bukti yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan PDSA untuk pilot studi, budaya *blame-free* dalam audit, dan praktik umpan balik efektif, organisasi keperawatan dapat meningkatkan mutu layanan pasien secara berkelanjutan dan menguatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan pedoman klinis.

C. Rangkuman

Integrasikan bukti ilmiah ke dalam asuhan keperawatan modern dengan *Evidence-Based Nursing* atau EBN menjadi hal yang esensial untuk mengatasi kesenjangan antara hasil riset dan praktik klinis. Penerapan EBN secara konsisten terbukti dapat meminimalkan intervensi yang tidak perlu, meningkatkan keselamatan pasien, mengoptimalkan biaya, dan mempercepat penyembuhan.
Bab pada buku ajar ini berfokus pada dua capaian utama:

1. Sintesis Bukti dan Perumusan Rekomendasi
   a. memberikan perbedaan antara sekadar merangkum literatur (*summarizing*) dan mensintesis bukti (*synthesizing*) yang bertujuan menghasilkan pemahaman terintegrasi untuk keputusan klinis.
   b. Ekstraksi data dari berbagai desain penelitian diorganisasi menggunakan Matriks Sintesis Literatur untuk memfasilitasi perbandingan dan integrasi temuan.
   c. Kualitas dan kekuatan bukti (*level of evidence*) dinilai menggunakan kerangka standar seperti Melnyk & Fineout-Overholt, JBI, atau GRADE untuk memastikan keandalan temuan hasil.
   d. Perumusan rekomendasi dilakukan menggunakan kerangka A-B-C-D (*Assess, Baseline/contextual factors, Choices, Deliverables*) agar operasional dan siap diterapkan di praktik.

2. Perancangan Implementasi dan Evaluasi Berkelanjutan
   a. Keberhasilan implementasi dimulai dengan mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* kunci serta menganalisis kesiapan budaya organisasi.
   b. Evaluasi dilakukan dengan menyusun indikator proses dan hasil (*outcome*) yang terstruktur dengan kriteria SMART (Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, Berbatas waktu).
   c. Untuk memastikan perubahan bertahan dalam jangka panjang (*sustainability*), diperlukan audit klinis untuk menilai kepatuhan, umpan balik (*feedback*) yang konstruktif, serta uji coba perubahan menggunakan siklus PDSA (*Plan-Do-Study-Act*).

Penutup Implementasi hasil riset ke dalam asuhan keperawatan bukan sekadar tuntutan akademis, melainkan sebuah tanggung jawab etis dari profesi keperawatan. Walaupun terdapat hambatan sistemik dan kultural di tatanan layanan kesehatan, pendekatan *implementation science* memberikan jalan keluar yang terstruktur. Melalui penguasaan sintesis literatur, perencanaan implementasi yang matang, serta pelaksanaan audit klinis dan umpan balik yang mengedepankan budaya tanpa menyalahkan (*blame-free*), perawat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen riset. Tujuannya adalah mencetak perawat sebagai agen perubahan yang tangguh, yang mampu menerjemahkan bukti ilmiah menjadi praktik klinis yang aman, efektif, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan pasien di dunia nyata.

Latihan Evaluasi Pembelajaran

Aktivitas 1 — *Knows How*
Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Studi Kasus 1: Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti

Mahasiswa diberikan 5 artikel tentang manajemen nyeri non-farmakologis, lalu diminta membuat matriks data dan menuliskan satu paragraf rekomendasi klinis. Tugas ini mencakup panduan bagaimana memilih rekomendasi tingkat tinggi/kuat (Strong) berdasarkan kualitas bukti, relevansi klinis, dan konsistensi temuan. Berikut 5 artikel tentang manajemen nyeri non-farmakologis.

1. Ari, E. S., Sotunsa, J. O., Leslie, T. A., Inuwa Ari, S., & Kumzhi, P. R. (2019). Impact of an educational intervention on postpartum perineal wound care among antenatal mothers in Jos: A quasiexperimental study. *Clinical Practice*, *16*(6), 1409-1422.
2. Rice, K., Castex, J., Redmond, M., Burton, J., Guo, J., & Beck, S. (2019). Bundling Interventions to Enhance Pain Care Quality (BITE Pain) in Medical Surgical Patients. Ochsner Journal, 19(2), 77-95. https://doi.org/10.31486/toj.18.0164
3. Rodrigues, V. A., Abreu, Y. R., Santos, C. A., Gatti, A. F., Murer, G. M., Gontijo, B. D., ... & Paro, H. B. (2022). Nonpharmacological labor pain management methods and risk of cesarean birth: A retrospective cohort study. *Birth*, *49*(3), 464-473.
4. Suh, Y., Lee, S., Kim, G., & Lee, J. (2022). Systematic review and meta-analysis of randomization controlled and nonrandomized controlled studies on nurse-led nonpharmacological interventions to improve cognition in people with dementia. Journal of Clinical Nursing, 32(13-14), 3155-3172. https://doi.org/10.1111/jocn.16430
5. Valeberg, B., Dihle, A., Småstuen, M., Endresen, A., & Rustøen, T. (2021). The effects of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgery: A randomised clinical trial. Journal of Clinical Nursing, 30(7-8), 1132-1143. https://doi.org/10.1111/jocn.15659

Petunjuk tugas

1. Buat matriks data berisi 5 artikel dengan kolom: Studi, Desain, Populasi, Intervensi, Outcome, Ukuran Efek, Risiko Bias, Relevansi Klinik, Feasibility.
2. Lakukan penilaian kualitas bukti per outcome menggunakan kerangka yang dipilih (mis. GRADE).

3. Tulis paragraf rekomendasi tingkat tinggi yang konsisten dengan penilaian kualitas bukti dengan struktur yang diharapkan:
   a. Pembuka singkat: jelaskan konteks klinik dan masalah nyeri.
   b. Ringkasan singkat temuan utama dari lima artikel (tanpa mengulang semua detail).
   c. Pernyataan rekomendasi utama (Strong) dengan justifikasi (desain studi, konsistensi temuan, relevansi klinis, feasibility).
   d. Pertimbangan konteks implementasi (kesiapan fasilitas, pelatihan, skor risiko/biaya).
   e. Sertakan bagian catatan implementasi di fasilitas klinik pilihan, termasuk indikator evaluasi.
   f. Rencana evaluasi implementasi dan mitigasi ketidakpastian.
   g. Penutup yang menegaskan manfaat bagi pasien dan kualitas praktik keperawatan.

Studi Kasus 2: Merancang rencana implementasi EBN (*stakeholder*, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur "Merancang timeline implementasi 3 bulan dan form audit sederhana untuk EBN pencegahan pasien jatuh"

Rumah Sakit Umum X berencana mengimplementasikan paket intervensi pencegahan jatuh berbasis bukti yang mencakup identifikasi risiko jatuh, modifikasi lingkungan, edukasi pasien, pelatihan staf, dan jalur pelaporan kejadian jatuh. Manajemen rumah sakit menetapkan target menurunkan angka jatuh per 1.000 pasien/hari sebesar 20% dalam 6 bulan setelah implementasi, dengan fokus awal pada bangsal dewasa dan unit geriatri.

Petunjuk tugas:
1. Mahasiswa membuata timeline implementasi 3 bulan untuk program pencegahan jatuh berbasis bukti
2. Mahasiswa mendesain form audit sederhana yang dapat dipakai untuk memantau kepatuhan dan dampak pencegahan jatuh
3. Mahasiswa membuat panduan indikator evaluasi pascaimplementasi selama 3 bulan dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

D. Latihan Soal

1. Seorang perawat di ruang rawat inap menemukan bahwa praktik reposisi pasien untuk mencegah luka tekan berbeda antar shift. Perawat kemudian mengumpulkan 8 artikel penelitian (RCT, kohort, dan kualitatif), membandingkan hasil, menilai kualitas bukti, dan menyimpulkan bahwa reposisi setiap 2 jam paling efektif pada pasien risiko tinggi. Apa tindakan yang telah dilakukan perawat tersebut?
   A. Literature review
   B. Summarizing literatur
   C. Sintesis bukti klinis
   D. Critical appraisal saja
   E. Meta-analisis

2. Seorang mahasiswa menyusun matriks sintesis literatur untuk topik manajemen nyeri pasca operasi. Mahasiswa memasukkan kolom: peneliti, desain studi, populasi, intervensi, outcome, dan kualitas bukti. Apa tujuan utama penggunaan matriks tersebut?
   A. Mengurangi jumlah artikel
   B. Memudahkan publikasi jurnal
   C. Mengorganisasi dan membandingkan bukti secara sistematis
   D. Menghindari bias penelitian
   E. Menggantikan systematic review

3. Dalam sintesis bukti, ditemukan hasil penelitian yang bertentangan terkait efektivitas intervensi edukasi pasien DM. Sebagian studi menunjukkan hasil signifikan, sebagian tidak. Apa langkah paling tepat untuk kondisis tersebut?
   A. Mengabaikan studi yang tidak signifikan
   B. Menggunakan hanya RCT
   C. Menganalisis konteks, desain, dan risiko bias
   D. Mengambil kesimpulan mayoritas
   E. Menghentikan sintesis

4. Seorang perawat menggunakan GRADE untuk menilai bukti intervensi edukasi pasien. Hasil menunjukkan kualitas bukti “moderate” dengan manfaat lebih besar dari risiko. Bagaimana rekomendasi yang paling tepat untuk kondisi tersebut?
   A. Tidak direkomendasikan
   B. Rekomendasi kuat tanpa syarat

C. Rekomendasi kondisional dengan evaluasi implementasi
D. Menunggu penelitian lanjutan
E. Digunakan hanya untuk penelitian

5. Dalam pendekatan A-B-C-D, seorang perawat menentukan indikator seperti kepatuhan SOP dan penurunan luka tekan sebelum implementasi intervensi. Apa langkah yang dilakukan pada kondisi tersebut?
   A. Assess
   B. Baseline
   C. Choices
   D. Deliverables
   E. Evaluation
   .
6. Sebuah rumah sakit akan menerapkan SOP baru pencegahan infeksi. Tim mengidentifikasi kepala ruangan, perawat, dokter, pasien, dan manajemen sebagai pihak yang terlibat. Apa langkah yang dilakukan pada kondisi tersebut?
   A. Analisis outcome
   B. Identifikasi stakeholder
   C. Audit klinis
   D. Penyusunan indikator
   E. Evaluasi implementasi

7. Dalam sebuah implementasi EBN, indikator yang digunakan antara lain adalah persentase perawat mengikuti SOP (90%) dan Jumlah pelatihan yang diikuti staf. Apa jenis indikator yang tepat pada implementasi tersebut?
   A. Outcome
   B. Struktur
   C. Proses
   D. Efisiensi
   E. Kualitas

8. Tim implementasi EBN pada salah satu rumah sakit menggunakan indikator yaitu penurunan insiden luka tekan 30% dalam 6 bulan. Apa indikator ini yang tepat pada implementasi tersebut?
   A. Proses
   B. Output
   C. Outcome

D. Struktur
E. Input

9. Dalam siklus PDSA, tim mencoba SOP baru pada satu ruangan selama 2 minggu, mengumpulkan data, lalu mengevaluasi hasilnya. Apa tahapan yang tepat pada kondisi tersebut?
   A. Plan
   B. Do
   C. Study
   D. Act
   E. Implement

10. Saat audit klinis, kepala ruangan memberikan umpan balik kepada perawat dengan pendekatan tidak menyalahkan individu, tetapi fokus pada perbaikan sistem. Apa pendekatan yang tepat pada kondisi implementasi tersebut?
   A. Evidence-based audit
   B. Blame culture
   C. Punishment system
   D. Blame-free culture
   E. Performance control

Aktivitas 2 —*Shows How*

Tugas Proyek Kelompok: Membuat proposal mini EBN dari masalah di tempat praktik klinis (PKL) mahasiswa.
Penyusunan Proposal Mini Evidence-Based Nursing (EBN)

Tugas	Keterangan
Nama Tugas	Penyusunan Proposal Mini Evidence-Based Nursing (EBN) berdasarkan masalah nyata yang ditemukan di lahan praktik klinis. Proposal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan konteks praktik dalam upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan
Tujuan Tugas	Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu: a. Mengidentifikasi masalah praktik keperawatan yang relevan dan prioritas b. Merumuskan pertanyaan klinis menggunakan pendekatan PICO(T) c. Menelusuri dan mensintesis bukti ilmiah secara sistematis d. Menilai kualitas dan kekuatan bukti (level of evidence) e. Menyusun rekomendasi berbasis bukti yang aplikatif f. Merancang rencana implementasi EBN yang terukur (stakeholder, indikator, audit–feedback)
Waktu Pelaksanaan Tugas	Selama minggu perkuliahan
Waktu Penyerahan Tugas	1 Minggu setelah jadwal perkuliahan dan yang diupload dalam LMS
Uraian Tugas	**Ketentuan Umum** a. Tugas dikerjakan dalam kelompok (4–5 mahasiswa) b. Masalah diambil dari pengalaman praktik klinis nyata (misalnya: luka tekan, kepatuhan hand hygiene, manajemen nyeri, edukasi pasien, dll.) c. Menggunakan minimal 5–10 artikel ilmiah (7 tahun terakhir)

		d. Mengutamakan jurnal bereputasi (Scopus, PubMed, CINAHL, dll.) e. Proposal disusun secara sistematis dan berbasis data f. Gunakan bahasa ilmiah dan sistematis g. Sertakan referensi APA Style (7 tahun terakhir) a. Gunakan tabel untuk : Matriks sintesis, Level of evidence, Indikator evaluasi b. Sertakan diagram (opsional): alur PICO, PDSA, stakeholder mapping **Sistematika Proposal Mini EBN** **BAB I. Pendahuluan** a. Latar belakang masalah (berbasis data klinis/observasi) b. Rumusan masalah c. Tujuan (umum dan khusus) d. Manfaat (praktik, pasien, institusi) **BAB II. Tinjauan Pustaka dan Sintesis Bukti** a. Konsep teoritis terkait masalah b. Penyusunan pertanyaan PICO(T) c. Strategi pencarian literatur d. Matriks sintesis literatur (ringkasan artikel) e. Analisis kualitas bukti (misalnya GRADE/JBI) f. Sintesis temuan (konsistensi, gap, implikasi) **BAB III. Rekomendasi Berbasis Bukti** Menggunakan pendekatan A-B-C-D, meliputi: a. A (Assess): kualitas dan kekuatan bukti b. B (Baseline): konteks klinik dan preferensi pasien c. C (Choices): alternatif intervensi dan pilihan utama d. D (Deliverables): indikator implementasi **BAB IV. Rencana Implementasi EBN** a. Model implementasi (misalnya Iowa Model / PDSA) b. Identifikasi dan analisis stakeholder c. Analisis kesiapan organisasi (opsional: ORIC) d. Rencana aksi (timeline kegiatan) e. Indikator evaluasi: Indikator proses & Indikator hasil (outcome)

		f. Rencana audit klinis dan umpan balik g. Strategi sustainabilitas **BAB V. Penutup** a. Kesimpulan b. Rekomendasi implementasi
Bentuk Luaran		1. Dokumen proposal mini EBN (±10–15 halaman) 2. Matriks sintesis literatur 3. Tabel indikator evaluasi 4. Rencana implementasi yang aplikatif
Komponen Penilaian		Identifikasi masalah & PICO(T): 15 % Kualitas pencarian & sintesis literatur: 25% Analisis level of evidence: 15% Rekomendasi berbasis bukti (A-B-C-D): 15% Rencana implementasi (stakeholder, indikator, audit): 20% Sistematika & presentasi: 10%

Rubrik Penilaian CPMK-7

Indikator	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

Referensi

Bourgault, A., Davis, J., LaManna, J., Turnage, D., & Conner, N. (2025). A Crosswalk Analysis of Commonly Used Evidence-Based Practice Models. International Journal of Nursing Practice, 31(4). https://doi.org/10.1111/ijn.70034

Chays-Amania, A., Schwingrouber, J., & Colson, S. (2025). Using implementation science to implement evidence-based practice: A discursive paper. *Journal of Advanced Nursing*, *81*(11), 8050-8061.

Cowman, S. (2017). Bedside to bench: re-thinking nursing research. Journal of Advanced Nursing, 74(2), 235-236. https://doi.org/10.1111/jan.13254

Cowman, S. (2019). Nursing research and patient care: A case for the bedside rather than the bench. Journal of Nursing Management, 27(4), 679-680.

Gaffield, M. L., & WHO. (2011, June). Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). In *Training Course In Sexual And Reproductive Health Research Geneva Workshop*

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2010). ARCC (Advancing Research and Clinical practice through close Collaboration). *Models and Frameworks for Implementing Evidence-Based Practice: Linking Evidence to Action*, *169*.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2022). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice*. Lippincott Williams & Wilkins.

Rycroft-Malone, J. (2010). Promoting action on research implementation in health services (PARIHS). *Models and frameworks for implementing evidence-based practice: linking evidence to action*, *109*, 135.

Schaffer, M. A., Sandau, K. E., & Diedrick, L. (2013). Evidence-based practice models for organizational change: overview and practical applications. *Journal of advanced nursing*, *69*(5), 1197-1209.

Shea, C. M., Jacobs, S. R., Esserman, D. A., Bruce, K., & Weiner, B. J. (2014). Organizational readiness for implementing change: a psychometric assessment of a new measure. *Implementation science*, *9*(1), 7.

Pearson, A. (2010). The Joanna Briggs Institute model of evidence-based health care as a framework for implementing evidence. *Models and frameworks for*

implementing evidence-based practice: Linking evidence to action, 185-203.

Tsai, H., Wang, H., Sakashita, R., Oh, E., Chen, C., & Im, E. (2024). Current Status of Translational Science in Nursing Across Four Countries. Advances in Nursing Science, 47(3), 302-315. https://doi.org/10.1097/ans.0000000000000537

Tucker, S., McNett, M., Melnyk, B., Hanrahan, K., Hunter, S., Kim, B., … & Kitson, A. (2021). Implementation Science: Application of Evidence-Based Practice Models to Improve Healthcare Quality. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 18(2), 76-84. https://doi.org/10.1111/wvn.12495

White, K. M., Dudley-Brown, S., & Terhaar, M. F. (Eds.). (2024). *Translation of evidence into nursing and healthcare*. Springer Publishing Company.

BAB 6

PENYUSUNAN PROPOSAL, SKRIPSI, DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah	6.1 Menyusun dokumen proposal/skripsi dengan konsistensi metodologis (latar–metode–rencana analisis–etik).	6.2 Menyusun manuskrip/presentasi ilmiah dengan sitasi benar, struktur IMRAD, dan kepatuhan etika publikasi.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Tugas telaah pustaka ringkas + matriks literatur	Reproducibility strategi pencarian (kriteria jelas) dan kualitas sintesis/kerangka konsep (skor rubrik).	15	Matriks literatur; kerangka konsep
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan identifikasi isu etik pada skenario	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				ukur) dan rencana audit jelas

Pendahuluan

Buku ajar ini disusun untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan kemampuan melakukan penelitian ilmiah serta menerapkan prinsip Evidence-Based Nursing (EBN) dalam praktik keperawatan. Buku ini secara khusus menekankan keterampilan akademik yang penting bagi mahasiswa, yaitu menyusun proposal penelitian, skripsi, serta publikasi ilmiah secara sistematis, ilmiah, dan sesuai standar akademik.

Buku ajar ini disusun oleh penulis yang merupakan dosen keperawatan yang memiliki pengalaman dalam pendidikan, penelitian, serta pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Dalam proses pendidikan keperawatan, kemampuan melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai calon perawat profesional.

Selama proses pembelajaran dan pembimbingan skripsi, penulis menemukan bahwa banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami tahapan penelitian, menyusun proposal penelitian yang sistematis, menulis laporan skripsi yang baik, serta mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai panduan praktis dan sistematis untuk membantu mahasiswa memahami proses penelitian keperawatan dari tahap perencanaan hingga diseminasi hasil penelitian.

Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya *Evidence-Based Nursing*, yaitu praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta kebutuhan pasien. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan mahasiswa tidak hanya memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing.
2. Membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian keperawatan secara sistematis dan ilmiah.
3. Membantu mahasiswa memahami langkah-langkah dalam penyusunan skripsi sesuai kaidah penulisan ilmiah.

4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah dan publikasi hasil penelitian.
5. Mendorong mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang relevan dengan praktik keperawatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dengan membaca buku ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah yang berkualitas serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan hasil penelitian sebagai dasar praktik keperawatan.

Buku ini ditujukan untuk:

1. Mahasiswa Program Studi Keperawatan, khususnya yang sedang mempelajari mata kuliah Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing.
2. Mahasiswa yang sedang menyusun proposal penelitian atau skripsi.
3. Dosen dan pembimbing akademik yang terlibat dalam bimbingan penelitian mahasiswa.
4. Tenaga kesehatan yang ingin memahami proses penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang keperawatan.

Materi dalam buku ini mencakup:

1. Konsep dasar riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing
2. Penyusunan proposal penelitian keperawatan
3. Penyusunan skripsi keperawatan
4. Teknik penulisan ilmiah
5. Publikasi ilmiah dalam keperawatan
6. Etika penelitian dan publikasi ilmiah

Buku ini dirancang sebagai buku ajar interaktif yang tidak hanya berisi konsep teori tetapi juga dilengkapi dengan berbagai komponen pembelajaran, antara lain:

- Penjelasan konsep secara sistematis
- Contoh penulisan proposal dan skripsi penelitian keperawatan
- Latihan dan tugas untuk mahasiswa

Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep penelitian secara teoretis sekaligus praktis.

Pendekatan pembelajaran dalam buku ini menggunakan beberapa strategi, yaitu:

1. Student-Centered Learning
   Mahasiswa didorong untuk aktif mengeksplorasi masalah penelitian yang relevan dengan praktik keperawatan.
2. Evidence-Based Approach
   Setiap konsep penelitian dikaitkan dengan penerapan Evidence-Based Nursing dalam praktik klinis.

3. Problem-Based Learning
   Mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi masalah nyata di bidang kesehatan dan mengembangkannya menjadi topik penelitian.
4. Active Learning
   Melalui latihan, diskusi, dan studi kasus, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Agar buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal, pembaca disarankan untuk:

1. Membaca setiap bab secara berurutan karena materi disusun secara bertahap dan saling berkaitan.
2. Memahami konsep dasar sebelum melanjutkan ke tahap penyusunan proposal atau skripsi.
3. Mengerjakan latihan atau tugas yang tersedia pada setiap bab untuk memperkuat pemahaman.
4. Menggunakan contoh-contoh yang tersedia sebagai panduan dalam menyusun proposal dan skripsi.
5. Mendiskusikan materi dengan dosen atau teman untuk memperdalam pemahaman.

Dengan mengikuti pedoman ini, pembaca dapat memperoleh manfaat maksimal dari buku ajar ini.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mempelajari materi pada bab Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyusun karya ilmiah penelitian keperawatan secara sistematis, mulai dari proposal penelitian, penyusunan skripsi, hingga publikasi ilmiah berdasarkan prinsip penelitian dan Evidence-Based Nursing.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar karya ilmiah dalam bidang keperawatan.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis karya ilmiah dalam pendidikan keperawatan.
3. Menjelaskan peran penelitian dalam pengembangan Evidence-Based Nursing.
4. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi proposal penelitian.
5. Mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam struktur proposal penelitian keperawatan.
6. Menyusun judul penelitian keperawatan yang jelas, spesifik, dan relevan dengan masalah kesehatan.
7. Menyusun latar belakang penelitian yang menggambarkan urgensi masalah penelitian.

8. Merumuskan **rumusan masalah penelitian** secara jelas dan sistematis.
9. Menyusun **tujuan penelitian dan manfaat penelitian** secara tepat.
10. Menyusun **tinjauan pustaka dan kerangka konsep penelitian** berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.
11. Menjelaskan komponen metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, dan teknik analisis data.
12. Menjelaskan struktur dan sistematika **penulisan skripsi keperawatan**.
13. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk **skripsi secara sistematis**.
14. Menggunakan **bahasa ilmiah dan teknik sitasi** yang benar dalam penulisan karya ilmiah.
15. Menjelaskan prinsip **etika penelitian dan etika publikasi ilmiah**.
16. Menjelaskan struktur **artikel ilmiah dari hasil penelitian**.
17. Mengubah laporan skripsi menjadi **artikel ilmiah yang siap dipublikasikan**.
18. Mengidentifikasi jurnal ilmiah yang sesuai untuk publikasi penelitian keperawatan.
19. Menjelaskan proses **submission dan review artikel ilmiah pada jurnal**.
20. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun dan mempublikasikan hasil penelitian keperawatan.

Aktivitas Belajar *(Scaffolding)*

Uraian Materi

Penelitian merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu keperawatan. Melalui penelitian, perawat dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan praktik keperawatan. Dalam pendidikan keperawatan, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penelitian ilmiah secara sistematis dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya ilmiah seperti proposal penelitian, skripsi, dan artikel ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses penyusunan proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan.

Uraian materi pada bab ini membahas secara sistematis tahapan penyusunan karya ilmiah penelitian keperawatan, mulai dari perencanaan penelitian melalui penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam skripsi, hingga diseminasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah.

A. Konsep Dasar Riset Keperawatan

1. Pengertian Riset Keperawatan

   Riset keperawatan merupakan proses ilmiah yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, serta pengembangan kebijakan kesehatan. Penelitian dalam bidang keperawatan bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti.

   Menurut Polit dan Beck, riset keperawatan adalah suatu proses ilmiah yang sistematis yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat mendukung praktik keperawatan yang efektif dan berkualitas (Polit & Beck, 2021). Penelitian keperawatan mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari intervensi klinis, manajemen keperawatan, pendidikan keperawatan, hingga promosi kesehatan di masyarakat.

   Riset keperawatan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

   a. Sistematis, yaitu dilakukan melalui tahapan penelitian yang jelas mulai dari identifikasi masalah hingga penyajian hasil penelitian.
   b. Objektif, yaitu didasarkan pada data dan fakta yang dapat diuji secara ilmiah.
   c. Empiris, yaitu berdasarkan pengamatan dan pengalaman nyata di lapangan.
   d. Replikatif, yaitu penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama untuk memverifikasi hasil penelitian.

   Dalam praktiknya, penelitian keperawatan sangat penting untuk menghasilkan inovasi dalam pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan keperawatan.

2. Tujuan dan Manfaat Riset Keperawatan

   Tujuan utama dari riset keperawatan adalah menghasilkan pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik keperawatan. Penelitian memungkinkan perawat untuk memahami fenomena kesehatan secara lebih mendalam dan mengembangkan intervensi yang efektif dalam perawatan pasien.

   Secara umum, tujuan riset keperawatan meliputi:

   a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan.
   b. Mengidentifikasi dan memahami masalah kesehatan yang dihadapi pasien dan masyarakat.
   c. Mengembangkan metode dan intervensi keperawatan yang lebih efektif.
   d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
   e. Mendukung praktik keperawatan berbasis bukti.

Selain itu, penelitian juga memberikan manfaat yang luas dalam dunia keperawatan, antara lain meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta memberikan dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan kesehatan.

Penelitian keperawatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas praktik keperawatan melalui pengembangan teori, peningkatan efektivitas intervensi keperawatan, serta peningkatan keselamatan pasien (S. K. Grove & Gray, 2018).

3. Proses Riset Keperawatan

Proses penelitian keperawatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah dan menghasilkan temuan yang valid.

Tahapan umum dalam penelitian keperawatan meliputi:

a. Identifikasi masalah penelitian
   Peneliti mengidentifikasi masalah kesehatan atau fenomena yang memerlukan penelitian.
b. Tinjauan Pustaka
   Peneliti mempelajari teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.
c. Perumusan pertanyaan penelitian atau hipotesis
   Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian.
d. Perancangan metode penelitian
   Peneliti menentukan desain penelitian, populasi dan sampel, serta metode pengumpulan data.
e. Pengumpulan data
   Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau metode lainnya.
f. Analisis data
   Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik atau analisis kualitatif.
g. Interpretasi dan pelaporan hasil penelitian
   Hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan ilmiah seperti skripsi, artikel ilmiah, atau laporan penelitian.

Proses penelitian ini merupakan dasar dalam penyusunan proposal penelitian dan skripsi, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

4. Konsep Evidence-Based Nursing

Evidence-Based Nursing (EBN) merupakan pendekatan dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik dengan pengalaman klinis serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

Evidence-based practice dalam keperawatan adalah pendekatan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta preferensi pasien untuk menghasilkan keputusan klinis yang optimal (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015).

Konsep Evidence-Based Nursing muncul sebagai respons terhadap kebutuhan praktik keperawatan yang lebih ilmiah dan berbasis data. Dengan menggunakan hasil penelitian yang valid, perawat dapat memberikan intervensi yang lebih efektif, aman, dan berkualitas.

EBN memiliki tiga komponen utama, yaitu:

a. Best research evidence
   Bukti ilmiah terbaik yang diperoleh dari penelitian yang valid dan terpercaya.
b. Clinical expertise
   Pengalaman dan keterampilan klinis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan.
c. Patient values and preferences
   Nilai, kebutuhan, dan preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga komponen tersebut harus dipertimbangkan secara bersama-sama dalam praktik keperawatan.

5. Tahapan Implementasi Evidence-Based Nursing

Penerapan Evidence-Based Nursing dalam praktik keperawatan biasanya dilakukan melalui beberapa langkah sistematis.

Terdapat tujuh langkah utama dalam penerapan EBN (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015), yaitu:

a. Menumbuhkan semangat untuk melakukan praktik berbasis bukti.
b. Merumuskan pertanyaan klinis yang jelas menggunakan pendekatan
c. PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome).
d. Mencari bukti ilmiah terbaik dari berbagai sumber penelitian.
e. Menilai kualitas dan validitas bukti penelitian yang ditemukan.
f. Mengintegrasikan bukti penelitian dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien.
g. Mengevaluasi hasil penerapan praktik berbasis bukti.
h. Menyebarluaskan hasil praktik berbasis bukti kepada tenaga kesehatan lainnya.

Melalui proses ini, penelitian keperawatan dapat digunakan secara langsung dalam praktik klinik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

6. Hubungan Riset Keperawatan dengan Evidence-Based Nursing

   Riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing memiliki hubungan yang sangat erat. Penelitian menghasilkan bukti ilmiah yang menjadi dasar dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

   Tanpa penelitian, praktik keperawatan akan bergantung pada pengalaman atau kebiasaan semata, yang belum tentu memberikan hasil terbaik bagi pasien. Sebaliknya, dengan adanya penelitian, praktik keperawatan dapat didasarkan pada bukti ilmiah yang telah diuji secara sistematis.

   Penelitian keperawatan memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi praktik keperawatan dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan evidence-based practice (Houser, 2023).

   Dengan demikian, kemampuan melakukan penelitian dan memahami hasil penelitian menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan.

7. Peran Mahasiswa Keperawatan dalam Pengembangan Evidence-Based Nursing

   Mahasiswa keperawatan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Melalui kegiatan penelitian seperti penyusunan proposal penelitian dan skripsi, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi praktik keperawatan.

   Selain itu, mahasiswa juga perlu memiliki kemampuan untuk:

   a. Mengkritisi hasil penelitian ilmiah.
   b. Menggunakan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan klinis.
   c. Mengembangkan inovasi dalam praktik keperawatan.
   d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah.

   Kemampuan tersebut akan membantu mahasiswa menjadi perawat profesional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.

B. Penyusunan proposal penelitian keperawatan

1. Pengertian Proposal Penelitian Keperawatan

   Proposal penelitian merupakan rancangan atau rencana penelitian yang disusun secara sistematis sebelum penelitian dilaksanakan. Proposal berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian serta sebagai

dasar untuk memperoleh persetujuan dari pembimbing, institusi pendidikan, maupun komite etik penelitian.

Dalam konteks pendidikan keperawatan, proposal penelitian menjadi langkah awal yang harus disusun oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian skripsi. Proposal memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian teori, serta metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci rencana penelitian yang akan dilakukan, termasuk tujuan penelitian, metodologi, serta prosedur pengumpulan dan analisis data (Polit & Beck, 2021). Proposal penelitian membantu peneliti untuk merencanakan penelitian secara sistematis sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Selain itu, proposal penelitian juga berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keperawatan.

2. Tujuan Penyusunan Proposal Penelitian

Penyusunan proposal penelitian memiliki beberapa tujuan penting dalam proses penelitian, khususnya dalam bidang keperawatan. Proposal tidak hanya berfungsi sebagai rencana penelitian, tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmiah antara peneliti dengan pembimbing maupun institusi penelitian.

Tujuan penyusunan proposal penelitian antara lain:

a. Memberikan gambaran sistematis mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan.
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
c. Memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar teoritis dan metodologis yang jelas.
d. Memperoleh persetujuan dari pembimbing atau lembaga terkait sebelum penelitian dilaksanakan.
e. Menilai kelayakan penelitian dari segi ilmiah, etika, maupun metode penelitian.

Proposal penelitian berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan dan bagaimana data akan dikumpulkan serta dianalisis (S. K. Grove & Gray, 2018).

Dengan demikian, proposal penelitian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan prinsip ilmiah.

3. Struktur Proposal Penelitian Keperawatan

Secara umum, proposal penelitian keperawatan terdiri dari beberapa komponen utama yang disusun secara sistematis. Struktur proposal penelitian biasanya terdiri dari:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan bagian pertama yang menggambarkan fokus utama penelitian. Judul harus mampu mencerminkan variabel penelitian, subjek penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

Judul penelitian yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- Jelas dan spesifik
- Singkat tetapi informatif
- Menggambarkan variabel penelitian
- Menunjukkan objek atau populasi penelitian

Contoh judul penelitian keperawatan:

"Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi."

Judul penelitian yang tepat akan membantu pembaca memahami topik penelitian secara cepat dan jelas.

b. Latar Belakang Penelitian

Latar belakang penelitian menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Bagian ini biasanya memaparkan fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan pelayanan kesehatan.

Dalam latar belakang, peneliti perlu menjelaskan:

- kondisi aktual yang terjadi
- data atau fakta yang mendukung masalah penelitian
- kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata
- urgensi penelitian untuk mengatasi masalah tersebut

Latar belakang penelitian harus mampu menunjukkan pentingnya penelitian yang dilakukan serta menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan praktik keperawatan (Houser, 2023).

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah harus disusun secara jelas dan spesifik sehingga dapat diteliti secara ilmiah.

Rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian.

Contoh rumusan masalah:

"Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi?"

Rumusan masalah yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- Jelas dan spesifik
- Dapat diteliti secara empiris
- Relevan dengan bidang keperawatan

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum menggambarkan tujuan utama penelitian, sedangkan tujuan khusus menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum tersebut.

Contoh tujuan umum:

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi.

Contoh tujuan khusus:

1) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar.
2) Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi.
3) Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan kepatuhan pemberian imunisasi.

e. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat penelitian biasanya dibagi menjadi:

1) **Manfaat teoritis**, yaitu kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
2) **Manfaat praktis**, yaitu manfaat penelitian bagi praktik keperawatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat.

f. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tinjauan pustaka bertujuan untuk:

- Memberikan dasar teoritis bagi penelitian.
- Menunjukkan perkembangan penelitian sebelumnya.
- Menghindari duplikasi penelitian.

Kajian literatur merupakan bagian penting dalam penelitian karena membantu peneliti memahami bukti ilmiah yang telah tersedia dan

mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015).

g. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep merupakan gambaran hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

Kerangka konsep membantu peneliti memahami hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Komponen metodologi penelitian meliputi:

1) Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contoh desain penelitian dalam keperawatan:

- penelitian deskriptif
- penelitian korelasional
- penelitian eksperimen
- penelitian kualitatif

2) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih sebagai responden penelitian.

3) Variabel Penelitian

Variabel merupakan karakteristik atau atribut yang diteliti dalam penelitian. Jenis variabel meliputi:

- variabel independen
- variabel dependen
- variabel kontrol

4) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner, lembar observasi, atau pedoman wawancara.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif biasanya digunakan analisis statistik, sedangkan dalam penelitian kualitatif digunakan analisis tematik atau analisis isi.

4. Etika Penelitian dalam Penyusunan Proposal

   Penelitian keperawatan yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus memperhatikan prinsip etika penelitian. Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak dan keselamatan responden.

   Beberapa prinsip etika penelitian meliputi:

   - Informed consent, yaitu persetujuan responden setelah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian.
   - Kerahasiaan data responden.
   - Tidak merugikan responden.
   - Kejujuran dalam pelaporan data penelitian.

   Kepatuhan terhadap prinsip etika merupakan aspek penting dalam penelitian kesehatan untuk melindungi hak partisipan serta menjaga integritas penelitian (Polit & Beck, 2021).

C. Penyusunan skripsi keperawatan

Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam pendidikan keperawatan, skripsi memiliki peran penting sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan penelitian yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Melalui penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan, merancang penelitian, mengumpulkan serta menganalisis data, dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

Skripsi keperawatan umumnya berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan praktik keperawatan, promosi kesehatan, manajemen keperawatan, pendidikan keperawatan, maupun pengembangan intervensi keperawatan. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Skripsi atau laporan penelitian merupakan bentuk dokumentasi ilmiah dari proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menyampaikan temuan penelitian kepada komunitas ilmiah. Oleh karena itu, penyusunan skripsi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Gray et al., 2017).

1. Pengertian Skripsi Keperawatan

   Skripsi keperawatan merupakan laporan ilmiah yang memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bidang keperawatan. Skripsi disusun berdasarkan penelitian yang telah dirancang melalui proposal penelitian dan dilaksanakan sesuai dengan metode ilmiah.

Laporan penelitian dalam keperawatan merupakan dokumen ilmiah yang menjelaskan secara sistematis latar belakang penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, serta interpretasi terhadap temuan penelitian. Laporan penelitian tersebut disusun untuk menyebarluaskan pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian (S. Grove & Gray, 2019).

Dalam konteks pendidikan keperawatan, skripsi tidak hanya berfungsi sebagai syarat akademik, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah bagi mahasiswa.

2. Tujuan Penyusunan Skripsi

   Penyusunan skripsi memiliki beberapa tujuan penting dalam pendidikan keperawatan, antara lain:

   - Melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian secara sistematis.
   - Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah kesehatan.
   - Mengintegrasikan teori keperawatan dengan praktik penelitian.
   - Menghasilkan karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu keperawatan.
   - Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yang sesuai dengan standar akademik.

   Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian membantu mahasiswa memahami bagaimana pengetahuan ilmiah dikembangkan melalui metode penelitian yang sistematis (Creswell, 2018).

3. Struktur Skripsi Keperawatan

   Secara umum, struktur skripsi keperawatan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

   a. Bagian Awal Skripsi

      Bagian awal skripsi berfungsi untuk memberikan informasi awal mengenai penelitian yang dilakukan. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut:

      - **Halaman Judul**

        Halaman judul memuat informasi mengenai judul penelitian, nama penulis, institusi pendidikan, serta tahun penyusunan skripsi.

      - **Halaman Persetujuan dan Pengesahan**

        Halaman ini menunjukkan bahwa skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing dan telah memenuhi persyaratan akademik untuk diuji.

      - **Abstrak**

        Abstrak merupakan ringkasan singkat dari penelitian yang meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan

kesimpulan. Abstrak merupakan bagian penting dalam laporan penelitian karena memberikan gambaran singkat mengenai isi penelitian sehingga pembaca dapat memahami inti penelitian secara cepat.

- **Kata Pengantar**

  Kata pengantar berisi ungkapan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

- **Daftar Isi**

  Daftar isi memuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari daftar bab, subbab, serta nomor halaman.

b. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi merupakan bagian utama yang menjelaskan secara rinci mengenai penelitian yang dilakukan.

- **BAB I Pendahuluan**

  Bab pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

  Latar belakang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan dengan memaparkan fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian bagi ilmu keperawatan maupun praktik kesehatan.

- **BAB II Tinjauan Pustaka**

  Bab tinjauan pustaka berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

  Kajian literatur merupakan proses penting dalam penelitian karena membantu peneliti memahami bukti ilmiah yang telah tersedia serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu diteliti lebih lanjut (Greenhalgh & Dijkstra, 2024).

  Bab ini biasanya mencakup:

  - konsep teoritis yang berkaitan dengan penelitian
  - penelitian terdahulu
  - kerangka teori
  - kerangka konsep penelitian
  - hipotesis penelitian (jika penelitian kuantitatif)

- **BAB III Metodologi Penelitian**

  Bab metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Komponen dalam metodologi penelitian meliputi:

1) desain penelitian
2) lokasi dan waktu penelitian
3) populasi dan sampel
4) teknik sampling
5) variabel penelitian
6) definisi operasional variabel
7) instrumen penelitian
8) prosedur pengumpulan data
9) teknik analisis data
10) pertimbangan etika penelitian

Metodologi penelitian harus dijelaskan secara rinci agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain (Parahoo, 2014).

- **BAB IV Hasil Penelitian & Pembahasan**

  Bab hasil penelitian menyajikan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data.

  Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk:

  1) tabel
  2) grafik
  3) diagram

  Pada bagian ini peneliti hanya menyajikan hasil analisis data tanpa memberikan interpretasi yang mendalam.

  Bab pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian. Peneliti menjelaskan makna dari temuan penelitian serta membandingkannya dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

  Pembahasan penelitian harus menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang relevan serta menjelaskan implikasi temuan penelitian bagi praktik keperawatan (Lobiondo-wood & Haber, 2022).

- **BAB V Kesimpulan dan Saran**

  Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan bagi praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, maupun penelitian selanjutnya.

4. Prinsip Penulisan Ilmiah dalam Skripsi

   Dalam penyusunan skripsi, mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip penulisan ilmiah agar karya ilmiah yang dihasilkan memiliki kualitas akademik yang baik.

   Beberapa prinsip penulisan ilmiah meliputi:

   ✓ Menggunakan bahasa yang formal dan jelas.
   ✓ Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu.

- ✓ Menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi secara tepat.
- ✓ Menyusun tulisan secara sistematis dan logis.

Penulisan ilmiah harus disusun secara jelas, ringkas, dan terstruktur agar pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan mudah (Day & Gastel, 2012).

5. Etika Penulisan Skripsi

   Etika penelitian dan penulisan ilmiah merupakan aspek penting dalam penyusunan skripsi. Peneliti harus menjunjung tinggi kejujuran ilmiah serta menghormati hak responden penelitian.

   Beberapa prinsip etika penelitian meliputi:

   a. Persetujuan responden (informed consent).
   b. Kerahasiaan data responden.
   c. Tidak memanipulasi data penelitian.
   d. Menghindari plagiarisme.

   Integritas ilmiah merupakan prinsip dasar dalam penelitian yang menuntut peneliti untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap proses serta hasil penelitian (Resnik, 2024).

D. Teknik penulisan ilmiah

Penulisan ilmiah merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan peneliti, khususnya dalam bidang keperawatan. Melalui penulisan ilmiah, hasil pemikiran, penelitian, dan pengalaman klinis dapat disampaikan secara sistematis kepada komunitas ilmiah. Dalam pendidikan keperawatan, teknik penulisan ilmiah sangat diperlukan dalam penyusunan proposal penelitian, skripsi, laporan penelitian, maupun artikel ilmiah.

Penulisan ilmiah memiliki karakteristik yang berbeda dengan tulisan populer atau tulisan nonilmiah. Tulisan ilmiah harus disusun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengikuti aturan atau kaidah penulisan akademik yang telah ditetapkan. Penulisan ilmiah merupakan proses komunikasi akademik yang bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian dan gagasan ilmiah secara jelas, sistematis, dan dapat diverifikasi oleh komunitas ilmiah (Belcher, 2019).

Dalam konteks penelitian keperawatan, teknik penulisan ilmiah membantu peneliti menyajikan hasil penelitian secara logis sehingga dapat dipahami oleh pembaca dan dapat digunakan sebagai dasar dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

Penulisan ilmiah adalah proses penyusunan karya tulis yang didasarkan pada metode ilmiah dan bertujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian secara objektif dan sistematis.

Penulisan ilmiah merupakan bentuk komunikasi akademik yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan baru kepada komunitas ilmiah melalui laporan penelitian, artikel ilmiah, maupun karya ilmiah lainnya.

Dalam penulisan ilmiah, penulis harus menggunakan bahasa yang formal, logis, serta didukung oleh referensi ilmiah yang relevan. Penulisan ilmiah juga harus mengikuti struktur tertentu agar pembaca dapat memahami isi tulisan secara sistematis.

1. Karakteristik Penulisan Ilmiah

   Penulisan ilmiah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk tulisan lainnya.

   a. Objektif

      Tulisan ilmiah harus didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh melalui penelitian atau kajian ilmiah. Penulis tidak boleh memasukkan opini pribadi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah.

      Objektivitas merupakan prinsip utama dalam penulisan ilmiah karena tujuan utama penulisan ilmiah adalah menyampaikan informasi yang dapat diuji secara empiris (Silvia, 2015).

   b. Sistematis

      Tulisan ilmiah harus disusun secara terstruktur dan mengikuti urutan logis sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah.

      Struktur umum karya ilmiah biasanya meliputi:

      - pendahuluan
      - tinjauan pustaka
      - metodologi penelitian
      - hasil penelitian
      - pembahasan
      - Kesimpulan

   c. Logis

      Penulisan ilmiah harus menggunakan alur pemikiran yang rasional dan konsisten. Setiap argumen yang disampaikan harus didukung oleh data atau referensi yang relevan. Tulisan ilmiah yang baik harus memiliki argumentasi yang jelas dan didukung oleh bukti yang kuat (Booth et al., 2016).

d. Menggunakan Bahasa Ilmiah

Bahasa ilmiah merupakan bahasa formal yang digunakan dalam karya ilmiah. Bahasa ilmiah harus jelas, tidak ambigu, dan menghindari penggunaan bahasa yang bersifat emosional.

Beberapa ciri bahasa ilmiah antara lain:

- menggunakan kalimat yang efektif
- menggunakan istilah ilmiah yang tepat
- menghindari penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak formal

2. Struktur Penulisan Ilmiah

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat struktur tertentu yang harus diikuti agar tulisan dapat dipahami dengan baik.

a. Judul

Judul merupakan bagian pertama yang menggambarkan isi penelitian atau karya ilmiah. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan topik penelitian.

Judul yang baik harus mampu menarik perhatian pembaca sekaligus memberikan gambaran mengenai fokus penelitian (Murray, 2005).

b. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta pentingnya penelitian yang dilakukan. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan konteks penelitian dan menjelaskan alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan.

c. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis bagi penelitian.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

e. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan data atau temuan penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data.

f. Pembahasan

Pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian serta kaitannya dengan teori atau penelitian sebelumnya.

g. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian serta implikasi penelitian bagi praktik atau pengembangan ilmu.

3. Teknik Sitasi dan Referensi

   Dalam penulisan ilmiah, setiap informasi yang berasal dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya melalui sitasi dan daftar pustaka.

   Sitasi merupakan cara untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli serta menghindari plagiarisme dalam penulisan ilmiah (Neville, 2012).

   Beberapa sistem sitasi yang umum digunakan dalam karya ilmiah antara lain:

   - APA Style
   - Vancouver Style
   - Harvard Style

   Dalam bidang kesehatan dan keperawatan, sistem sitasi yang sering digunakan adalah APA Style dan Vancouver Style.

   Contoh sitasi dalam teks:

   Menurut Belcher (2019), penulisan ilmiah merupakan bentuk komunikasi akademik yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan baru kepada komunitas ilmiah.

4. Menghindari Plagiarisme

   Plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Plagiarisme merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik.

   Plagiarisme tidak hanya mencakup penyalinan langsung teks dari sumber lain tetapi juga penggunaan ide atau konsep tanpa memberikan kredit kepada penulis asli (Pecorari, 2013).

   Untuk menghindari plagiarisme, penulis dapat melakukan beberapa langkah berikut:

   a. Mencantumkan sumber referensi dengan benar.
   b. Menggunakan teknik parafrase dengan mencantumkan sumber.
   c. Menggunakan tanda kutip untuk kutipan langsung.
   d. Menggunakan perangkat lunak pemeriksa plagiarisme.

5. Teknik Parafrase dalam Penulisan Ilmiah

   Parafrase merupakan teknik menulis kembali informasi dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya.

   Parafrase merupakan keterampilan penting dalam penulisan akademik karena membantu penulis menyampaikan informasi dari berbagai sumber tanpa melakukan plagiarisme (Bailey, 2025).

   Contoh parafrase:

   Kalimat asli: Scientific writing is a form of communication used to share research findings.

Parafrase: Penulisan ilmiah merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah.

6. Kesalahan Umum dalam Penulisan Ilmiah

   Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan ilmiah antara lain:

   a. Kalimat yang terlalu panjang dan tidak jelas.
   b. Tidak mencantumkan sumber referensi.
   c. Struktur tulisan yang tidak sistematis.
   d. Penggunaan bahasa yang tidak formal.
   e. Kesalahan dalam penggunaan sitasi.

   Mahasiswa perlu memahami teknik penulisan ilmiah dengan baik agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.

E. Publikasi ilmiah dalam keperawatan

Publikasi ilmiah merupakan salah satu tahap penting dalam proses penelitian karena melalui publikasi hasil penelitian dapat disebarluaskan kepada komunitas ilmiah dan praktisi kesehatan. Dalam bidang keperawatan, publikasi ilmiah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas praktik keperawatan, serta penerapan praktik berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat dan mahasiswa keperawatan, tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan penelitian atau skripsi, tetapi juga perlu dipublikasikan agar hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah yang lebih luas. Dengan publikasi ilmiah, hasil penelitian dapat dikaji, diuji, serta dijadikan dasar dalam pengembangan praktik keperawatan yang lebih efektif dan berkualitas.

Publikasi ilmiah merupakan sarana utama dalam menyebarluaskan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah sehingga pengetahuan baru dapat digunakan untuk meningkatkan praktik keperawatan berbasis bukti. Oleh karena itu, kemampuan menulis dan mempublikasikan karya ilmiah menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa keperawatan (Lobiondo-wood & Haber, 2022).

Publikasi ilmiah adalah proses penyebarluasan hasil penelitian melalui media ilmiah seperti jurnal ilmiah, prosiding konferensi, atau buku ilmiah. Publikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan temuan penelitian kepada komunitas akademik sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Publikasi ilmiah merupakan bentuk komunikasi akademik yang digunakan oleh para peneliti untuk berbagi temuan penelitian, mengembangkan pengetahuan ilmiah, serta meningkatkan kolaborasi dalam bidang ilmu tertentu (Gasparyan et al., 2011).

Dalam bidang keperawatan, publikasi ilmiah tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan hasil penelitian dalam praktik klinik.

1. Tujuan Publikasi Ilmiah

   Publikasi ilmiah memiliki beberapa tujuan utama dalam dunia akademik dan penelitian.

   a. Menyebarluaskan Hasil Penelitian

      Publikasi ilmiah memungkinkan hasil penelitian diketahui oleh komunitas ilmiah sehingga dapat digunakan oleh peneliti atau praktisi lainnya.

   b. Mengembangkan Ilmu Keperawatan

      Melalui publikasi ilmiah, temuan penelitian dapat menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik keperawatan.

   c. Mendukung Evidence-Based Nursing

      Publikasi ilmiah menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan berbasis bukti. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah merupakan sumber utama bukti ilmiah yang digunakan dalam evidence-based practice (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015).

   d. Meningkatkan Reputasi Akademik

      Publikasi ilmiah juga berperan dalam meningkatkan reputasi akademik peneliti dan institusi pendidikan.

2. Jenis Publikasi Ilmiah

   Dalam bidang keperawatan, terdapat beberapa jenis publikasi ilmiah yang umum digunakan.

   a. Artikel Penelitian

      Artikel penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Artikel ini biasanya berisi hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti.

   b. Artikel Tinjauan Pustaka (Review Article)

      Artikel ini berisi kajian literatur yang membahas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai suatu topik tertentu.

   c. Laporan Kasus (Case Report)

      Laporan kasus merupakan laporan mengenai kasus klinis tertentu yang memiliki nilai ilmiah atau pendidikan bagi tenaga kesehatan.

d. Prosiding Seminar

Prosiding merupakan kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi ilmiah.

Jenis publikasi ilmiah tersebut memiliki peran penting dalam menyebarluaskan pengetahuan ilmiah kepada komunitas akademik (Gastel & Day, 2022).

3. Struktur Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal biasanya memiliki struktur yang sistematis. Struktur ini sering dikenal dengan istilah IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Results, and Discussion.

a. Judul

Judul artikel harus mencerminkan isi penelitian secara jelas dan spesifik.

b. Abstrak

Abstrak merupakan ringkasan singkat dari penelitian yang biasanya terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian.

c. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, masalah penelitian, serta tujuan penelitian.

d. Metode Penelitian

Bagian metode menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

e. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari analisis data.

f. Pembahasan

Pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian serta kaitannya dengan teori atau penelitian sebelumnya.

g. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari temuan utama penelitian. Struktur IMRAD membantu penulis menyajikan hasil penelitian secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah (Gastel & Day, 2022).

4. Proses Publikasi Artikel Ilmiah

Proses publikasi artikel ilmiah dalam jurnal biasanya melalui beberapa tahapan berikut.

a. Persiapan Naskah

Penulis menyusun artikel ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan oleh jurnal.

b. Submission Artikel

   Artikel kemudian dikirimkan melalui sistem pengiriman artikel yang biasanya dilakukan secara daring (online submission system).

c. Proses Review

   Artikel yang dikirimkan akan melalui proses penilaian oleh reviewer atau penelaah sejawat (peer review). Peer review merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang yang sama untuk menilai kualitas ilmiah suatu artikel sebelum dipublikasikan (Ware & Mabe, 2015).

d. Revisi Artikel

   Jika reviewer memberikan masukan atau koreksi, penulis harus melakukan revisi terhadap artikel.

e. Publikasi Artikel

   Setelah artikel dinyatakan layak, artikel akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

5. Pemilihan Jurnal Ilmiah

   Dalam publikasi ilmiah, pemilihan jurnal yang tepat sangat penting agar artikel memiliki peluang lebih besar untuk diterima.

   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jurnal antara lain:

   - Ruang lingkup jurnal sesuai dengan topik penelitian.
   - Reputasi jurnal dan indeksasi jurnal.
   - Pedoman penulisan jurnal.
   - Proses review dan waktu publikasi.

   Dalam konteks Indonesia, jurnal ilmiah sering diklasifikasikan berdasarkan indeksasi seperti SINTA (Science and Technology Index), sedangkan jurnal internasional sering terindeks dalam database seperti Scopus atau Web of Science.

   Pemilihan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan publikasi artikel ilmiah (Ramia, 2023).

6. Etika Publikasi Ilmiah

   Etika publikasi ilmiah merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh penulis dalam proses publikasi penelitian. Beberapa prinsip etika publikasi ilmiah meliputi:

   a. Kejujuran Ilmiah

      Penulis harus menyajikan data penelitian secara jujur tanpa manipulasi.

   b. Menghindari Plagiarisme

      Penulis harus mencantumkan sumber referensi dengan benar jika menggunakan ide atau tulisan dari penulis lain.

   c. Authorship

      Penulis yang tercantum dalam artikel harus benar-benar berkontribusi dalam penelitian. Menurut Committee on Publication Ethics (COPE), integritas ilmiah

merupakan prinsip utama dalam publikasi penelitian dan harus dijaga oleh semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi.

7. Konversi Skripsi menjadi Artikel Ilmiah

   Skripsi yang disusun oleh mahasiswa dapat dikonversi menjadi artikel ilmiah yang siap dipublikasikan dalam jurnal.

   Langkah-langkah konversi skripsi menjadi artikel ilmiah antara lain:

   - Memadatkan isi skripsi menjadi artikel yang lebih ringkas.
   - Menyederhanakan bagian metodologi dan hasil penelitian.
   - Menyesuaikan format artikel dengan pedoman jurnal yang dituju.
   - Memperbarui referensi dengan literatur terbaru.

   Penulis perlu menyesuaikan gaya penulisan dan struktur artikel agar sesuai dengan standar jurnal ilmiah (Murray, 2005).

F. Etika penelitian dan publikasi ilmiah

Etika penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan penelitian, terutama dalam bidang kesehatan dan keperawatan. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika untuk melindungi hak, keselamatan, serta kesejahteraan partisipan penelitian. Selain itu, etika publikasi ilmiah juga penting untuk menjaga integritas ilmiah serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian yang dipublikasikan.

Dalam konteks keperawatan, penelitian seringkali melibatkan pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan lainnya sebagai responden. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan risiko atau kerugian bagi partisipan penelitian.

Prinsip etika dalam penelitian kesehatan didasarkan pada empat prinsip utama yaitu menghormati otonomi individu, berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (nonmaleficence), dan keadilan (justice). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis dalam penelitian kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019).

Etika penelitian adalah standar moral yang digunakan untuk membimbing perilaku peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian. Standar etika ini mencakup kejujuran ilmiah, perlindungan terhadap subjek penelitian, serta tanggung jawab peneliti terhadap masyarakat ilmiah (Resnik, 2024).

Dalam penelitian keperawatan, penerapan etika penelitian sangat penting karena penelitian sering melibatkan pasien yang mungkin berada dalam kondisi rentan secara fisik maupun psikologis.

1. Prinsip-Prinsip Etika Penelitian

   Dalam penelitian kesehatan, terdapat beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan oleh peneliti.

   a. Prinsip Otonomi (Respect for Persons)

      Prinsip otonomi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan mengenai partisipasinya dalam penelitian. Partisipan penelitian harus diberikan informasi yang lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, serta risiko penelitian sebelum memutuskan untuk berpartisipasi.

      Menurut **World Medical Association** dalam *Declaration of Helsinki*, setiap partisipan penelitian harus memberikan persetujuan secara sukarela setelah mendapatkan informasi yang memadai mengenai penelitian (World Medical Association, 2013).

   b. Prinsip Beneficence

      Prinsip beneficence mengharuskan peneliti untuk memaksimalkan manfaat penelitian dan meminimalkan risiko bagi partisipan penelitian. Penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

   c. Prinsip Nonmaleficence

      Prinsip nonmaleficence berarti bahwa penelitian tidak boleh menyebabkan bahaya atau kerugian bagi partisipan penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa risiko penelitian telah diminimalkan dan tidak melebihi manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

   d. Prinsip Justice

      Prinsip keadilan menekankan bahwa semua partisipan penelitian harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

      Prinsip keadilan dalam penelitian berkaitan dengan distribusi manfaat dan risiko penelitian secara adil kepada semua pihak yang terlibat (Shamoo & Resnik, 2015).

2. Informed Consent dalam Penelitian

   Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh partisipan penelitian setelah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai penelitian yang akan dilakukan.

   Informasi yang harus diberikan kepada partisipan penelitian meliputi:

   - tujuan penelitian
   - prosedur penelitian
   - manfaat penelitian
   - risiko penelitian
   - hak partisipan untuk menolak atau menghentikan partisipasi dalam penelitian

Informed consent merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian etis karena memberikan kesempatan kepada individu untuk membuat keputusan secara sadar mengenai partisipasi mereka dalam penelitian (Faden & Beauchamp, 2016).

3. Kerahasiaan dan Privasi Responden

   Dalam penelitian kesehatan, data yang diperoleh dari responden seringkali bersifat sensitif dan pribadi. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

   Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data antara lain:

   - menggunakan kode atau nomor identifikasi untuk menggantikan nama responden
   - menyimpan data penelitian secara aman
   - membatasi akses terhadap data penelitian

4. Ethical Clearance dalam Penelitian

   Ethical clearance merupakan persetujuan etik yang diberikan oleh komite etik penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Persetujuan etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip etika penelitian.

   Komite etik biasanya akan menilai beberapa aspek penelitian, antara lain:

   - tujuan penelitian
   - metode penelitian
   - potensi risiko bagi partisipan
   - prosedur informed consent
   - perlindungan terhadap kerahasiaan data responden

   Semua penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian (CIOMS, 2016).

5. Etika Publikasi Ilmiah

   Selain etika penelitian, peneliti juga harus memperhatikan etika dalam publikasi ilmiah. Etika publikasi bertujuan untuk menjaga integritas ilmiah serta memastikan bahwa hasil penelitian dilaporkan secara jujur dan transparan.

   Etika publikasi ilmiah mencakup berbagai aspek seperti kejujuran dalam pelaporan data, pengakuan terhadap kontribusi penulis, serta pencegahan plagiarisme (Wager & Kleinert, 2010).

6. Plagiarisme dalam Publikasi Ilmiah

   Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai kepada penulis asli. Plagiarisme merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik.

Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk (Roig, 2015), antara lain:

- menyalin teks dari sumber lain tanpa mencantumkan referensi
- menggunakan ide orang lain tanpa memberikan kredit kepada penulis asli
- mempublikasikan karya orang lain sebagai karya sendiri

Untuk menghindari plagiarisme, penulis harus mencantumkan sumber referensi secara tepat serta menggunakan teknik parafrase yang benar.

7. Authorship dan Kontribusi Penulis

   Dalam publikasi ilmiah, penulis yang tercantum dalam artikel harus benar-benar memiliki kontribusi dalam penelitian.

   Seseorang dapat diakui sebagai penulis jika memenuhi beberapa kriteria berikut (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 2021):

   - berkontribusi secara signifikan dalam perancangan atau pelaksanaan penelitian
   - terlibat dalam penulisan atau revisi artikel ilmiah
   - menyetujui versi akhir artikel yang dipublikasikan
   - bertanggung jawab terhadap integritas penelitian

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini Case (Diskusi Kelompok)

Di ruang rawat inap anak, perawat menemukan bahwa beberapa pasien usia prasekolah menunjukkan kecemasan tinggi saat pemasangan infus. Anak menangis, menolak tindakan, dan kurang kooperatif. Orang tua juga tampak cemas melihat kondisi tersebut. Perawat ruangan ingin mengetahui intervensi nonfarmakologis yang efektif untuk menurunkan kecemasan anak selama prosedur invasif. Kepala ruangan meminta tim mahasiswa praktik untuk menelaah bukti ilmiah dan menyusun usulan penelitian sederhana yang dapat diterapkan di ruangan.

Mahasiswa diminta menyelesaikan tugas dalam kelompok kecil.

Tahap 1. Identifikasi Masalah dan Rumusan PICO

Diskusikan pertanyaan berikut:

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Mengapa masalah ini penting ditangani?
3. Susun pertanyaan klinis menggunakan format PICO

Tahap 2. Penelusuran Bukti Ilmiah

Cari **minimal 3 artikel ilmiah** (5 tahun terakhir bila memungkinkan) terkait intervensi nonfarmakologis untuk menurunkan kecemasan anak saat prosedur invasif.

Tahap 3. Critical Appraisal Sederhana

Pilih 1 artikel terbaik, lalu nilai menggunakan format berikut:

Aspek Penilaian	Ya	Tidak	Catatan
Tujuan penelitian jelas			
Metode sesuai			
Sampel dijelaskan			
Intervensi dijelaskan			
Hasil valid			
Relevan untuk keperawatan			

Kesimpulan Appraisal:

Apakah artikel layak dijadikan dasar praktik? Jelaskan alasan kelompok.

Tahap 4. Rancang Proposal Mini Penelitian

Berdasarkan hasil telaah bukti, susun draft proposal singkat:

Judul Penelitian

.....

Latar Belakang Singkat (1 paragraf)

.....

Rumusan Masalah

.....

Tujuan Penelitian

.....

Metode Penelitian

- Desain:
- Populasi/Sampel:
- Intervensi:
- Instrumen:
- Analisis Data:

Tahap 5. Alternatif Draft Manuskrip Ilmiah

Jika memilih jalur manuskrip, susun format singkat berikut:

1. Judul Artikel
2. Abstrak singkat (100 kata)
3. Pendahuluan
4. Metode
5. Hasil yang diharapkan
6. Implikasi keperawatan

Output Presentasi Kelompok (10 Menit)

Setiap kelompok mempresentasikan:

1. Masalah klinik yang dipilih
2. Pertanyaan PICO
3. Hasil pencarian literatur
4. Hasil critical appraisal
5. Draft proposal/manuskrip
6. Rekomendasi praktik keperawatan

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi Telaah Pustaka Ringkas + Matriks Literatur

Di ruang rawat inap dewasa, angka kecemasan pasien preoperasi cukup tinggi. Perawat ingin mengetahui intervensi nonfarmakologis yang efektif untuk menurunkan kecemasan pasien sebelum operasi.

Mahasiswa diminta melakukan telaah pustaka ringkas untuk memberikan rekomendasi awal berbasis bukti.

Tahap 1. Menentukan Topik dan Pertanyaan Review

Topik yang dikaji:

Efektivitas intervensi nonfarmakologis terhadap kecemasan pasien preoperasi

Rumusan pertanyaan:

"Intervensi nonfarmakologis apa yang efektif menurunkan kecemasan pasien preoperasi?"

Tahap 2. Strategi Pencarian Literatur (*Reproducibility*)

Mahasiswa wajib menuliskan strategi pencarian yang jelas agar dapat diulang oleh orang lain.

Strategi Pencarian

Komponen	**Isi**
Database	PubMed / Google Scholar / ScienceDirect / Garuda
Kata kunci utama	preoperative anxiety
Sinonim	surgical anxiety, anxiety before surgery
Intervensi	music therapy, relaxation, education, guided imagery
Boolean operator	AND / OR
Rentang tahun	2020–2026
Bahasa	Indonesia / Inggris
Jenis artikel	RCT / quasi experiment / review

Tahap 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi

- Artikel tahun 2020–2026
- Topik kecemasan pasien preoperasi
- Intervensi nonfarmakologis
- Full text tersedia
- Bahasa Indonesia atau Inggris

Kriteria Eksklusi

- Editorial/opini
- Artikel duplikat
- Pasien anak (jika fokus dewasa)

- Tidak mengukur kecemasan

Tahap 4. Seleksi Artikel

Ambil minimal 5 artikel terbaik.

Tahap 5. Matriks Literatur

No	Penulis/Tahun	Negara	Desain	Sampel	Intervensi	Outcome	Hasil Utama
1							
2							
3							
4							
5							

Tahap 6. Sintesis Naratif

Tuliskan rangkuman hasil literatur (300–500 kata):

Panduan sintesis:

1. Intervensi apa yang paling sering diteliti?
2. Mana yang paling efektif?
3. Adakah hasil yang bertentangan?
4. Apa kelemahan studi sebelumnya?
5. Apa celah penelitian (*research gap*)?

Tahap 7. Menyusun Kerangka Konsep

Contoh:

```
Intervensi Nonfarmakologis
(Musik / Edukasi / Relaksasi)
            ↓
 Penurunan Kecemasan
 Pasien Preoperasi
```

Mahasiswa dapat memodifikasi sesuai hasil telaah.

Output yang Dikumpulkan

1. Dokumen telaah pustaka ringkas (3–5 halaman)
2. Matriks literatur
3. Diagram kerangka konsep
4. Daftar pustaka

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	Simulasi Telaah Pustaka Ringkas + Matriks Literatur

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Menyusun rumusan masalah yang benar
- Menentukan desain penelitian yang sesuai
- Menjelaskan informed consent sebagai persetujuan sukarela
- Menentukan variabel independen dan dependen dengan benar

Cuplikan Rubrik

Kriteria	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas
Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema	Coding sistematis; tema	Sangat sistematis; tema kuat;

		kurang koheren	koheren; penyajian jelas	penyajian transparan dan meyakinkan
Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun komponen dasar proposal, menentukan metode penelitian, menerapkan etika penelitian, dan menilai kelayakan artikel ilmiah..
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling **2. Pengkajian** 3. Diagnosa dan perencanaan **4. Implementasi** 5. Evaluasi **6. Perilaku professional**

No.	Komponen	Isi
6	Kategori	1. Riset Keperawatan 2. Skripsi 3. Publikasi Ilmiah 4. Evidence-Based Nursing
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO: Anda adalah mahasiswa tingkat akhir keperawatan yang sedang mengikuti ujian metodologi penelitian. Di ruang rawat inap anak, kepatuhan cuci tangan keluarga pasien masih rendah sehingga meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Kepala ruangan meminta Anda menyusun rancangan penelitian sederhana berbasis bukti.. TUGAS: 1. Tentukan judul penelitian yang sesuai. 2. Tuliskan rumusan masalah. 3. Tentukan: desain penelitian, variabel independent, variabel dependen 4. Jelaskan informed consent pada responden. 5. Nilai secara singkat apakah artikel tentang edukasi cuci tangan keluarga pasien layak dijadikan referensi.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO : Anda adalah mahasiswa tingkat akhir keperawatan yang sedang mengikuti ujian metodologi penelitian. Di ruang rawat inap anak, kepatuhan cuci tangan keluarga pasien masih rendah sehingga meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Kepala ruangan meminta Anda menyusun rancangan penelitian sederhana berbasis bukti.. TUGAS: 1. Tentukan judul penelitian yang sesuai. 2. Tuliskan rumusan masalah. 3. Tentukan: desain penelitian, variabel independent, variabel dependen 4. Jelaskan informed consent pada responden. 5. Nilai secara singkat apakah artikel tentang edukasi cuci tangan keluarga pasien layak dijadikan referensi. INSTRUKSI PENGUJI:

No.	Komponen	Isi
		Hal yang dinilai 1. Ketepatan peserta menyusun judul penelitian yang spesifik. 2. Ketepatan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. 3. Kemampuan menentukan desain penelitian sesuai tujuan. 4. Kemampuan membedakan variabel independen dan dependen. 5. Kemampuan menjelaskan informed consent. 6. Kemampuan menilai relevansi artikel ilmiah. 7. Profesionalisme dan komunikasi peserta. 8. Penguji tidak diperbolehkan memberi petunjuk tambahan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. KS berperan sebagai kepala ruangan/perawat senior. 2. Menyampaikan bahwa kepatuhan cuci tangan keluarga pasien rendah. 3. Bila peserta bertanya data tambahan: Banyak keluarga pasien tidak mencuci tangan sebelum menyentuh anak, Edukasi belum rutin dilakukan. 4. Bila peserta bertanya harapan: ingin ada solusi berbasis penelitian. 5. KS bersikap kooperatif dan netral.
10	Setting station	Ruang diskusi akademik / ruang OSCE **Tata Letak:** 1. Meja peserta 2. Kursi peserta 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Kursi KS 6. Lembar soal 7. Lembar jawaban 8. Stopwatch/timer
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Lembar soal peserta 2. Lembar penilaian penguji 3. Alat tulis 4. Stopwatch

No.	Komponen	Isi
		5. Artikel abstrak singkat tentang edukasi cuci tangan 6. Name tag peserta
12	Penulis	. .....
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Polit, D. F., & Beck, C. T. *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. *Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice*. Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare*.

SOP Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Menelaah pedoman akademik, buku panduan skripsi, dan template penulisan institusi				
2	Menentukan topik sesuai bidang keperawatan dan minat penelitian				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
3	Mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan fenomena klinik/komunitas				
4	Menyiapkan perangkat kerja: laptop, referensi, aplikasi sitasi, akun jurnal				
5	Menyusun jadwal kerja dan target penyelesaian				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
6	Berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait topik penelitian				
7	Menjelaskan latar belakang dan urgensi topik yang dipilih				
8	Menyepakati fokus penelitian dengan pembimbing				
9	Menyepakati mekanisme bimbingan dan timeline				
10	Mencatat masukan awal pembimbing				
C	**Tahap Kerja (No. 11 s.d. 32: sistematis)**				
	Penyusunan Proposal				
11	Menyusun judul penelitian yang spesifik dan relevan				
12	Menulis latar belakang masalah berbasis data dan literatur				
13	Menyusun rumusan masalah				
14	Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
15	Menentukan manfaat penelitian				
16	Menyusun tinjauan pustaka dari sumber ilmiah mutakhir				
17	Menyusun kerangka konsep / kerangka teori				
18	Menentukan hipotesis (jika kuantitatif)				
19	Menentukan desain penelitian				
20	Menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling				
21	Menentukan instrumen penelitian				
22	Menentukan prosedur pengumpulan data				
23	Menentukan analisis data				
24	Menyusun aspek etika penelitian dan informed consent				
	Penyusunan Skripsi				
25	Melaksanakan penelitian sesuai proposal yang disetujui				
26	Mengolah dan menganalisis data penelitian				
27	Menyusun BAB hasil penelitian				
28	Menyusun BAB pembahasan berbasis teori dan jurnal				
29	Menyusun kesimpulan dan saran				
30	Menyusun abstrak dalam Bahasa Indonesia/Inggris				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	Publikasi Ilmiah				
31	Mengonversi skripsi menjadi manuskrip artikel ilmiah				
32	Memilih jurnal yang sesuai scope dan author guidelines				
33	Menyesuaikan format artikel sesuai template jurnal				
34	Melakukan submission artikel ke jurnal				
35	Menanggapi reviewer dan melakukan revisi artikel				
D	**Tahap Terminasi**				
36	Melakukan pengecekan plagiarisme sesuai batas institusi				
37	Memastikan seluruh sitasi dan daftar pustaka sesuai format				
38	Menyerahkan naskah akhir kepada pembimbing				
39	Melakukan revisi akhir pasca ujian/seminar				
40	Menyimpan seluruh file penelitian secara rapi				
E	**Tahap Dokumentasi**				
41	Mendokumentasikan logbook bimbingan				
42	Menyimpan data mentah penelitian				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
43	Menyimpan lembar persetujuan etik dan informed consent				
44	Menyimpan bukti submit artikel / LOA bila ada				
F	**Penampilan Profesional**				
45	Disiplin terhadap jadwal bimbingan				
46	Komunikatif dan responsif terhadap arahan pembimbing				
47	Jujur, menghindari fabrikasi/falsifikasi data				
48	Teliti, sistematis, dan bertanggung jawab				
49	Menjaga etika akademik dan profesionalisme				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENYUSUNAN PROPOSAL, SKRIPSI, DAN PUBLIKASI ILMIAH

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun komponen dasar proposal, menentukan metode penelitian, menerapkan etika penelitian, dan menilai kelayakan artikel ilmiah..					3	
2	Implementasi keperawatan	Menyusun Proposal, Skripsi dan Publikasi Ilmiah					4	
3	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif, jujur, menjaga etika					3	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENYUSUNAN PROPOSAL, SKRIPSI, DAN PUBLIKASI ILMIAH

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam Mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun komponen dasar proposal, menentukan metode penelitian, menerapkan etika penelitian, dan menilai kelayakan artikel ilmiah..					3	
2. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan Menyusun					4	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
Proposal, Skripsi dan Publikasi Ilmiah. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
3. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, jujur, disiplin serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					3	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi riwayat menstruasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti Mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun komponen dasar proposal, menentukan metode penelitian, menerapkan etika penelitian, dan menilai kelayakan artikel	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi Mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun komponen dasar proposal, menentukan metode penelitian, menerapkan etika penelitian, dan menilai kelayakan artikel ilmiah dengan tepat.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			ilmiah, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	
2. Implementasi: Keperawatan	Tidak menyusun Proposal, Skripsi dan Publikasi Ilmiah	Menyusun Proposal saja namun tidak melakukan pengambilan data penelitian.	Menyusun Proposal dan Skripsi namun tidak melakukan Publikasi hasil penelitian	Menyusun Proposal, Skripsi dan Publikasi hasil penelitian
3. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, disiplin, tidak jujur, teliti, tidak komunikatif serta responsif terhadap arahan pembimbing dan tidak menjaga etika akademik dan profesionalisme	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam disiplin, jujur, teliti, komunikatif serta responsif terhadap arahan pembimbing	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, disiplin, jujur, teliti namun masih ada kekurangan kecil dalam komunikatif serta responsif terhadap arahan pembimbing	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi disiplin, jujur, teliti, komunikatif serta responsif terhadap arahan pembimbing dan menjaga etika akademik dan profesionalisme

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Aktivitas 3 — DOPS (*Does)*

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada mahasiswa dalam menyusun proposal, mengolah skripsi, melakukan presentasi ilmiah, menggunakan aplikasi referensi, serta menyiapkan manuskrip publikasi.
- Contoh Kegiatan
  Mahasiswa melakukan bimbingan skrips BAB III:
  - desain penelitian
  - teknik sampling
  - instrumen
  - analisis data
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)* pada Mahasiswa bimbingan Skripsi BAB III

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bimbingan Skripsi BAB III
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan	Dosen pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat sesi bimbingan skripsi BAB III yang mempresentasikan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bimbingan Skripsi BAB III
	mahasiswa saat melakukan tugas nyata secara terstruktur di lingkungan akademik atau praktik. Penilai mengamati proses kerja, ketepatan langkah, komunikasi, dan hasil kerja.	rancangan metodologi penelitian, meliputi desain penelitian, teknik sampling, instrumen, dan analisis data.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep metodologi penelitian secara nyata, sistematis, dan mandiri. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menjelaskan penerapan metode penelitian pada proposal skripsinya.	Mahasiswa dinilai bukan hanya mengetahui definisi desain penelitian atau sampling, tetapi mampu mempertanggungjawabkan pemilihan metode yang digunakan dalam penelitiannya.
Kasus akademik	Kasus diambil dari situasi nyata yang umum terjadi pada proses penyusunan skripsi dan sesuai capaian pembelajaran metodologi penelitian.	Seorang mahasiswa sedang menyusun skripsi berjudul *Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi dengan Kepatuhan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas X*. Mahasiswa datang untuk bimbingan BAB III kepada dosen pembimbing.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan presentasi singkat, menjelaskan isi BAB III, menjawab pertanyaan pembimbing, dan merevisi bagian yang kurang tepat.	Mahasiswa membuka file BAB III, menjelaskan bahwa desain penelitian menggunakan *cross-sectional*, sampel sebanyak 80 responden dengan *purposive sampling*, instrumen berupa kuesioner pengetahuan dan checklist kepatuhan, serta analisis menggunakan uji Chi-square.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bimbingan Skripsi BAB III
Aspek yang dinilai	Aspek meliputi ketepatan metodologi, penalaran ilmiah, komunikasi akademik, kemampuan menjawab, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menjelaskan alasan memilih desain *cross-sectional*, kesesuaian teknik sampling, validitas instrumen, dan kesesuaian uji statistik dengan jenis data.
Fokus observasi pembimbing	Penilai mengamati kualitas performa mahasiswa menggunakan format DOPS terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa dapat membedakan variabel independen dan dependen, menjelaskan populasi terjangkau, serta memahami kapan menggunakan uji Chi-square atau alternatif lain.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, singkat, spesifik, dan berorientasi perbaikan.	Dosen menyampaikan bahwa mahasiswa sudah tepat memilih desain korelasional, namun perlu memperjelas alasan penggunaan *purposive sampling*, menambahkan uji validitas instrumen, dan memperbaiki definisi operasional variabel.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam praktik akademik nyata.	Mahasiswa dinyatakan kompeten bila mampu menjelaskan BAB III secara runtut, menjawab pertanyaan metodologis dengan benar, dan siap lanjut pengambilan data. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi bila masih banyak kesalahan konsep.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level does (mampu melakukan).	Pada kasus ini, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami metodologi penelitian, tetapi mampu menerapkannya secara nyata dalam proses bimbingan skripsi secara profesional dan mandiri.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi akademik
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 6. 4 Portofolio pada Mahasiswa Melakukan Bimbingan Skripsi BAB III

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa secara bertahap, berkelanjutan, dan autentik. Dalam Outcome-Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari proses, hasil, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan.	Pada bimbingan skripsi BAB III, portofolio berisi bukti bahwa mahasiswa mampu menyusun metodologi penelitian, menerima umpan balik pembimbing, memperbaiki naskah, dan menunjukkan peningkatan kualitas proposal dari waktu ke waktu.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan capaian kompetensi, proses pembelajaran, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama penyusunan skripsi.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah bimbingan BAB III, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pemahamannya meningkat setelah revisi dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian pendukung portofolio karena memberikan bukti performa mahasiswa dalam situasi simulasi maupun praktik nyata.	OSCE dapat memuat ujian metodologi penelitian, sedangkan DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa mempresentasikan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III
		BAB III kepada dosen pembimbing.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan aktivitas akademik, kendala yang dihadapi, keputusan metodologis, dan hasil bimbingan.	Mahasiswa menuliskan bahwa pada bimbingan pertama dosen meminta memperjelas desain penelitian, menyesuaikan teknik sampling, dan menambah uji validitas instrumen.
Refleksi akademik	Refleksi menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali kelemahan, menganalisis kesalahan, dan menyusun strategi perbaikan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa sebelumnya masih bingung membedakan cross-sectional dan quasi experiment, lalu mempelajari ulang metodologi penelitian sebelum bimbingan berikutnya.
Feedback CI/dosen	Umpan balik pembimbing menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Dosen menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik menjelaskan variabel penelitian, tetapi masih perlu memperbaiki alasan penggunaan purposive sampling dan kesesuaian uji statistik.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian satu kali, tetapi kumpulan bukti yang dibangun berulang dan berkesinambungan. Penekanannya adalah konsistensi perkembangan kompetensi mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu sesi bimbingan, tetapi dari beberapa kali pertemuan yang menunjukkan peningkatan mutu BAB III secara konsisten.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa akademik pada berbagai kesempatan.	Dari catatan revisi, hasil DOPS, dan feedback pembimbing terlihat bahwa mahasiswa semakin mampu menjelaskan desain penelitian, sampling,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III
		instrumen, dan analisis data secara mandiri.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi tampak dalam performa nyata yang berkembang dan terdokumentasi.	Pada bimbingan skripsi BAB III, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui metodologi penelitian, tetapi benar-benar mampu menerapkannya dalam penyusunan proposal secara profesional.

Tabel 6. 5 Case Report pada Mahasiswa Melakukan Bimbingan Skripsi BAB III

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III
Hakikat case report	*Case report* merupakan laporan singkat, sistematis, dan reflektif mengenai satu kasus akademik nyata yang dialami mahasiswa selama proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan tinggi, *case report* berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah, menerapkan teori metodologi penelitian, serta mendokumentasikan proses pemecahan masalah secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat mengenai pengalaman bimbingan skripsi BAB III dengan dosen pembimbing terkait revisi metodologi penelitian yang mencakup desain penelitian, teknik sampling, instrumen, dan analisis data.
Tujuan	*Case report* bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori metodologi penelitian dengan situasi nyata, mengidentifikasi masalah akademik, merumuskan solusi, dan mengevaluasi hasil bimbingan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan bahwa telah melakukan bimbingan, tetapi juga menjelaskan kendala metodologi yang ditemukan, arahan dosen, dan perbaikan yang dilakukan pada BAB III.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III
Isi laporan	Isi *case report* biasanya mencakup identitas singkat kasus, latar belakang masalah, kronologi bimbingan, analisis isu metodologis, keputusan revisi, hasil akhir, dan pembelajaran yang diperoleh.	Mahasiswa menuliskan bahwa BAB III awal masih memiliki kesalahan pemilihan desain penelitian, teknik sampling kurang tepat, instrumen belum tervalidasi, dan analisis data belum sesuai jenis data.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa mengenali masalah metodologi, ketepatan analisis, logika ilmiah, respons terhadap umpan balik, dan kemampuan memperbaiki naskah.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memahami alasan perubahan desain penelitian, memperbaiki sampling, menambahkan validitas instrumen, dan menyesuaikan uji statistik.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan *critical thinking*, penalaran akademik, keterampilan menulis ilmiah, dan kebiasaan refleksi diri.	Dari kasus bimbingan ini, mahasiswa belajar bahwa pemilihan metode penelitian harus selalu sesuai tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan.
Makna dalam OBE	Dalam Outcome-Based Education (OBE), *case report* menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori metodologi penelitian dalam situasi akademik nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep metodologi penelitian, tetapi juga mampu memperbaiki BAB III berdasarkan proses bimbingan secara profesional.

Tabel 6. 6 Refleksi Akademik pada Mahasiswa Melakukan Bimbingan Skripsi BAB III

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III**
Hakikat refleksi akademik	Refleksi akademik merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa meninjau pengalaman belajar, mengenali kesalahan atau kelemahan, menganalisis penyebab, serta merencanakan perbaikan berkelanjutan dalam proses akademik.	Pada bimbingan skripsi BAB III, mahasiswa merefleksikan bahwa pemahaman metodologi penelitian yang belum mendalam menyebabkan beberapa bagian BAB III perlu direvisi setelah konsultasi dengan dosen pembimbing.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa proses bimbingan bukan sekadar memperbaiki naskah, tetapi sarana belajar untuk meningkatkan kompetensi riset, berpikir kritis, dan tanggung jawab akademik.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti salah memilih desain penelitian atau uji statistik dapat berdampak besar terhadap kualitas hasil penelitian.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi kendala, analisis penyebab kesalahan, pembelajaran yang diperoleh, serta rencana tindak lanjut setelah bimbingan.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama revisi adalah desain penelitian, teknik sampling, instrumen, dan analisis data yang sebelumnya belum sesuai dengan tujuan penelitian.
Masalah yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali bagian BAB III yang belum tepat atau belum lengkap.	Masalah yang diidentifikasi antara lain desain penelitian kurang sesuai, teknik sampling tidak realistis, instrumen belum diuji validitas, dan analisis data tidak sesuai skala data.
Tindakan perbaikan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dilakukan setelah menerima umpan balik pembimbing.	Mahasiswa mengganti desain menjadi *cross-sectional*, memperbaiki sampling menjadi *purposive sampling*,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mahasiswa Bimbingan Skripsi BAB III
		menambahkan uji validitas instrumen, dan mengganti analisis menjadi Chi-square.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana pengalaman tersebut akan memengaruhi penyusunan skripsi berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa setiap keputusan metodologis harus didasarkan pada tujuan penelitian, jenis variabel, dan karakteristik data, bukan sekadar meniru contoh proposal lain.
Makna dalam OBE	Dalam Outcome-Based Education (OBE), refleksi akademik menunjukkan perkembangan sikap profesional, pembelajaran mandiri, dan kemampuan evaluasi diri mahasiswa secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya menulis BAB III, tetapi juga mampu mengevaluasi proses bimbingan dan meningkatkan kualitas proposal secara terus-menerus.

G. Rangkuman

Penyusunan proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah merupakan rangkaian proses ilmiah yang saling terintegrasi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa keperawatan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan berbasis bukti dalam praktik keperawatan.

Tahap awal dalam penelitian dimulai dari penyusunan proposal penelitian, yang berfungsi sebagai rencana atau blueprint penelitian. Proposal memuat komponen penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, serta metodologi penelitian. Melalui proposal, peneliti merancang penelitian secara sistematis sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan terarah, valid, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Selanjutnya, penelitian yang telah dilaksanakan dituangkan dalam bentuk skripsi keperawatan. Skripsi merupakan laporan ilmiah yang menyajikan seluruh proses penelitian mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, hingga pembahasan dan kesimpulan. Penyusunan skripsi menuntut mahasiswa untuk mampu mengintegrasikan teori dengan data empiris serta melakukan analisis yang mendalam terhadap temuan penelitian. Selain itu, skripsi juga melatih

mahasiswa dalam menyusun tulisan ilmiah yang sistematis, logis, dan sesuai dengan standar akademik.

Tahap berikutnya adalah publikasi ilmiah, yang merupakan proses diseminasi hasil penelitian kepada komunitas ilmiah melalui jurnal atau media ilmiah lainnya. Publikasi ilmiah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu keperawatan karena memungkinkan hasil penelitian digunakan sebagai dasar dalam praktik keperawatan berbasis bukti (Evidence-Based Nursing). Oleh karena itu, kemampuan mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Dalam keseluruhan proses tersebut, mahasiswa juga harus memahami dan menerapkan teknik penulisan ilmiah yang baik, termasuk penggunaan bahasa formal, struktur penulisan yang sistematis, serta teknik sitasi yang benar. Selain itu, aspek etika penelitian dan publikasi ilmiah menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Prinsip etika seperti informed consent, kerahasiaan data, kejujuran ilmiah, serta penghindaran plagiarisme harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap penelitian.

Dengan demikian, proses penyusunan proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pendidikan keperawatan. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis bukti.

Tabel 6. 7 Red Flags & Eskalasi

Red Flags	**Makna Akademik**	**Tindakan Eskalasi**
Desain penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian	Menunjukkan mahasiswa belum memahami hubungan antara rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Jika dibiarkan, hasil penelitian menjadi tidak valid.	Segera konsultasi intensif dengan dosen pembimbing. Minta mahasiswa merevisi desain berdasarkan tujuan penelitian dan membaca ulang referensi metodologi penelitian.
Mahasiswa tidak mampu menjelaskan alasan memilih desain penelitian	Indikasi bahwa mahasiswa hanya menyalin contoh proposal tanpa memahami konsep metodologis.	Lakukan *probing question* saat bimbingan. Bila tetap tidak mampu menjawab, jadwalkan remedial metodologi penelitian.

Red Flags	Makna Akademik	Tindakan Eskalasi
Teknik sampling tidak realistis atau tidak sesuai populasi	Berpotensi menyebabkan sampel tidak representatif dan penelitian sulit dilaksanakan di lapangan.	Minta mahasiswa memetakan ulang populasi target, populasi terjangkau, dan akses responden. Revisi teknik sampling sesuai kondisi nyata.
Jumlah sampel tidak memiliki dasar perhitungan	Menunjukkan kelemahan dalam perencanaan metodologi dan dapat menurunkan kekuatan analisis data.	Arahkan mahasiswa menggunakan rumus perhitungan sampel atau konsultasi dengan dosen statistik/metodologi.
Instrumen penelitian tidak jelas sumbernya	Risiko penggunaan alat ukur tidak valid atau tidak reliabel, sehingga data yang diperoleh diragukan.	Minta mahasiswa mencantumkan sumber instrumen asli dan bukti penggunaan sebelumnya. Jika instrumen buatan sendiri, lakukan uji validitas dan reliabilitas.
Mahasiswa tidak memahami cara skoring instrumen	Menunjukkan kelemahan dalam operasionalisasi variabel dan pengolahan data.	Latih mahasiswa menjelaskan indikator, skoring, kategori hasil, dan interpretasi instrumen.
Analisis data tidak sesuai jenis variabel/skala data	Risiko kesimpulan statistik salah dan hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Segera revisi rencana analisis. Konsultasi dengan dosen statistik atau mengikuti klinik analisis data.
Mahasiswa memilih uji statistik hanya karena meniru penelitian lain	Menunjukkan kurangnya penalaran ilmiah dan pemahaman konsep analitik.	Minta mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan uji berdasarkan tujuan penelitian, jumlah kelompok, distribusi data, dan skala data.
BAB III banyak plagiarisme atau salin-tempel proposal lain	Pelanggaran etika akademik serius dan menghambat kompetensi nyata mahasiswa.	Lakukan pemeriksaan plagiarisme, minta revisi total bagian bermasalah, berikan pembinaan etika akademik.
Mahasiswa berulang kali datang	Menunjukkan kurang disiplin, rendah tanggung jawab	Konseling akademik, kontrak target revisi, monitoring progres

Red Flags	Makna Akademik	Tindakan Eskalasi
bimbingan tanpa revisi	akademik, atau hambatan belajar tersembunyi.	bersama pembimbing/koordinator skripsi.

Form Checklist

Bab **Mahasiswa Menyusun BAB III Skripsi**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai

No	Indikator Evaluasi	Ya	Tidak
1	Desain penelitian sesuai tujuan	☐	☐
2	Teknik sampling realistis	☐	☐
3	Instrumen valid/relevan	☐	☐
4	Analisis data sesuai jenis variabel	☐	☐

Glosarium

Abstrak : Ringkasan singkat dari karya ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian.

Analisis Data **:** Proses mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Artikel Ilmiah : Tulisan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dengan struktur tertentu.

Author (Penulis) : Individu yang memiliki kontribusi signifikan dalam perancangan, pelaksanaan, dan penulisan penelitian.

Daftar Pustaka : Daftar sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian, seperti wawancara atau observasi.

Data Sekunder : Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian.

Desain Penelitian : Rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Etika Penelitian : Prinsip moral yang mengatur pelaksanaan penelitian agar melindungi hak dan keselamatan responden.

Evidence-Based Nursing (EBN) : Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan preferensi pasien.

Hipotesis : Dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian.

Informed Consent : Persetujuan responden setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai penelitian.

Instrumen Penelitian : Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner atau lembar observasi.

Jurnal Ilmiah : Media publikasi yang memuat artikel hasil penelitian yang telah melalui proses review.

Kerangka Konsep : Gambaran hubungan antar variabel dalam penelitian yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram.

Kuesioner : Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data dari responden.

Latar Belakang : Bagian dalam karya ilmiah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan.

Metodologi Penelitian : Bagian yang menjelaskan cara atau metode yang digunakan dalam penelitian.

Originalitas Penelitian : Keaslian penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tidak merupakan hasil plagiarisme.
Parafrase : Penulisan kembali ide dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna.
Peer Review : Proses penilaian artikel ilmiah oleh ahli di bidang yang sama sebelum dipublikasikan.
Plagiarisme : Tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa mencantumkan sumber.
Populasi : Keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian.
Proposal Penelitian : Rencana penelitian yang disusun secara sistematis sebelum penelitian dilaksanakan.
Publikasi Ilmiah : Proses menyebarluaskan hasil penelitian melalui jurnal atau media ilmiah.
Rumusan Masalah : Pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian.
Sampling : Teknik pemilihan sebagian populasi sebagai sampel penelitian.
Sitasi : Cara mencantumkan sumber referensi dalam penulisan ilmiah.
Skripsi : Karya ilmiah hasil penelitian yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan.
Subjek Penelitian : Individu atau objek yang menjadi sumber data dalam penelitian.
Tinjauan Pustaka : Kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.
Variabel : Karakteristik atau faktor yang diteliti dalam penelitian.
Variabel Dependen : Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
Variabel Independen : Variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Referensi

Bailey, S. (2025). *Academic Writing A Handbook for International Students*. Routledge.

Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *The American Journal of Bioethics: AJOB*, *19*(11), 9–12. https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402

Belcher, W. L. (2019). *Writing Your Article in Twelve* (Second Edi). University of Chicago Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The Craft of Research* (Fourth Edi). The University of Chicago Press.

CIOMS. (2016). *International Ethical Guidelines for International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans*. the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches*. Sage Publications.

Day, R. A., & Gastel, B. (2012). *How to Write and Publish a Scientific Paper* (Seventh). Cambridge University Press.

Faden, R. R., & Beauchamp, T. L. (2016). *A History and Theory of Informed Consent*. Oxford University Press.

Gasparyan, A. Y., Ayvazyan, L., Blackmore, H., & Kitas, G. D. (2011). Writing a narrative biomedical review: considerations for authors, peer reviewers, and editors. *Rheumatology International*, *31*(11), 1409–1417. https://doi.org/10.1007/s00296-011-1999-3

Gastel, B., & Day, R. A. (2022). *How to Write and Publish a Scientific Paper* (Ninth Edit). Greenwood.

Gray, J. ., Grove, S. ., & Sutherland, S. (2017). *Burns & Grove's the Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence* (8th ed.). Elsevier.

Greenhalgh, T. M., & Dijkstra, P. (2024). *How to Read a Paper: the Basics of Evidence-Based Healthcare* (7th ed.). Wiley-Blackwell.

Grove, S., & Gray, J. (2019). *Understanding Nursing Research* (7th ed.). Elsevier.

Grove, S. K., & Gray, J. R. (2018). *Understanding Nursing Research Building an Evidence-Based Practice* (7th ed.). Elsevier.

Houser, J. (2023). *Nursing Research: Reading, Using, and Creating Evidence* (Fifth Edit). Jones & Bartlett Learning.

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (2021). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication*

of Scholarly Work in Medical Journals (Issue December, pp. 1–19). International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Lobiondo-wood, G., & Haber, J. (2022). *Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice* (NINETH EDI). Elsevier.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2015). *Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice* (Third edit). Wolters Kluwer Health.

Murray, R. (2005). *Writing for Academic Journals*. Open University Press.

Neville, C. (2012). *The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism*. Open University Press.

Parahoo, K. (2014). *Nursing research : principles, process and issues*. Palgrave Macmillan.

Pecorari, D. (2013). *Teaching to Avoid Plagiarism: How To Promote Good Source Use*. McGraw-Hill Education.

Polit, F. ., & Beck, C. . (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Ramia, J. M. (2023). *How to select a journal for your research*. *29*(21), 3379–3384. https://doi.org/10.3748/wjg.v29.i21.3379

Resnik, D. B. (2024). *The Ethics of Research with Human Subjects* (Second Edi). Springer New York LLC.

Roig, M. (2015). *Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing*. Department of Health & Human Services.

Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2015). *Responsible Conduct of Research* (Third Edit). Oxford University Press.

Silvia, P. J. (2015). *How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing*. American Psychological Association.

Wager, E., & Kleinert, S. (2010). Responsible research publication : international standards for authors. *A Position Statement Developed at the 2nd World Conference on Research Integrity.*, *2011*, 2–7.

Ware, M., & Mabe, M. (2015). *The STM Report: An Overview of Scientific and Scholarly Publishing* (Fourth Edi). International Association of STM Publishers.

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, *310*(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Profil Penulis



Nurafni Suid, S.Tr. Kep., Ns., M.Tr.Kep adalah seorang akademisi dan peneliti berdedikasi yang lahir di Gorontalo pada 22 September 1995. Langkah profesionalnya di dunia keperawatan dimulai sejak menempuh pendidikan Diploma IV Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, yang kemudian ia lengkapi dengan gelar profesi Ners serta Magister Keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Saat ini, ia aktif mendedikasikan ilmu dan kepakarannya sebagai dosen Program Studi Ners pada Departemen Keperawatan Medikal Bedah di STIKES Amanah Makassar. Di samping perannya di ruang kelas, penulis jug menaruh perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui aktivitas riset yang progresif dan program pengabdian masyarakat yang berdampak. Komitmennya dalam dunia akademik telah membuahkan berbagai publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Korespondensi dan kolaborasi lebih lanjut dengan penulis dapat terjalin melalui pos-email **:** **nurafnisuid@gmail.com**

Profil Penulis



Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep
lahir di Malaka pada 27 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang ditempuh diawali di Akademi Keperawatan Kupang dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) dan Profesi Ners (Ns.) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis kemudian meraih gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada tahun 2023.

Karier profesional penulis diawali sebagai perawat sekaligus dosen di Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (PAM-KT) Dili, Timor Timur, pada periode 1996–1998. Sejak bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Keperawatan dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners. Di samping aktivitas akademik, penulis aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, serta anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

Dalam bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Falsafah dan Teori Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan, Caring, Etika Keperawatan, Metodologi Penelitian, Evidence-Based Nursing, dan Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa pada penyusunan tugas akhir, karya ilmiah, dan penelitian di bidang keperawatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan book chapter di bidang keperawatan, menjadi narasumber dalam seminar, pelatihan, dan workshop ilmiah, serta berperan sebagai reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi pengembangan model praktik keperawatan berbasis caring, etik dan budaya,

pendidikan keperawatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian tuberkulosis, mutu dan keselamatan pasien di RS.
Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aemilianusmau58@gmail.com.
Motto: "Terus Belajar agar Ilmunya Dapat Bermanfaat bagi Banyak Orang"



Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep. adalah dosen pada Program Studi Diploma III Keperawatan, Fakultas Kesehatan di Universitas Salakanagara, dengan bidang keahlian Manajemen Keperawatan. Ia memulai pendidikan Sarjana Keperawatan pada tahun 2010 di UIN Alauddin Makassar dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di institusi yang sama pada tahun 2014. Pendidikan Magister Keperawatan diselesaikannya pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam kegiatan akademik, karya ilmiah, dan penelitiannya, saya berfokus pada manajemen pelayanan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan, dan keselamatan pasien. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, saya berkomitmen berkontribusi terhadap pengembangan praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Motto: Terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat.

Dr. Dyah Dwi Astuti, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.
merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners di Poltekkes Kemenkes Surakarta yang memiliki kepakaran di bidang Keperawatan Anak dan Keperawatan Neonatal. Beliau aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan penelitian di bayi risiko tinggi berbasis bukti ilmiah. Beliau menempuh



pendidikan Sarjana dan Profesi Ners di UGM, Magister dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia, dan Doktor Keperawatan di Universitas Indonesia. Selain menempuh pendidikan formal hingga jenjang doktoral, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan kompetensi akademik dan klinis di bidang keperawatan anak dan perawatan bayi di ruang intensif neonatal. Email:astutidyah83@gmail.com

Profil Penulis



Ns. Cut Sarida Pompey, S.Kep., M.N.S.

Seorang akademisi keperawatan, peneliti, dan *academic leader* dengan keahlian utama di bidang Keperawatan Medikal Bedah dan *Neuroscience Nursing Care, Nursing Education and Competencies*. Saat ini, terafiliasi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan pengalama sebagai Kepala Program Studi Profesi Ners dan Ketua Jurusan Keperawatan. Ns. Cut meraih gelar Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners dari Universitas Indonesia, serta gelar Magister of Nursing Science dari Prince of Songkla University, Thailand. Perjalanan karier profesionalnya dimulai sebagai perawat klinis di salah satu rumah sakit di Jakarta, sebelum mendedikasikan diri di dunia pendidikan sebagai dosen keperawatan di Universitas Esa Unggul dan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Dalam ranah darma perguruan tinggi, Ns. Cut Berfokus pada pengembangan keperawatan berbasis bukti, pendidikan klinis, dan penelitian di bidang perawatan keperawatan neurosain, pendidikan & kompetensi keperawatan, dan *Interprofessional Collaborative Practice* serta memiliki erpengalaman dalam pengembangan pembelajaran, penelitian terapan, dan penguatan kompetensi klinis mahasiswa keperawatan. publikasi ilmiah, dan kegiatan pelayanan masyarakat berdasarkan kebutuhan komunitas.

Profil Penulis



Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep, lahir di Sragen, 16 Mei 1981. Penulis menempuh pendidikan tinggi meraih gelar sarjana dan magister keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Penulis telah bekerja menjadi dosen selama 16 tahun dan saat ini aktif menjadi dosen Prodi Ners pada Departemen Keperawatan Anak di STIKES Notokusumo Yogyakarta. Selain menjadi dosen, penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian yang dilakukan selain mendapatkan dana dari hibah internal institusi, juga beberapa kali dana dari KEMENRISTEK DIKTI dan LLDIKTI Wilayah V. Hasil luaran yang didapatkan adalah publikasi baik di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional bereputasi serta HKI. Penulis juga aktif menjadi editor di Jurnal Keperawatan Notokusumo dan menjadi reviewer di International Journal of Developmental Disabilities serta Jurnal Cakrawala Promosi Kesehatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fika.nurindriasari@stikes-notokusumo.ac.id

Sinopsis

Buku Ajar *Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing* disusun sebagai bahan ajar yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar-dasar penelitian keperawatan dan penerapan praktik keperawatan berbasis bukti. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti pemula, dan praktisi keperawatan dalam memahami proses riset secara sistematis, mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penilaian bukti ilmiah, hingga implementasi hasil penelitian dalam praktik pelayanan keperawatan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan materi tentang instrumen penelitian dan pengukuran, yang mencakup prinsip penyusunan instrumen, validitas, reliabilitas, skala pengukuran, serta pentingnya ketepatan alat ukur dalam menghasilkan data yang bermutu. Selanjutnya, buku ini menguraikan prosedur pengumpulan data dan manajemen data, termasuk teknik pengumpulan data, etika pengumpulan informasi dari responden, pengkodean, penyimpanan, serta pengelolaan data agar siap dianalisis secara ilmiah.

Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan analisis data kuantitatif dasar yang meliputi konsep statistik deskriptif, pemilihan uji statistik sederhana, interpretasi hasil analisis, serta penyajian data penelitian secara tepat. Buku ini juga membahas critical appraisal dan hirarki bukti sebagai keterampilan penting dalam menilai kualitas artikel ilmiah, kekuatan bukti, serta relevansinya terhadap praktik keperawatan.

Selain membahas aspek metodologis, buku ini menekankan pentingnya implementasi *Evidence-Based Nursing* dalam praktik keperawatan. Materi ini membantu pembaca memahami bagaimana bukti ilmiah, pengalaman klinis, nilai pasien, dan konteks pelayanan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan keperawatan. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan panduan penyusunan proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah, sehingga pembaca memiliki gambaran utuh mengenai proses penulisan karya ilmiah yang sistematis, etis, dan sesuai kaidah akademik.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang aplikatif dan mudah dipahami dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, keterampilan riset, serta budaya praktik keperawatan berbasis bukti. Kehadiran buku ini diharapkan mampu mendukung lahirnya tenaga keperawatan yang kritis, profesional, dan mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan serta keselamatan pasien.

Buku Ajar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing disusun sebagai bahan ajar yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar-dasar penelitian keperawatan dan penerapan praktik keperawatan berbasis bukti. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti pemula, dan praktisi keperawatan dalam memahami proses riset secara sistematis, mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penilaian bukti ilmiah, hingga implementasi hasil penelitian dalam praktik pelayanan keperawatan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan materi tentang instrumen penelitian dan pengukuran, yang mencakup prinsip penyusunan instrumen, validitas, reliabilitas, skala pengukuran, serta pentingnya ketepatan alat ukur dalam menghasilkan data yang bermutu. Selanjutnya, buku ini menguraikan prosedur pengumpulan data dan manajemen data, termasuk teknik pengumpulan data, etika pengumpulan informasi dari responden, pengkodean, penyimpanan, serta pengelolaan data agar siap dianalisis secara ilmiah.

Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan analisis data kuantitatif dasar yang meliputi konsep statistik deskriptif, pemilihan uji statistik sederhana, interpretasi hasil analisis, serta penyajian data penelitian secara tepat. Buku ini juga membahas critical appraisal dan hirarki bukti sebagai keterampilan penting dalam menilai kualitas artikel ilmiah, kekuatan bukti, serta relevansinya terhadap praktik keperawatan.

Selain membahas aspek metodologis, buku ini menekankan pentingnya implementasi Evidence-Based Nursing dalam praktik keperawatan. Materi ini membantu pembaca memahami bagaimana bukti ilmiah, pengalaman klinis, nilai pasien, dan konteks pelayanan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan keperawatan. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan panduan penyusunan proposal, skripsi, dan publikasi ilmiah, sehingga pembaca memiliki gambaran utuh mengenai proses penulisan karya ilmiah yang sistematis, etis, dan sesuai kaidah akademik.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang aplikatif dan mudah dipahami dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, keterampilan riset, serta budaya praktik keperawatan berbasis bukti. Kehadiran buku ini diharapkan mampu mendukung lahirnya tenaga keperawatan yang kritis, profesional, dan mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan serta keselamatan pasien.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-01-9 (PDF)
9 786347 927019